BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HUỲNH ANH DŨNG

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ SỰ CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2018

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Mã số: 60.72.07.01

Hà Nội, 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HUỲNH ANH DŨNG

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ SỰ CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2018

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Mã số: 60.72.07.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. BS TRẦN THANH TÙNG

Hà Nội, 2018

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **i**
DANH MỤC BẢNG ..... **v**
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..... **vi**
BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT ..... **vii**
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..... **viii**
ĐẶT VẤN ĐỀ **1**
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU **2**
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU **3**
1.1. Một số khái niệm dùng trong nghiên cứu *3*
1.1.1. Khái niệm về bệnh viện *3*
1.1.2. Khái niệm về chăm sóc của điều dưỡng *3*
1.1.3. Khái niệm về chăm sóc người bệnh toàn diện *4*
1.1.4. Khái niệm về sự hài lòng của người bệnh *4*
1.1.5. Khái niệm về sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng *4*
1.2. Các học thuyết và nguyên lý cơ bản về chăm sóc điều dưỡng *5*
1.2.1. Học thuyết Florence Nightingale *5*
1.2.2. Học thuyết Virginia Henderson *6*
1.2.3. Các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng *7*
1.3. Quy trình điều dưỡng và vai trò, chức năng của người điều dưỡng *8*
1.3.1. Quy trình điều dưỡng *8*
1.3.2. Đánh giá công tác chăm sóc của điều dưỡng ... ***Error! Bookmark not defined.***

1.3.3. Vai trò của người điều dưỡng.....9

*1.3.4. Chức năng của người điều dưỡng .....**Error! Bookmark not defined.***

1.4. Sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng 10

1.4.1. Sự cần thiết của việc đánh giá sự hài lòng 10

1.4.2. Một số công cụ đánh giá sự hài lòng của người bệnh 11

1.4.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng.....14

1.5. Các kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh với chất lượng chăm sóc của điều dưỡng.....16

1.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới 16

1.5.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam.....17

1.6. Giới thiệu Khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy.....21

1.7. Khung lý thuyết của nghiên cứu 22

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....27

2.1. Đối tượng nghiên cứu.....27

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 27

2.3. Thiết kế nghiên cứu 27

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu.....27

2.4.1. Nghiên cứu định lượng.....27

2.4.2. Nghiên cứu định tính 28

2.5. Phương pháp thu thập số liệu.....28

2.5.1. Các bước thu thập số liệu.....28

2.5.2. Công cụ thu thập số liệu.....29

2.6. Phương pháp phân tích số liệu *30*

2.6.1. Xử lý khi thu thập số liệu *30*

2.6.2. Phân tích số liệu *30*

2.7. Biến số nghiên cứu *32*

Chăm sóc tinh thần cho người bệnh *32*

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu *33*

2.9. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số *33*

2.9.1. Hạn chế của nghiên cứu *33*

2.9.2. Biện pháp khắc phục *34*

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU **35**

3.1. Một số thông tin chung về đối tượng nghiên cứu *35*

3.2. Hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng chăm sóc điều dưỡng *39*

3.2.1. Hài lòng của người bệnh về sự chăm sóc tinh thần 39

3.2.2. Hài lòng của NB về thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng 42

3.2.3. Hài lòng của NB về mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng 46

3.2.4. Hài lòng của NB về việc tư vấn và giáo dục sức khỏe của điều dưỡng 49

3.2.5. Tỷ lệ hài lòng của NB theo từng yếu tố hài lòng 53

3.2.6. Sự hài lòng chung của người bệnh *54*

3.3. Một số yếu tố liên quan tới sự hài lòng chung của người bệnh *55*

Chương 4. BÀN LUẬN **58**

4.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu *58*

4.2. Sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng *60*

4.2.1. Sự hài lòng của người bệnh về yếu tố chăm sóc tinh thần 60

4.2.2. Sự hài lòng của người bệnh về thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng 61

4.2.3. Sự hài lòng của người bệnh về yếu tố mối quan hệ với điều dưỡng 63

4.2.4. Sự hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong thời gian điều trị và sau khi ra viện.....64
4.2.5. Sự hài lòng chung của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng.....67
4.3. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng 67
4.3.1. Các yếu tố nhân khẩu, xã hội học của người bệnh.....67
4.3.2. Phân tích hồi quy logistic về các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung.....69
KẾT LUẬN.....70
KHUYẾN NGHỊ.....71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
Phụ lục 1. Giấy đồng ý tham gia nghiên cứu.....75
Phụ lục 2: Bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng của người bệnh.....76
Phụ lục 3. Hướng dẫn phỏng vấn sâu Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học 82
Phụ lục 4: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng/ Phó khoa Huyết học.....84
Phụ lục 5. Hướng dẫn phỏng vấn sâu điều dưỡng chăm sóc.....86
Phụ lục 6. Hướng dẫn phỏng vấn sâu người bệnh nội trú.....88
Phụ lục 7: Biến số nghiên cứu 90

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu.....35
Bảng 3.2. Thông tin về lần nhập viện này của ĐTNC.....37
Bảng 3.3. Hài lòng của người bệnh về sự chăm sóc tinh thần (n=299) 39
Bảng 3.4. Hài lòng của NB về thực hiện hoạt động chăm sóc ĐD (n=299) 42
Bảng 3.5. Thời gian người bệnh phải chờ đợi 45
Bảng 3.6. Hài lòng của NB về mối quan hệ giữa NB và ĐD (n=299).....46
Bảng 3.7. Hài lòng của NB về việc tư vấn và GDSK của ĐD (n=299) 49
Bảng 3.8. Bảng tổng hợp sự hài lòng của NB theo từng yếu tố (n=299) 53
Bảng 3.9. Sự hài lòng chung của người bệnh (n=299) 54
Bảng 3.10. Mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng chung....55
Bảng 3.12. Mối liên quan giữa các đặc điểm y tế với sự hài lòng chung (n=299)...56
Bảng 3.12. Phân tích hồi quy Logistic đa biến các yếu tố 57
liên quan đến sự hài lòng chung (n = 299) 57

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ phân bố theo bệnh lý của ĐTNC.....38
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ hài lòng người bệnh về chăm sóc tinh thần của điều dưỡng.....40
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh về thực hiện hoạt động CSĐD 44
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh về mối quan hệ NB và ĐD.....47
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh về tư vấn và GDSK.....50
Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh NB ở từng nhóm hoạt động.....53
Biểu đồ 3.7. Phân bố điểm hài lòng chung của người bệnh ... **Error! Bookmark not defined.**
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh 54

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT

BS	Bác sĩ
BHYT	Bảo hiểm Y tế
BVCR	Bệnh viện Chợ Rẫy
BVĐK	Bệnh viện Đa khoa
CLS	Cận lâm sàng
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
CSĐD	Chăm sóc điều dưỡng
CSNB	Chăm sóc người bệnh
CSSK	Chăm sóc sức khỏe
ĐD	Điều dưỡng
ĐTNC	Đối tượng nghiên cứu
GDSK	Giáo dục sức khỏe
HIV	Human Immunodeficiency Virus
NB	Người bệnh
NNNB	Người nhà người bệnh
NSNS	Newcatsle Satisfaction with Nursing Scale Thang đo sự hài lòng về chăm sóc điều dưỡng
TP	Thành phố
YHCT	Y học cổ truyền
WHO	World Health Organization Tổ chức Y tế thế giới

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định để nâng cao chất lượng điều trị phải quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dịch vụ chăm sóc điều dưỡng (CSĐD). Vấn đề này được bệnh viện Chợ Rẫy hết sức quan tâm. Nhằm tìm hiểu sự hài lòng của người bệnh (NB) về công tác chăm sóc điều dưỡng (ĐD) tại Khoa Huyết học và những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.

Thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích, phương pháp định lượng kết hợp với định tính, được tiến hành tại Khoa Huyết học. Đối tượng nghiên cứu định lượng là 299 NB nội trú được chọn qua chọn mẫu toàn bộ. Ở cấu phần định tính, thực hiện 13 cuộc phỏng vấn sâu NB nội trú, cán bộ quản lý khoa, điều dưỡng viên. Nghiên cứu sử dụng các phân tích thống kê mô tả, kiểm định χ^2 và mô hình hồi quy Logistic. Thời gian nghiên cứu từ 01/2018 đến 06/2018. Các biến số chính về đặc điểm nhân khẩu học, sự hài lòng của NB qua 28 tiểu mục thuộc 4 nhóm yếu tố: chăm sóc tinh thần cho NB, thực hiện hoạt động CSĐD, mối quan hệ giữa NB và ĐD và hoạt động tư vấn và giáo dục sức khỏe.

Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng chung của NB về công tác CSĐD là 44,5%. Trong đó, tỷ lệ hài lòng về chăm sóc tinh thần là 52,2%; thực hiện hoạt động chăm sóc của ĐD là 51,5%; mối quan hệ giữa NB và ĐD là 53,2%; về tư vấn và giáo dục sức khỏe là 53,8%. Phân tích mối liên quan chỉ rõ, sự hài lòng của NB có liên quan đến các yếu tố kinh tế hộ gia đình (OR=1,66; 95%CI: 1,01-2,74; p=0,04), tình trạng mắc bệnh (OR=1,62; 95%CI: 1,02-2,58; p=0,04) và số lần vào viện trong 12 tháng gần đây (OR=2,05; 95%CI: 1,18-3,56; p=0,01). Phân tích hồi quy logistic cho thấy những NB thuộc diện hộ nghèo có xu hướng hài lòng hơn gấp 1,71 lần so với những NB không thuộc diện hộ nghèo (p=0,039) và nhóm những NB có số lần nhập viện điều trị trên 2 lần trong năm có xu hướng hài lòng hơn gấp 2,01 lần so với những NB mới vào viện từ 1 đến 2 lần (p=0,014).

Khuyến nghị: nghiên cứu cho thấy ĐD cần cải thiện kỹ năng giao tiếp với NB bên cạnh việc trau dồi chuyên môn. Bệnh viện Chợ Rẫy cần nhanh chóng bổ sung nhân lực cho khoa huyết học, nhất là cán bộ làm công việc hành chính.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tổ chức Y tế thế giới cũng đã nhận định dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng viên cung cấp là một trong các trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phải quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ CSĐD [12]. Thực hiện tốt công tác CSĐD sẽ giảm được thời gian nằm viện, chi phí điều trị, nguy cơ biến chứng và đẩy mạnh quá trình hồi phục.

Tại Việt Nam, vai trò của điều dưỡng gần đây đã có sự thay đổi tích cực thể hiện qua các chính sách về điều dưỡng viên, các chuẩn mực về hành nghề điều dưỡng, sự đổi mới các mô hình phân công chăm sóc, tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện, chuẩn hóa các kỹ thuật điều dưỡng. Tại các bệnh viện đã triển khai thông tư 07/2011/TT - BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về: "Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện", trong đó quy định rõ: "*Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn"* [7].

Tại những bệnh viện có bệnh nhân mắc bệnh nan y, cần điều trị nội trú dài ngày, liệu trình phức tạp như các trung tâm ung bướu, các bệnh viện huyết học – truyền máu thì vai trò hỗ trợ bác sĩ, thực hiện chính xác y lệnh và nâng đỡ người bệnh của điều dưỡng càng trở nên cấp thiết. Là đơn vị tuyến cuối về chuyên khoa huyết học – truyền máu tại khu vực phía Nam, khoa Huyết học – bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày có khoảng 200 lượt NB nội trú và ngoại trú đến khám và điều trị [2]. Với lượng NB nội trú đông và đa số là mắc bệnh nặng, nhiều NB đang điều trị giai đoạn cuối, khối lượng công việc của điều dưỡng tại khoa là rất lớn. Do đó, việc đảm bảo sự hài lòng cho tất cả NB là vấn đề không đơn giản. Mặc dù đã có khá nhiều nghiên cứu về sự hài lòng về công tác CSĐD nhưng đa số được thực hiện tại các bệnh viện đa khoa; chính vì vậy nghiên cứu tại một đơn vị chuyên biệt như khoa Huyết học vẫn rất cần thiết. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài: ***"Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Huyết học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018"*** nhằm có căn cứ khoa học cho các hoạt động can thiệp cải thiện sự hài lòng của người bệnh tại khoa trong thời gian tới.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nội trú với công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Một số khái niệm dùng trong nghiên cứu

1.1.1. Khái niệm về bệnh viện

Theo định nghĩa của WHO: "Bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời của một tổ chức xã hội và y tế, chức năng của nó là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, cả phòng bệnh và chữa bệnh, dịch vụ ngoại trú của bệnh viện phải vươn tới cả gia đình và môi trường cư trú. Bệnh viện còn là trung tâm đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu sinh học xã hội" [17].

- Bệnh viện là một tổ chức động bao gồm đầu vào là NB, cán bộ y tế, trang thiết bị, thuốc cần có để chẩn đoán, điều trị. Đầu ra là NB khỏi bệnh ra viện hoặc phục hồi sức khỏe hoặc NB tử vong [23].

1.1.2. Khái niệm về chăm sóc của điều dưỡng

Điều dưỡng viên là đội ngũ cán bộ chuyên môn có số lượng nhiều nhất trong bệnh viện, nên có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của mọi bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh. WHO đã nhận định dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng viên và hộ sinh viên cung cấp là một trong các trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phải quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng (CSĐD) [12].

Như vậy, CSĐD là sự đáp ứng của điều dưỡng về các nhu cầu thể chất, tinh thần, cảm xúc, xã hội và tâm hồn của NB. Các nhu cầu đó được cung cấp sao cho NB được chữa khỏi bệnh, khỏe mạnh, sống cuộc sống bình thường để cả điều dưỡng và NB đều hài lòng [40].

Chất lượng dịch vụ CSĐD ở bệnh viện công được xác định bởi tất cả những dịch vụ được cung cấp cho khách hàng và đặc tính của từng dịch vụ. Mục tiêu của CSĐD là hướng tới sự đáp ứng các nhu cầu cao của khách hàng với chất lượng tập trung vào tính hợp lý, tính công bằng, các quy trình kỹ thuật và hiệu quả đầu ra [50].

1.1.3. Khái niệm về chăm sóc người bệnh toàn diện

Chăm sóc người bệnh toàn diện là sự chăm sóc, theo dõi và điều trị của bác sĩ và điều dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất và tinh thần trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện [4]

1.1.4. Khái niệm về sự hài lòng của người bệnh

- Sự hài lòng của NB là: "Khi các dịch vụ y tế đáp ứng những mong đợi của người bệnh/khách hàng trong quá trình điều trị". Khái niệm này cho rằng sự hài lòng chỉ tập trung trên các dịch vụ điều trị [47].

- Sự hài lòng của NB là một thái độ hướng tới một trải nghiệm về chăm sóc sức khỏe [33]. Khái niệm này nhấn mạnh khía cạnh tâm lý của người bệnh, điều này phụ thuộc vào tâm trạng NB tại thời điểm điều tra.

- Sự hài lòng của NB được xem là phần không thể thiếu của chất lượng chăm sóc sức khỏe [43].

Trong nghiên cứu này sự hài lòng của người bệnh được hiểu là đánh giá của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng đã nhận được so với dự kiến mà họ mong đợi trong suốt quá trình điều trị nội trú.

1.1.5. Khái niệm về sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng

Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe hiện nay, sự hài lòng của NB là một chỉ số quan trọng đối với chất lượng chăm sóc bởi:

- Sự hài lòng của NB cho biết quan điểm của NB đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe/ dịch vụ y tế, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của NB và xem xét dựa trên quan điểm của họ. Sự hài lòng càng cao thì khả năng tuân thủ điều trị và chấp nhận ý kiến tư vấn từ cán bộ y tế càng cao, khả năng sẽ quay trở lại cao hơn khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng giới thiệu cơ sở y tế đó cho người thân [38].

Tại các nước, ngành điều dưỡng phát triển rất mạnh và là nơi đào tạo về chuyên ngành này. Tại Thái Lan, ĐD đạt tiêu chuẩn đào tạo của thế giới và tất cả các dịch vụ điều dưỡng đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế; thực hiện theo bộ tiêu

chuẩn của Phòng Điều dưỡng. Chuẩn mực CSĐD trong bệnh viện sẽ đảm bảo nếu bao gồm các tiêu chí:

(1) Ý kiến về quan điểm của bệnh nhân: Tiếp nhận thông tin y tế; Bệnh nhân thấy thoải mái khi điều trị tại khoa, phòng; Điều dưỡng có kỹ năng tốt; Điều dưỡng làm giảm đau hoặc các triệu chứng bất thường của NB tốt;

(2) 100% NB tuân thủ theo hướng dẫn của điều dưỡng;

(3) Tỷ lệ NB hài lòng với công tác chăm sóc của điều dưỡng ≥ 80% [46].

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại các bệnh viện được quan tâm; tinh thần phục vụ người bệnh của điều dưỡng có nhiều chuyển biến tích cực xoay quanh các nhóm yếu tố chính: chăm sóc và hỗ trợ về tinh thần cho NB, thực hiện tốt công tác chuyên môn, kỹ thuật điều dưỡng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa NB và điều dưỡng, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho NB trong suốt quá trình nằm viện và sau khi ra viện.

1.2. Các học thuyết và nguyên lý cơ bản về chăm sóc điều dưỡng

1.2.1. Học thuyết Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820-1910) là người sáng lập ra ngành điều dưỡng. Bà đã trở thành người điều hành và tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho những người nghèo khổ tại thủ đô nước Anh, sắp xếp hợp lý và đưa ra các tiêu chuẩn cho công tác ĐD [14]. Florence Nightingale đã thành lập trường đào tạo ĐD đầu tiên trên thế giới ở nước Anh vào năm 1860. Nhà trường cùng với chương trình đào tạo một năm đã đặt nền tảng cho hệ thống đào tạo ĐD không chỉ ở Vương Quốc Anh mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới [13].

Florence Nightingale đã đưa ra khung thực hành điều dưỡng. Bà nhìn nhận vai trò của người điều dưỡng không chỉ đơn thuần là cho NB dùng thuốc mà định hướng vào việc tác động tới môi trường để giúp đỡ NB mau chóng hồi phục. Các yếu tố đó là:

+ Không khí trong lành

+ Ánh sáng

+ Sự ấm áp của buồng bệnh

+ Sự sạch sẽ nơi buồng bệnh và giường bệnh

+ Sự yên tĩnh của buồng bệnh và bệnh viện

+ Dinh dưỡng cho NB đầy đủ [57].

1.2.2. Học thuyết Virginia Henderson

Học thuyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng sự độc lập của NB cho đến khi có thể tiến triển sau thời gian nằm viện. Sự hỗ trợ trong các hoạt động cá nhân nhằm giúp lấy lại sự độc lập của NB trong thực hiện các hoạt động hàng ngày góp phần gia tăng và phục hồi sức khỏe. Học thuyết tập trung vào 4 khía cạnh lớn về cá nhân, môi trường, sức khỏe và sự chăm sóc. Theo học thuyết, các hoạt động ĐD được chia làm 14 phần dựa vào các nhu cầu của con người. Từ 14 nhu cầu này đã giúp chúng ta xác định khung nội dung về thực hành điều dưỡng. Khi làm việc, người ĐD cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản này:

+ Đáp ứng nhu cầu về hô hấp

+ Đáp ứng nhu cầu về ăn uống

+ Giúp đỡ NB trong quá trình bài tiết

+ Giúp đỡ NB về tư thế trong vận động, tập luyện

+ Đáp ứng nhu cầu ngủ và nghỉ

+ Giúp NB mặc và thay quần áo

+ Giúp NB duy trì thân nhiệt

+ Giúp NB vệ sinh cá nhân hàng ngày

+ Giúp NB tránh được các nguy hiểm trong khi nằm viện

+ Giúp NB trong sự giao tiếp

+ Giúp NB thoải mái về tinh thần, tự do tín ngưỡng

+ Giúp NB lao động, làm một việc gì đó để tránh mặc cảm là người vô dụng

+ Giúp NB trong những hoạt động vui chơi giải trí

+ Giúp NB có kiến thức về y học [5] [25].

Học thuyết Virginia Henderson gợi ý cho người điều dưỡng khi tiếp cận với người bệnh cần phải đánh giá và xác định những nhu cầu của họ, trên cơ sở đó hỗ trợ họ đáp ứng được các nhu cầu cơ bản. Trên đây là một số lý thuyết ban đầu đặt nền móng cho công tác ĐD, mô tả những nội dung và yêu cầu cơ bản của nghề ĐD. Những lý thuyết này chưa thực sự trình bày về sự hài lòng của người bệnh nhưng về tư tưởng đã thể hiện sự quan tâm đến vai trò của ĐD nhằm đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Đây chính là yếu tố nền tảng góp phần tạo nên sự hài lòng của người bệnh.

Ngày nay trên thế giới, ngành điều dưỡng là một ngành riêng, có nhiều trình độ từ trung cấp đến sau đại học. Nhân lực điều dưỡng được tăng cường đào tạo, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế [19].

1.2.3. Các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng

Người ĐD có 04 trách nhiệm cơ bản: nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe và làm giảm bớt đau đớn cho NB [1].

Trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp của người ĐD đối với NB: chăm sóc cơ bản đối với những người cần tới sự chăm sóc. Trong quá trình chăm sóc, người ĐD cần tạo ra môi trường trong đó quyền con người, các giá trị tập quán, tín ngưỡng của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng được tôn trọng. Người ĐD cần đảm bảo cho mọi cá thể nhận được các thông tin cần thiết, làm cơ sở để họ chấp nhận các phương pháp điều trị và chăm sóc. Người ĐD giữ kín các thông tin về đời tư của người mà mình chăm sóc đồng thời phải xem xét một cách thận trọng khi chia sẻ các thông tin này với người khác. Trách nhiệm nghề nghiệp của người ĐD đối với NB phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau đây:

+ Không bao giờ được từ chối giúp đỡ NB

+ Giúp đỡ NB loại bỏ các đau đớn về thể chất

+ Không bao giờ được bỏ mặc NB

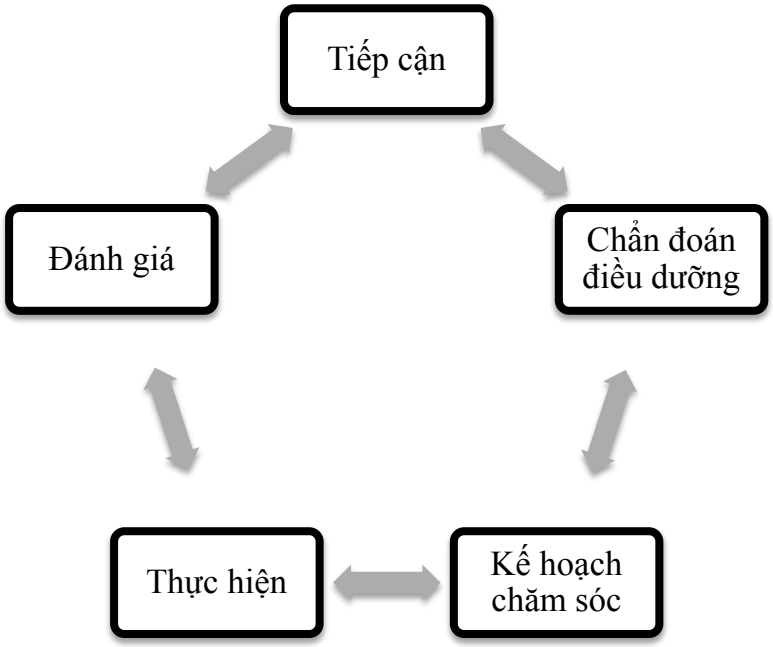
+ Tôn trọng nhân cách và quyền của con người

+ Hỗ trợ về tinh thần cho NB [1].

1.3. Quy trình điều dưỡng và vai trò, chức năng của người điều dưỡng

1.3.1. Quy trình điều dưỡng

Quy trình điều dưỡng được Lydia Hall công bố lần đầu tiên vào 1955 trên một bài báo khoa học, sau đó Johnson (1959), Orlando (1961) và Wiedenbach (1963) là những người đầu tiên đưa vào sử dụng. Quy trình điều dưỡng là phương pháp khoa học được áp dụng trong lĩnh vực điều dưỡng để thực hiện chăm sóc người bệnh có hệ thống bảo đảm liên tục, an toàn và hiệu quả bao gồm: Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc điều dưỡng [7]. Quy trình này gồm 5 bước như hình vẽ dưới đây:



Sơ đồ 1.1. Quy trình điều dưỡng [55]

Quy trình chăm sóc của ĐD bắt đầu từ khi tiếp nhận bệnh nhân cho đến lúc bệnh nhân ra viện, bao gồm: Chăm sóc thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, theo dõi, phục hồi chức năng, giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Do đó, nghiên cứu về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng là vấn đề quan trọng trong các hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.

Theo Donabedian, công tác chăm sóc điều dưỡng được đánh giá dựa trên 03 nhóm chỉ số: chỉ số cấu trúc, chỉ số quy trình và chỉ số kết quả đầu ra [34]:

- Chỉ số cấu trúc: Tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất như điều kiện và cơ chế cần thiết để vận hành tổ chức hay đơn vị, bao gồm những quy định về tổ chức quản lý, tổ chức phục vụ chăm sóc, đầu tư tài chính, phương tiện chăm sóc. Những nội dung của nhóm tiêu chuẩn này là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng chăm sóc tốt và có ảnh hưởng gián tiếp tới chất lượng chăm sóc.

- Chỉ số quy trình: Tập trung vào thực hành và cách thức thực hiện chăm sóc của điều dưỡng. Các chăm sóc này liên quan tới những nhu cầu của NB. Đây là cách hiệu quả nhất để xác định chất lượng chăm sóc. Các CSĐD được đánh giá bởi NB, NB ghi lại và quan sát các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng.

- Chỉ số hiệu quả đầu ra: Tập trung vào kết quả tình trạng sức khỏe của NB, sự hài lòng và kết quả của chăm sóc làm NB hồi phục. Những hiệu quả này dễ quan sát, đặc biệt là liên quan đến chăm sóc và sử dụng thuốc để điều trị bệnh. Hiệu quả chăm sóc điều dưỡng rất khó để xác định bởi vì CSĐD bao gồm cả hiệu quả về xã hội và hành vi cư xử. Chỉ số hiệu quả chăm sóc thường tập trung vào: Sự thay đổi hành vi của NB hướng tới mục tiêu khi xuất viện thể hiện NB hiểu biết về bệnh tật của họ, biết cách tự chăm sóc tự phòng bệnh, có những biểu hiện tiến bộ hơn liên quan đến sức khỏe so với lúc nhập viện. Sự ghi nhận của NB khi xuất viện làm cơ sở để chứng minh sự hoàn thành mục tiêu chăm sóc đã đề ra.

Trong nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là NB, vì vậy chúng tôi loại trừ những câu hỏi liên quan đến các tiêu chuẩn cấu trúc đối với NB.

1.3.2. Vai trò, chức năng của người điều dưỡng

Vai trò và chức năng của người điều dưỡng chủ yếu gồm [1]:

+ ***Chăm sóc:*** với mục tiêu thúc đẩy sự giao tiếp, hỗ trợ NB qua hành động và thái độ biểu thị sự quan tâm tới lợi ích của NB. Theo Benner và Wrubel thì "Chăm sóc là yếu tố cơ bản để thực hành điều dưỡng hiệu quả". Trong bệnh viện, mọi máy móc và kỹ thuật hiện đại không thay thế được sự chăm sóc của người điều dưỡng vì các thiết bị này sẽ không tác động được tới cảm xúc và điều chỉnh hành động cho thích ứng với những nhu cầu đa dạng của mỗi NB. Chăm sóc là nền tảng của mọi can thiệp điều dưỡng và là một thuộc tính cơ bản của người điều dưỡng [6].

+ ***Truyền đạt thông tin***: Thông tin có hiệu quả là yếu tố thiết yếu của nghề điều dưỡng. Hoạt động giao tiếp có vai trò quyết định trong xây dựng mối quan hệ giữa NB và điều dưỡng, giữa điều dưỡng và các nhân viên y tế khác. Giao tiếp hỗ trợ cho mọi can thiệp điều dưỡng [6].

+ ***Tư vấn:*** Tư vấn nhằm giúp người bệnh nhận biết và đương đầu với những căng thẳng về tâm lý, những vấn đề xã hội liên quan tới bệnh tật. Người điều dưỡng khuyến khích NB tìm kiếm những hành vi thay thế, cung cấp sự lựa chọn và xây dựng ý thức tự kiểm soát bản thân NB trong quá trình điều trị và sau khi ra viện [6].

+ ***Biện hộ cho người bệnh:*** là hành động thay mặt hoặc bảo vệ quyền lợi cho NB, giúp thúc đẩy những hành động tốt đẹp nhất của NB và bảo đảm cho những nhu cầu của người bệnh được đáp ứng [6].

+ ***Giáo viên:*** trong bệnh viện, vai trò giảng dạy của điều dưỡng cho học sinh thực tập là khá quan trọng. Ngoài ra điều dưỡng còn có nhiệm vụ truyền đạt những kiến thức, thông tin mới thu nhận được qua tập huấn/ hội thảo cho đồng nghiệp.

Ngoài ra, một số điều dưỡng còn đảm nhiệm công tác lãnh đạo, quản lý, làm công tác nghiên cứu khoa học.

1.4. Sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng

1.4.1. Sự cần thiết của việc đánh giá sự hài lòng

Lợi ích của việc thực hiện các nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của NB là nó cho NB có cơ hội được đánh giá và nói lên ý kiến của họ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ nhận được [1]. Qua thông tin về sự hài lòng người bệnh còn giúp xây dựng các chính sách y tế nhằm giải quyết các vấn đề cần cải thiện như: thái độ giao tiếp, giáo dục sức khỏe, những vấn đề chất lượng trong chăm sóc, quy trình khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, biết được sự hài lòng của NB để đáp ứng nhu cầu, mong muốn của họ [1].

Sự hài lòng của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà còn phụ thuộc vào sự mong đợi của khách hàng và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên việc hiểu biết các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của NB là rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cụ thể là dịch vụ điều dưỡng [1].

1.4.2. Một số công cụ đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Sự hài lòng của NB về công tác CSĐD có thể được đánh giá bằng khá nhiều phương pháp, cả định lượng và định tính. Tuy nhiên phương pháp định lượng thường được chọn hơn bởi không cần chi phí lớn, dễ dàng để thống kê và thường được cho là có tính chính xác cao hơn. Sau đây là một số công cụ định lượng thường được áp dụng trên thế giới.

- **Bộ công cụ MISS**

Một trong những công cụ đầu tiên được đề xuất để đánh giá sự hài lòng của người bệnh là MISS (Medical Interview Satisfaction Scale) và PSS (Patient Satisfaction Scale) do Linder-Pelz và cộng sự đề xuất với các câu hỏi được xây dựng bởi Osterweis và Howell [51] [56]. MISS với thang đo gồm 29 tiểu mục có thể được xem là công cụ đánh giá sự hài lòng một cách có hệ thống đầu tiên được xây dựng. PSS là bộ công cụ với 25 tiểu mục đo lường sự hài lòng chung, hài lòng với chất lượng chăm sóc, hài lòng về giao tiếp giữa nhân viên y tế và người bệnh, hài lòng về các kỹ thuật y tế [51]. Sau đó, nhiều công cụ khác nhau lần lượt được công bố dựa trên nền tảng là PSS. Dữ liệu có thể được thu thập qua thư, điện thoại hoặc phỏng vấn trực tiếp. Sự hài lòng được đánh giá bằng thang đo Likert 5 mức độ từ rất đồng ý đến không đồng ý với những quan điểm về bác sĩ và dịch vụ y tế [56]. Phương pháp do Osterweis và Howell đề xuất đơn giản hơn bằng cách liệt kê một loạt các dịch vụ y tế do bệnh viện cung cấp và người bệnh sẽ đánh giá các dịch vụ này theo các mức độ từ rất hài lòng đến rất không hài lòng [56].

Do tính chất đặc thù của từng chuyên khoa điều trị mà các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá sự hài lòng cũng được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, chúng thường xoay quanh các chủ đề chính sau: giao tiếp giữa NB và điều dưỡng khi nhập viện, giao tiếp giữa NB và điều dưỡng trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, vấn đề kiểm soát cơn đau/ giảm đau, sự thuận tiện/ phù hợp của các dịch vụ y tế tại bệnh viện, nỗ lực của nhân viên y tế và cuối cùng là tư vấn khi xuất viện [32]. Với công cụ này, ở bước đầu tiên Elisa Carretta phân chia câu trả lời của người bệnh theo thang Likert 3 mức độ gồm: Dịch vụ/ Hoạt động y tế chưa đáp ứng nhu cầu của NB,

đáp ứng nhu cầu NB và vượt quá mong đợi của NB. Ở bước 2, những người cho rằng chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi sẽ được đề nghị đánh giá mức độ chưa đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi bằng thang Likert 5 điểm (1: không quan trọng đến 5: quan trọng) [32].

- **Thang đo sự hài lòng Newcastle**

Năm 1996, Lois H. Thomas và cộng sự giới thiệu thang đo sự hài lòng về công tác chăm sóc điều dưỡng Newcastle – NSNS (Newcatsle Satisfaction with Nursing Scales) [54]. Tác giả chia bộ công cụ thành ba phần:

(1) Đánh giá điều dưỡng thông qua những trải nghiệm thực tế điều trị tại bệnh viện qua thang đo Likert 07 mức độ (Cực kỳ không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý): *ĐD cung cấp thông tin chỉ khi NB cần; ĐD thường bỏ đi và quên mất yêu cầu của NB; ĐD thường xuyên quay lại để kiểm tra tình trạng NB; ĐD thường không để tâm những đồng nghiệp của mình đã làm đến đâu rồi*;

(2) Đánh giá sự hài lòng của NB về công tác ĐD qua thang đo Likert 05 mức độ (Không hài lòng đến hoàn toàn hài lòng): *ĐD hiểu rõ những mối quan tâm của NB; ĐD sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của NB; ĐD xuất hiện nhanh chóng để hỗ trợ NB khi được mời;*

(3) Đặc điểm nhân khẩu học của NB: thông tin về NB và quá trình nằm viện.

Thang đo NSNS đã được chứng minh là có đủ độ tin cậy thông qua chỉ số Cronbach's α là 0,91 đối với thang đo trải nghiệm thực tế và 0,96 đối với thang đo sự hài lòng [54].

- **Bộ công cụ HCAHPS**

Một công cụ dùng để khảo sát mức độ hài lòng của NB về hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, cụ thể là công tác chăm sóc của ĐD và khám chữa bệnh của các bác sĩ là HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems Survey) [36]. Đây là một bộ công cụ đã được chuẩn hóa và được sử dụng từ năm 2006 đến nay bởi Cơ quan Nghiên cứu và Quản lý chất lượng chăm sóc sức khỏe thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi đa số các bệnh viện thu thập thông tin về sự hài lòng của NB thì HCAHPS tạo ra một tiêu chuẩn quốc gia cho việc thu thập và công bố các thông tin đó cho cộng đồng, từ đó khách hàng hoặc NB dễ dàng có sự đánh

giá và ra quyết định chọn lựa cơ sở y tế để điều trị. Quy trình chọn mẫu được thiết kế để tạo ra sự đồng nhất giữa các bệnh viện, từ đó dữ liệu từ các bệnh viện có thể được so sánh một cách dễ dàng. Việc liên tục công bố kết quả khảo sát ra cộng đồng tạo động lực thúc đẩy các bệnh viện tích cực cải tiến quy trình, năng lực, chất lượng phục vụ. Ngoài ra, thông tin khảo sát chính là cơ sở để xây dựng chính sách y tế.

Bộ công cụ khảo sát HCAHPS được biên soạn với 27 câu hỏi. Ở 18 câu đầu tập trung đánh giá trải nghiệm của NB sau quá trình điều trị. Phần này đưa ra các chuẩn mực về khám bệnh của bác sĩ, chăm sóc của điều dưỡng, vệ sinh môi trường bệnh viện sạch sẽ, yên tĩnh, hướng dẫn dùng thuốc, tư vấn giáo dục sức khỏe khi đang điều trị và NB sẽ đưa ra cảm nhận của mình theo thang đo Likert 04 mức độ *(Không bao giờ, thỉnh thoảng, thường thường, luôn luôn)*. 04 câu hỏi tiếp theo tìm hiểu về việc liệu NB đã được tư vấn đầy đủ về các liệu pháp điều trị cũng như các loại thuốc sử dụng hành ngày tại nhà ra sao. Những câu hỏi cuối khai thác về đặc điểm nhân khẩu – xã hội học của NB.

- **Bộ câu hỏi PSNCQQ**

PSNCQQ (Patient Satisfaction with Nursing Care Quality Questionnaire) do Heather K. Spence Laschinger giới thiệu lần đầu năm 2005 [42]. Mục tiêu là để NB thể hiện quan điểm của mình về các dịch vụ y tế được cung cấp tại bệnh viện. Công cụ hỏi về 19 chủ đề: công tác điều dưỡng và chăm sóc hàng ngày, nhân viên hộ lý và môi trường bệnh viện, chăm sóc y tế, thông tin, nhập viện, xuất viện và thanh toán, chất lượng chăm sóc tổng thể, khuyến nghị và ý định và cuối cùng là tình hình sức khỏe sau điều trị. Các hệ số đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach‘s α khá cao, dao động từ 0,90 đến 0,94. Sau đó có 3 câu hỏi được thiết kế để đo lường sự hài lòng với chất lượng chăm sóc tổng thể trong thời gian nằm viện, chất lượng chăm sóc điều dưỡng tổng thể và ý định giới thiệu bệnh viện cho gia đình và bạn bè. Đánh giá của NB được thể hiện qua thang đo Likert 05 mức độ. Năm 2012, Milutinovic đã chuyển ngữ bộ công cụ này sang tiếng Serbia và áp dụng tại khoa ngoại bệnh viện Vojvodina ở thành phố Novi Sad. Với 240 NB được mời tham gia, bộ công cụ được chứng minh là đáng tin cậy với chỉ số Cronbach‘s α đạt mức 0,94. Ngoài ra,

nghiên cứu cũng đã tìm thấy mối quan hệ giữa tuổi, trình độ học vấn, tình trạng bệnh tật trước khi vào viện và sự hài lòng với công tác chăm sóc điều dưỡng [48].

Như vậy, qua một số công cụ đánh giá sự hài lòng của NB về chăm sóc điều dưỡng, chúng ta nhận thấy mặc dù thang đo Likert được sử dụng có thể khác nhau, nội dung các câu hỏi có thể khác nhau nhưng bản chất đều tập trung tìm hiểu cảm nhận của người bệnh về dịch vụ y tế mà họ được cung cấp theo các khía cạnh chính:

+ Mối quan hệ, sự tương tác giữa người bệnh và điều dưỡng

+ Khả năng thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng theo chuyên môn y tế.

+ Khả năng tư vấn và giáo dục sức khỏe cho NB trong quá trình điều trị cũng như sau khi ra viện.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy công tác chăm sóc, hỗ trợ về mặt tinh thần cho NB cũng rất quan trong dù chưa được đề cập hoặc đề cập ít trong những công cụ kể trên. Thực tế, công tác chăm sóc về tinh thần là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của ĐD được quy định tại Điều 5, thông tư 07/2011/BYT [7]. Vì vậy trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi cũng tiến hành tìm hiểu thêm về công tác chăm sóc, hỗ trợ về tinh thần cho NB.

1.4.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng

Năm 2001, mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB đã được Jorgen Nathorst-Boos và cộng sự xây dựng. Theo mô hình này thì sự hài lòng của người bệnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: điều trị của bác sĩ, chăm sóc của điều dưỡng, thông tin, nhu cầu người bệnh, môi trường bệnh viện, tình trạng sức khỏe, kinh nghiệm trước đó, tiêu chuẩn xã hội, giáo dục, yếu tố tâm lý và bối cảnh bệnh viện [39].

Theo nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu tại Thái Lan thì các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của NB được xây dựng dựa trên quy trình của chăm sóc điều dưỡng từ lúc vào viện đến khi ra viện. Quy trình này gồm 4 khía cạnh là: giao tiếp của điều dưỡng, đảm bảo tình trạng vệ sinh buồng bệnh và khoa phòng, các hoạt

động chăm sóc điều dưỡng, cách cư xử của điều dưỡng với NB [46]. Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu khác còn cho thấy nhu cầu hành vi của NB bị ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng sức khỏe của họ. Khi NB được tôn trọng và được tham gia vào việc ra quyết định trong quá trình điều trị sẽ có mức hài lòng cao hơn so với việc chỉ tuân thủ y lệnh của thầy thuốc [30].

Dựa trên y văn, chúng tôi tóm tắt một số yếu tố chính liên quan đến sự hài lòng của NB như sau:

+ Các chăm sóc hỗ trợ về tinh thần: NB nhận được các dịch vụ như: nhân viên y tế đón tiếp nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ, động viên, quan tâm thăm hỏi NB hàng ngày và thái độ tôn trọng của điều dưỡng đối với NB.

+ Kỹ năng chuyên môn của điều dưỡng: NB cũng được theo dõi về tình trạng và diễn biến bệnh, được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ khi NB có khó khăn về ăn uống, vận động, vệ sinh, giúp đỡ khi thực hiện các hoạt động trong bệnh viện.

+ Giải thích về các hoạt động chăm sóc/ điều trị và sự tham gia của NB vào việc ra các quyết định chăm sóc: Trước khi thực hiện các quy trình kỹ thuật, thực hiện thuốc, đưa NB đi mổ, trước khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu, NB được giải thích về những điều có thể xảy ra, những thay đổi và dấu hiệu bất thường. Khi được giải thích tốt như vậy, NB có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn và cùng tham gia phối hợp với các điều dưỡng trong quá trình điều trị.

+ Thông tin về tình trạng bệnh tật và giáo dục sức khỏe: NB và người nhà được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh tật của mình và được hướng dẫn cách tự chăm sóc (chế độ ăn uống, cách tập luyện, theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng bất thường) trong và sau khi nằm viện. Vì không phải lúc nào nhân viên y tế cũng ở bên NB nên việc hướng dẫn cho NB và người nhà giúp cho họ tự chăm sóc bản thân khi cần [1].

1.5. Các kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của người bệnh với chất lượng chăm sóc của điều dưỡng

1.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới

Gần đây, nghiên cứu của Jafar Alasad và công sự (2015) tại Riyadh – Ả Rập Xê Út trên 424 NB sử dụng bộ công cụ NSNS phiên bản tiếng Ả Rập. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh về CSĐD là khá cao ở tất cả các khoa được khảo sát (90,67%), không có sự khác biệt về tỷ lệ hài lòng giữa từng khoa nội – ngoại và nhi ($p>0,05$). NB nữ tỏ ra hài lòng hơn so với NB nam (t-test, $p<0,05$) [27].

Wipada Kunaviktikul và cộng sự (2005) tại Thái Lan, đã đưa ra 9 chỉ số để đánh giá chất lượng chăm sóc của điều dưỡng ở Thái Lan đó là: Tỷ lệ điều dưỡng và tỷ lệ chuyên môn của điều dưỡng; số giờ làm việc của điều dưỡng/bệnh nhân/ngày với tổng số bệnh nhân nhập viện; tỷ lệ những NB nhập viện bị loét do tỳ đè, do nằm lâu sau khi nhập viện 72 giờ với tổng số NB ra viện ở cùng thời điểm; sự hài lòng của điều dưỡng với công việc, với các mối quan hệ, với đồng nghiệp, với cơ hội thăng tiến, với sự an toàn, với lương bổng; tỷ lệ nhiễm trùng các ống sonde tiểu sau khi nhập viện 48 giờ so với tổng số NB ra viện ở cùng thời điểm; tỷ lệ NB bị ngã trong thời gian nằm viện so với tổng số NB ra viện ở cùng thời điểm; sự hài lòng của NB với việc giáo dục sức khỏe cho họ; sự hài lòng của NB với việc kiểm soát đau; sự hài lòng của NB với các chăm sóc của ĐD bao gồm: Thể chất, tinh thần, cảm xúc, sự riêng tư, sự tham gia của NB vào việc ra các quyết định chăm sóc [40].

Nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu (2001) về *"Các yếu tố liên quan tới chất lượng dịch vụ CSĐD qua đánh giá của người bệnh ra viện tại bệnh viện Banpong"* trên 175 NB sau mổ ngoại khoa, thuộc tỉnh Ratchaburi - Thái lan. Cho thấy 3/5 số người bệnh cho rằng dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng là tốt. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng một số hoạt động của ĐD cần được cải thiện, chẳng hạn như việc hỗ trợ NB thực hiện một số hoạt động (tắm, gội đầu, vệ sinh…) trong bệnh viện. Có 51,3% NB hài lòng với chất lượng dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng. Nghiên cứu

cũng chỉ ra 4 yếu tố liên quan tới chất lượng chăm sóc là: Điều kiện của nguồn lực ĐD chăm sóc, kỹ năng và khả năng của người điều dưỡng, cách cư xử giữa các thành viên với nhau, thông tin y tế của ĐD và sự giáo dục của NB [46].

Nghiên cứu Mehrnoosh Akhtari-Zavave (2010), theo phương pháp mô tả cắt ngang. Đã được tiến hành để tìm hiểu mối liên quan giữa sự hài lòng trên 384 bệnh nhân ung thư với CSĐD trong 10 bệnh viện có tham gia giảng dạy ở Tehran, Iran. Cho thấy 82,2% người bệnh hài lòng với dịch vụ CSĐD được cung cấp, số người bệnh không hài lòng chiếm 17,2%. Về sự hài lòng của NB, có 76,7% bệnh nhân hài lòng với sự tư vấn và GDSK của ĐD; mối quan hệ cá nhân và điều dưỡng là 96,6%; kỹ năng điều dưỡng là 76,8% và yếu tố môi trường là 69,5% [26].

1.5.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam

Nghiên cứu của Trần Quang Huy (2009) tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho thấy mô hình chăm sóc NB theo đội đáp ứng được quan điểm chăm sóc NB toàn diện. Hầu hết điều dưỡng đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình và phát huy được chức năng nghề nghiệp độc lập khi chăm sóc NB, nắm bắt thông tin về NB, chế độ dinh dưỡng, những diễn biến về tình trạng bệnh và tư vấn, giáo dục sức khỏe cho NB. Tuy nhiên điều dưỡng cần lưu ý hơn trong nhận định, tiên lượng các nguy cơ xảy ra biến chứng để có kế hoạch phòng ngừa cho bệnh nhân. Người bệnh và NNNB đều hài lòng và đánh giá cao về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Hầu hết các nhân viên y tế tham gia khảo sát đều hài lòng với mô hình này, trách nhiệm cá nhân phải cao hơn và phải tích cực hơn [15]. Nghiên cứu này đã đánh giá được công tác chăm sóc NB từ phía các thành viên của đội chăm sóc, mối quan hệ giữa các thành viên trong đội và sự hài lòng của các thành viên trong đội chăm sóc. Tuy nhiên chỉ tính được tỷ lệ (%) có thực hiện công việc chứ không biết các thành viên thực hiện công việc ở mức độ nào.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Điều và cộng sự về *"Thực trạng và một số giải pháp về tăng cường công tác điều dưỡng trong chăm sóc NB toàn diện tại viện chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108"* từ tháng 4/2006 đến 6/2007. Đối tượng gồm 120 NB đang điều trị tại viện Chấn thương-

Chỉnh hình, các NB đều trong giai đoạn sau phẫu thuật từ 2 ngày trở lên. Kết quả cho thấy NB đánh giá công tác chăm sóc, theo dõi những yếu tố cơ bản như mạch, nhiệt độ, huyết áp và làm các xét nghiệm được thực hiện ở mức độ cao (đạt > 90%); công tác chăm sóc theo dõi chuyên khoa sâu như chuẩn bị bệnh nhân trước mổ, hướng dẫn chế độ ăn uống, giáo dục sức khỏe, phòng bệnh và chế độ tập luyện được NB đánh giá ở mức độ thấp hơn (đạt < 90%) [10]. Tuy nhiên hạn chế trong nghiên cứu này là chưa tính tỷ lệ trung bình của từng nội dung chăm sóc và cũng chưa có tỷ lệ trung bình chung của các nội dung chăm sóc NB là bao nhiêu.

Nghiên cứu Nguyễn Thị Hiền và cộng sự (2009) về *"Đánh giá bước đầu kết quả chăm sóc toàn diện cho NB tại khoa ngoại sản bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh năm 2009"*. Cho thấy công tác tiếp đón, hướng dẫn nội quy khoa phòng được NB đánh giá đạt 100%. Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị có 93,4% NB cho là đạt yêu cầu. Về công tác theo dõi, chăm sóc, giải thích cho NB có 90% NB đánh giá công tác giải thích trước khi làm thủ thuật, giải thích chế độ ăn uống đạt yêu cầu. Có 93,3% NB đánh giá đạt về công tác thực hiện thuốc, hướng dẫn cách sử dụng thuốc và công khai thuốc vật tư tiêu hao [11]. Ưu điểm của nghiên cứu là đã tính được tỷ lệ phần trăm các nội dung chăm sóc của điều dưỡng đạt yêu cầu. Tuy nhiên chưa đánh giá được đầy đủ các nội dung chăm sóc toàn diện như công tác vệ sinh, vận động... Cỡ mẫu của nghiên cứu chỉ tiến hành trên 30 NB nên chưa phản ánh đúng được chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại khoa.

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Linh (2006) về *"Đánh giá kỹ năng giao tiếp trong điều trị, chăm sóc và phục vụ NB tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, năm 2006"*, khảo sát trên 227 NB, người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Đánh giá trên 4 nhóm tiêu chí: Thái độ tiếp đón, giao tiếp; sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ; tiêu cực giao tiếp giữa các nhân viên; những ý kiến đóng góp xây dựng. Kết quả cho thấy có từ 65,54% đến 74% ý kiến của NB và gia đình NB đánh giá nhân viên y tế luôn có thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử tốt. Có 90,7% đến 94,27% ý kiến NB đánh giá nhân viên y tế luôn có sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với NB và gia đình NB. 100% NB và người nhà NB đánh giá nhân viên y tế không

có biểu hiện gợi ý, nhận tiền, quà biếu và giao tiếp giữa các nhân viên luôn lịch sự, tôn trong lẫn nhau [18].

Nghiên cứu của Nguyễn Thu (2011) về *"Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định năm 2011"*, dựa trên nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp kết hợp (định lượng và định tính), thực hiện trên 96 NB nội trú. Cho thấy sự hài lòng của NB với chất lượng CSSK được xác định dựa vào 4 yếu tố: Thời gian chờ đợi tiếp cận chăm sóc; tiếp cận và tương tác với nhân viên bệnh viện; điều kiện cơ sở vật chất và kết quả nằm viện. Kết quả điều tra cho thấy rằng tỷ lệ hài lòng về giao tiếp và tương tác với nhân viên bệnh viện là thấp nhất (47,9%). Tiếp đến là thời gian chờ đợi nhận dịch vụ CSSK (72,9%). Tiếp theo đó là tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị (79,2%) và hài lòng về kết quả CSSK tại bệnh viện (85,4%). Tỷ lệ NB hài lòng với công tác vệ sinh và cảnh quan trong bệnh viện rất cao gần như tuyết đối (98,3 - 100%). Có tới 87,5% NB sẵn sàng giới thiệu người khác đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, tỷ lệ hài lòng chung với dịch vụ CSSK tại bệnh viện thấp chỉ có 59,4% [22].

Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn "*Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 2011"*. Công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình đội đạt hiệu quả cao trong chăm sóc, đặc biệt là hoạt động đi buồng đội vào mỗi buổi sáng. Người bệnh và người nhà người bệnh cũng được phát huy vai trò trong hoạt động chăm sóc dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng viên. Kết quả cũng cho thấy mức độ hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh là rất cao. Các nhiệm vụ được điều dưỡng viên thường xuyên thực hiện với tỷ lệ khá cao, điều dưỡng tự tin và rất tự tin khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên còn một số nhiệm vụ mà điều dưỡng viên chưa thường xuyên thực hiện là: chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB; chăm sóc phục hồi chức năng cho NB; giám sát người nhà hỗ trợ chăm sóc NB; tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB [24].

Nghiên cứu Bùi Thị Bích Ngà (2011), trong nghiên cứu của mình về *"Thực trạng công tác chăm sóc của điều dưỡng qua nhận xét của người bệnh điều trị nội*

trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, năm 2011". Tác giả cho biết điều dưỡng viên làm tương đối tốt các chức năng cơ bản như: Hỗ trợ điều trị và phối hợp thực hiện y lệnh của bác sĩ (đạt 84,2%). Theo dõi, đánh giá NB (80,5%); tiếp đón NB (đạt 78,9%). Các chức năng chăm sóc, hỗ trợ tâm lý tinh thần NB; chăm sóc hỗ trợ dinh dưỡng ăn uống; tư vấn, giáo dục sức khỏe đạt lần lượt là 66,2%; 55,6%; 49,6%. Tuy vậy công tác chăm sóc, hỗ trợ NB nặng vệ sinh cá nhân hàng ngày chủ yếu do người nhà chăm sóc (86,3%). Các yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc của điều dưỡng từ phía người bệnh là các yếu tố về nơi cư trú, số lần nằm viện và cách thức điều trị của NB có ảnh hưởng đến việc nhận xét công tác chăm sóc của điều dưỡng. Từ phía nhân viên y tế gồm các yếu tố: Số lượng điều dưỡng không đủ (tỷ lệ ĐD/BS đạt 1/1,52) thiếu nhiều so với qui định về nhân lực trong hướng dẫn thực hiện thông tư 07/2011/TT-BYT. Chất lượng chuyên môn của đội ngũ điều dưỡng chưa đáp ứng đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của công tác chăm sóc NB. Nguyên nhân là do cơ cấu đội ngũ điều dưỡng không đồng đều cả về trình độ, nội dung được đào tạo cũng như sự hạn chế trong công tác đào tạo liên tục và tinh thần tự học của điều dưỡng viên. Tỷ lệ ĐD đại học, cao đẳng còn thấp (13%); 50% điều dưỡng trình độ trung cấp là y sĩ y học cổ truyền chuyển đổi sang điều dưỡng viên. Đặc biệt, ý thức và khả năng phát huy vai trò chủ động trong hoạt động chuyên môn của ĐD còn yếu, chủ yếu phụ thuộc vào y lệnh điều trị và phối hợp điều trị [20].

Theo nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh (2012), tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội về *"Đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012"* trên 385 bệnh nhân cho biết chất lượng chăm sóc của điều dưỡng được NB và người nhà người bệnh (NNNB) đánh giá đạt 79,5%. Tìm thấy có mối liên quan giữa 4 yếu tố (các chăm sóc hỗ trợ tinh thần của người bệnh, kỹ năng chuyên môn của điều dưỡng, hài lòng về giải thích về hoạt động chăm sóc/điều trị và sự tham gia của người bệnh trong việc ra các quyết định chăm sóc, cung cấp thông tin và sự giáo dục sức khỏe cho người bệnh) với sự hài lòng chung của người bệnh [1].

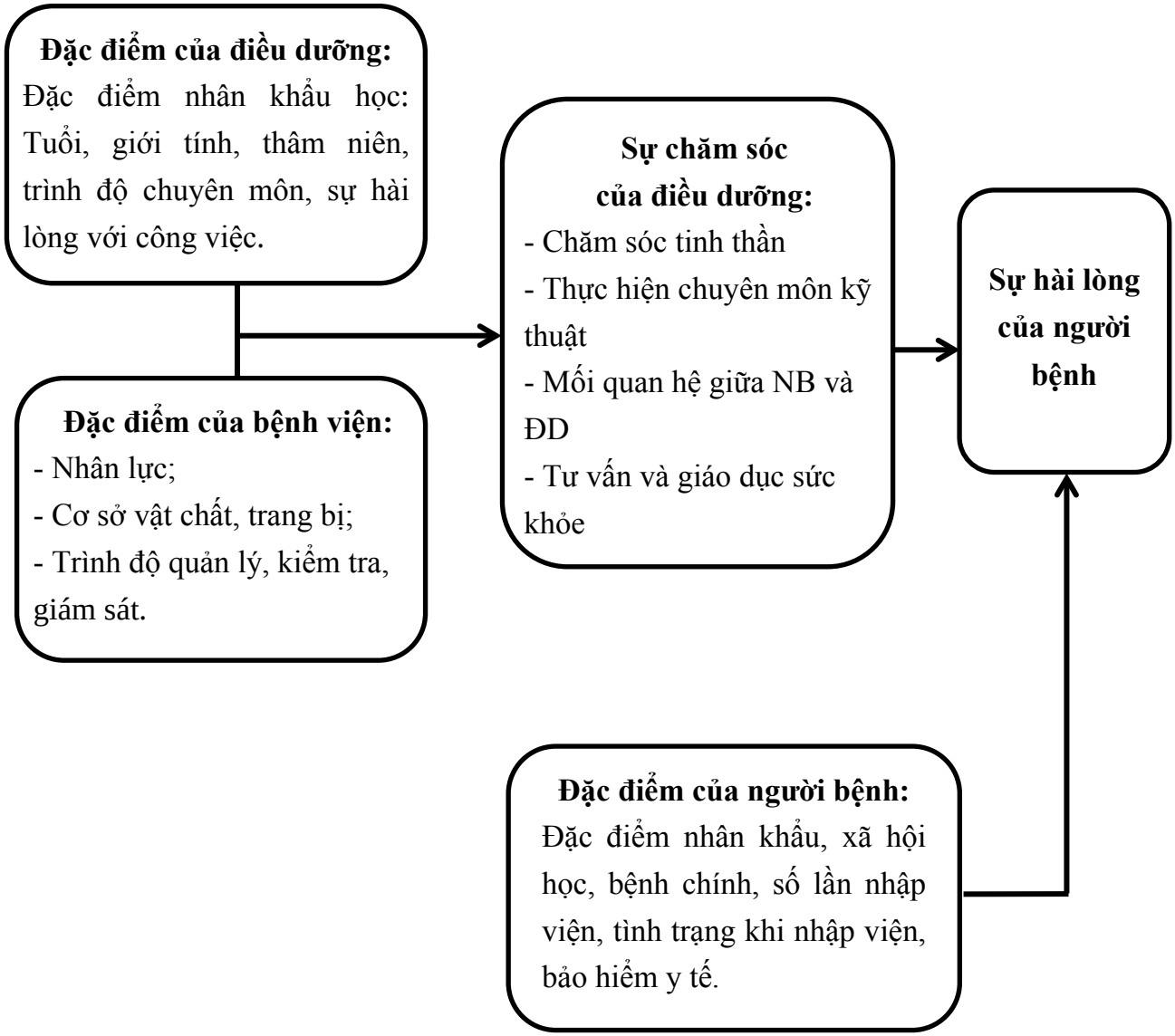
1.6. Giới thiệu Khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ Rẫy là một bệnh viện đa khoa trung ương tuyến cuối với tổng số cán bộ nhân viên tính đến cuối năm 2017 là hơn 3.800 người với 71 khoa, phòng. Bệnh viện có cơ cấu tổ chức khá phức tạp, trong đó có 5 trung tâm, 10 phòng chức năng và 48 khoa chuyên môn trong đó gồm rất nhiều chuyên khoa sâu [3].

Thời gian qua, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bệnh viện Chợ Rẫy luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, quản lý và vận hành tốt bệnh viện đồng bộ và hiện đại, với kỹ thuật và công nghệ luôn được đổi mới và áp dụng, đội ngũ thầy thuốc và nhân viên có đủ trình độ và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân khu vực phía Nam, cả trong nước và người nước ngoài. [3].

Khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy là một đơn vị trực thuộc bệnh viện Chợ Rẫy, được hình thành và đi vào hoạt động từ khi bệnh viện được thành lập. Ban đầu với tên gọi là khoa Huyết học – Miễn dịch với các bộ phận: Huyết học lâm sàng, Xét nghiệm huyết học - Miễn dịch và Ngân hàng máu. Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay khoa Huyết học đã là một tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân với 05 đơn vị trực thuộc, triển khai thực hiện các kỹ thuật cao như: ghép tế bào gốc ngoại vi cho bệnh nhân mắc bệnh lý máu ác tính cùng nhiều kỹ thuật khác. Khoa Huyết học đã tham gia và được công nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế ISO/IEC 15189:2012 và hiện có đủ năng lực để sàng lọc, chẩn đoán, điều trị bệnh nội và ngoại khoa (ghép tế bào gốc), các bệnh lý chuyên khoa huyết học, thực hiện các xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu [16]. Tại thời điểm nghiên cứu, Khoa Huyết học có 16 bác sĩ và 45 điều dưỡng, mỗi ngày trung bình khoa tiếp nhận mới 20 bệnh nhân nội trú và khám cho khoảng 200 bệnh nhân ngoại trú. Vào mỗi thời điểm, tại khoa luôn duy trì khoảng 90 bệnh nhân nằm điều trị.

1.7. Khung lý thuyết của nghiên cứu



Sơ đồ 1.1. Khung lý thuyết về mô hình tương tác về hành vi sức khỏe của người bệnh dựa trên mô hình của Cox, C.L. (1982) [41]

Trong nghiên cứu của chúng tôi do hạn chế về ngân sách và thời gian nghiên cứu, chúng tôi tập trung vào 2 nhóm yếu tố chính là: (1) Yếu tố cá nhân của NB gồm đặc điểm nhân khẩu - xã hội học và trải nghiệm của lần chăm sóc sức khỏe (CSSK) trước đây; và (2) sự tương tác giữa NB và điều dưỡng về các hoạt động chăm sóc điều dưỡng gồm: hỗ trợ tinh thần; thực hiện kỹ năng chăm sóc của điều dưỡng; tư vấn và giáo dục sức khỏe và mối quan hệ giữa cá nhân NB và ĐD.

(1) Các đặc điểm nhân khẩu – xã hội học:

Những yếu tố nhân khẩu học của NB có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của họ trong suốt quá trình chăm sóc. Theo Avis, Bond và Arthur (1995) thì tuổi, giới tính, dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa, trình độ học vấn, mức độ lo lắng, tình trạng sức khỏe trước khi nhập viện là những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB. Tuổi và giới tính ảnh hưởng đến nhận thức về chăm sóc của NB, NB lớn tuổi thì sự hài lòng của họ cao hơn so với NB trẻ tuổi và trung niên. Đàn ông thì có xu hướng hài lòng hơn so với phụ nữ [28]. Trong một nghiên cứu khác cho thấy trình độ học vấn có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của NB về CSĐD, những người bệnh có trình độ học vấn cao thì không hài lòng với chất lượng chăm sóc cung cấp nhiều hơn. Một trong những lý do có thể là những NB có trình độ học vấn cao thì mức độ yêu cầu thêm thông tin về chất lượng chăm sóc và luôn luôn cố gắng thiết lập sự tin tưởng về mối quan hệ giữa ĐD và người bệnh. Có thể những NB có trình độ học vấn thấp không biết về những quyền lợi của họ hoặc những gì tạo nên chất lượng chăm sóc tốt [44]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu được thực hiện bởi Liu và Wang (2007) về sự hài lòng của bệnh nhân về CSĐD và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong một bệnh viện ở Trung Quốc cho thấy các bệnh nhân có trình độ học vấn cao thì sự hài lòng với CSĐD cao hơn so với người có trình độ học vấn thấp hơn [45].

Loại bảo hiểm y tế mà NB sử dụng cũng có ảnh hưởng đến sự hài lòng của họ. Theo nghiên cứu của Burke và các cộng sự (2003) trên những bệnh nhân nhiễm HIV, những người có bảo hiểm y tế tư nhân chưa hài lòng với các khía cạnh tài chính của chăm sóc sức khỏe hơn so với những người có bảo hiểm công cộng hoặc không có bảo hiểm [31].

Các yếu tố như dân tộc, mức thu nhập trung bình/người/tháng, nghề nghiệp có mối liên quan đến sự hài lòng của NB được nhắc đến trong nghiên cứu của Nguyễn Đức Thành (2006) và Nguyễn Thu (2011) [21] [22].

Thời gian nằm viện, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của những lần nhập viện trước cũng ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB. Những NB nhập viện nhiều lần thường hài lòng hơn so với những người nhập viện lần đầu tiên [26]. Những người bị bệnh nặng thì ít hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn những người bị bệnh

nhẹ. Điều đó có thể giải thích là do nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của những người bệnh nặng cao hơn.

Nghiên cứu của Mehrnoosh Akhtari-Zavave trên các bệnh nhân ung thư và Nguyễn Bá Anh trên những bệnh nhân ngoại khoa, đều chưa tìm ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa loại giường NB sử dụng (bình thường và dịch vụ tự nguyện) với sự hài lòng của người trong suốt thời gian điều trị [1] [26].

(2) Các yếu tố nhận thức về chăm sóc điều dưỡng của NB hay sự tương tác của Điều dưỡng - người bệnh.

+ Sự tương tác giữa người bệnh và điều dưỡng

Mối quan hệ giữa NB và điều dưỡng là một yếu tố quan trọng quyết định sự hài lòng của NB. Khái niệm này bao gồm mối quan hệ, phát triển mối quan hệ, NB được biết đến như những cá nhân riêng biệt, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng, trung thực, tin tưởng, hợp tác và hài hước. Trong nghiên cứu của nhóm tác giả Shattell, Star và Thomas (2007): Mối quan hệ giữa các cá nhân, trong trường hợp này là giữa NB và ĐD, được xây dựng dựa trên các yếu tố như sự trung thực, tin tưởng, tôn trọng, hiểu biết, thấu hiểu, xem các cá nhân đơn thuần là một người trong gia đình (chứ không phải là NB hay gì khác), giữ liên lạc (trong giao tiếp), thân thiện và cảm nhận được sự gắn kết, hợp tác và vui vẻ [53]. Tác giả Liu và các cộng sự cũng chỉ rõ rằng NB có nhu cầu được chăm sóc, tiếp xúc với những điều dưỡng có thái độ quan tâm, lắng nghe và luôn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Sự thân thiện và vui vẻ điều dưỡng làm tăng sự hài lòng của NB [44]. Hiện nay, các bệnh viện rất quan tâm đến sự giao tiếp của điều dưỡng với NB. Điều đó được thể hiện qua việc các bệnh viện đã và đang nỗ lực tổ chức các chương trình tập huấn cho ĐD về quy tắc ứng xử theo Quyết định số 29/2008/QĐ – BYT. Tuy nhiên, có những NB tỏ ra không hài lòng đối với thái độ gắt gỏng, ban ơn và thiếu tôn trọng của ĐD đối với họ.

+ Thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng

Mong muốn được chăm sóc và tư vấn sức khỏe bởi một đội ngũ cán bộ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả là một trong những mong muốn cơ bản của NB khi họ đến bệnh viện

khám, chữa bệnh. Theo nghiên cứu của Heiner (2005), người bệnh cảm thấy an toàn hơn nếu họ được chăm sóc bởi đội ngũ điều dưỡng có trình độ, khéo léo và tạo cho họ có cảm giác tin tưởng, an toàn [37].

+ Tư vấn và giáo dục sức khỏe

Tư vấn cho NB rất quan trọng, NB cần thông tin liên quan về tình trạng bệnh của họ vì họ cảm thấy lo lắng, sợ hãi và dễ tổn thương hơn trong khi nằm viện. Nghiên cứu của Eriksson và Svedlund (2007) cho thấy đôi khi NB hiểu sai hay không tuân thủ điều trị vì sự truyền đạt không rõ ràng, khó hiểu trong những cách thức giao tiếp và thông tin mà họ nhận được từ điều dưỡng [35]. Nghiên cứu của Bankauskaite và Saarelma (2003) báo cáo rằng, sự thiếu thông tin về các nguyên nhân của bệnh, quan điểm và cách điều trị, chăm sóc là một trong những yếu tố dẫn đến NB không hài lòng [29].

Gia đình của người bệnh cũng có những nỗi sợ hãi và lo lắng, điều dưỡng cần dành thời gian để cung cấp thông tin, giải thích cho họ. Trong khi cung cấp thông tin, người điều dưỡng thường tìm thấy nhiều cơ hội để giáo dục sức khỏe cho NB làm thế nào để nhanh chóng hồi phục, để khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh, biến chứng. Và làm thế nào để thực hiện các hoạt động của cuộc sống một cách tốt nhất có thể. Bất cứ khi nào điều dưỡng thực hiện chăm sóc NB cũng nên giải thích hoặc thông báo những gì sẽ thực hiện. Một ví dụ đơn giản là việc lấy nhiệt độ cho NB có thể sẽ là không đơn giản, trừ khi người ĐD giải thích những gì họ đang làm, làm như thế nào và tại sao lại làm.

Việc tư vấn và giáo dục sức khỏe cho NB là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt, cũng như rất cần thiết trong sự phát triển mối quan hệ giữa NB và điều dưỡng. Điều dưỡng cần tận dụng những cơ hội tư vấn, giáo dục sức khỏe vì khi họ làm như vậy những kỹ năng của họ sẽ phát triển và điều đó là rất quan trọng.

+ Chăm sóc về tinh thần

Mỗi điều dưỡng có một cách thức cảm thông, giao tiếp riêng theo cá tính của bản thân với NB. Điều đó quyết định những hành vi giống nhau hay khác nhau giữa các điều dưỡng khi thực hiện việc chăm sóc, an ủi, động viên, hỗ trợ… với các

nhu cầu đặc biệt. Người bệnh đánh giá cao việc điều dưỡng cảm thông với những gì NB đang trải qua. Điều này giúp NB giảm sự lo lắng và sợ hãi về bệnh tật, những gì đang diễn ra xung quanh của họ [52]. Công tác chăm sóc tinh thần là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của ĐD được quy định tại Điều 5, thông tư 07/2011/BYT [7]

Để có thể đạt được những mục tiêu này, cán bộ điều dưỡng cần được đào tạo đầy đủ, làm việc trong môi trường bệnh viện với đủ trang thiết bị phù hợp và có đủ thời gian để hoàn thành từng nhiệm vụ: từ tương tác với NB, tìm hiểu và hỗ trợ về tinh thần, thực hiện y lệnh và tư vấn giáo dục sức khỏe. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cần đưa ra những quy trình làm việc, tiêu chí phục vụ NB của ĐD hết sức rõ ràng và có sự giám sát thực hiện các quy định này từ cấp trên. Đây vừa là mục tiêu làm việc, vừa là động lực thúc đẩy cán bộ ĐD nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ do mình tham gia cung cấp.

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Huyết học –Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Các bên liên quan: Trưởng khoa và Phó khoa Huyết học phụ trách điều dưỡng, điều dưỡng trưởng Khoa Huyết học, điều dưỡng viên tại các đơn vị: điều trị trong ngày, ghép tế bào gốc ngoại vi, huyết học lâm sàng, sinh học phân tử-di truyền.

➢ *Tiêu chuẩn lựa chọn người bệnh:*

- Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Bệnh nhân có thời gian điều trị nội trú tại khoa từ 5 ngày trở lên và được xuất viện.

➢ *Tiêu chuẩn loại trừ người bệnh:*

- Người bệnh là nhân viên y tế hoặc người nhà của nhân viên y tế tại Bệnh viện.

- Người bệnh từ chối tham gia nghiên cứu.

- Người bệnh hôn mê hoặc có tinh thần không tỉnh táo.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2018 đến tháng 08/2018.

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Kết quả định tính bổ trợ cho kết quả định lượng.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

2.4.1. Nghiên cứu định lượng

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu xác định một giá trị tỷ lệ:

$$n = \frac{Z^2_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot p(1-p)}{d^2}$$

Trong đó:

n: Là số người bệnh cần nghiên cứu.

p: Là tỷ lệ hài lòng của NB về công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (2012) tỷ lệ hài lòng của NB là 80% nên p = 0,8 [1].

Z: ứng với α= 5% thì $Z_{(1-\alpha/2)}$ =1,96

d: sai số cho phép 0,05

Thay vào công thức ta tính được n = 246, ước lượng 20% từ chối phỏng vấn và làm tròn số được cỡ mẫu (n) là 295 người bệnh.

Phương pháp chọn mẫu: sử dụng phương pháp chọn mẫu toàn bộ, tất cả người bệnh đủ tiêu chuẩn lựa chọn đều được mời tham gia nghiên cứu đến khi đủ cỡ mẫu dự kiến.

2.4.2. Nghiên cứu định tính

- Thực hiện 13 cuộc phỏng vấn sâu sau khi chọn mẫu có chủ đích:

+ 01 Trưởng khoa Huyết học

+ 02 Phó khoa Huyết học phụ trách điều dưỡng

+ 01 Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học

+ 04 Điều dưỡng viên tại các đơn vị: điều trị trong ngày, ghép tế bào gốc ngoại vi, huyết học lâm sàng, sinh học phân tử-di truyền.

+ 05 bệnh nhân nội trú.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu

2.5.1. Các bước thu thập số liệu

❖ *Phần định lượng:*

- Phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân ngay tại bệnh phòng hoặc phòng giao ban Khoa Huyết học:

Bước 1: Hàng ngày sau thời gian đi buồng bệnh, điều tra viên lập danh sách những người bệnh đủ tiêu chuẩn để mời phỏng vấn *(thời gian nằm viện từ 5 ngày*

trở lên và sẽ được xuất viện trong ngày). Sử dụng phương pháp chọn mẫu toàn bộ người bệnh có trong danh sách.

Bước 2: Khi NB hoàn thành các thủ tục khám bệnh hoặc ra viện, điều tra viên xin gặp và mời vào phòng giao ban để phỏng vấn. Nếu đối tượng nghiên cứu đồng ý tham gia sẽ được mời ký giấy đồng ý tham gia nghiên cứu.

Bước 3: Điều tra viên (ĐTV) tiến hành phỏng vấn đối tượng nghiên cứu.

Bước 4: Kết thúc phỏng vấn, ĐTV kiểm tra phiếu trả lời.

- Bộ câu hỏi được nghiên cứu viên điều tra thử trên 10 bệnh nhân tại Khoa Huyết học trước khi tiến hành điều tra trên quần thể nghiên cứu, sau đó có chỉnh sửa cho phù hợp. Toàn bộ quá trình thu thập số liệu định lượng dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2018.

❖ *Phần định tính*

Phỏng vấn sâu: Thông qua phương pháp này để hiểu sâu hơn bản chất của vấn đề chất lượng công tác chăm sóc điều dưỡng tại khoa.

2.5.2. Công cụ thu thập số liệu

a. Phần định lượng

Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc tham khảo từ nghiên cứu sự hài lòng của NB nội trú về chất lượng chăm sóc điều dưỡng tại Bệnh viện Việt Đức của tác giả Nguyễn Bá Anh [1]. Bộ câu hỏi này được chỉnh lý cho phù hợp với bối cảnh của Khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó, thang đo cho nghiên cứu được xây dựng gồm 28 tiểu mục thuộc 4 yếu tố:

- Chăm sóc tinh thần cho NB: 05 tiểu mục/biến.
- Thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng: 09 tiểu mục/biến.
- Mối quan hệ giữa NB và ĐD: 06 tiểu mục/biến.
- Tư vấn và giáo dục sức khỏe: 08 tiểu mục/biến.

b. Phần định tính

Việc thu thập số liệu định tính được thực hiện nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, các yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc của điều dưỡng cũng như các giải pháp nhằm cải thiện công tác này, góp phần nâng cao sự hài lòng của NB.

Thu thập dữ liệu định tính dựa vào các hướng dẫn PVS để phỏng vấn lãnh

đạo khoa Huyết học, ĐD trưởng và ĐD viên và người bệnh nội trú. Những cuộc phỏng vấn này được thực hiện tại phòng giao ban của khoa Huyết học vào thời gian thích hợp và có ghi âm. Nguồn dữ liệu này do học viên trực tiếp phỏng vấn, ghi biên bản phỏng vấn và gỡ băng.

2.6. Phương pháp phân tích số liệu

2.6.1. Xử lý khi thu thập số liệu

Định lượng: Tất cả những số liệu thu thập được kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc.

- Kết quả thu thập số liệu của các điều tra viên được giám sát, kiểm tra để có biện pháp khắc phục vào ngày hôm sau nếu nếu có sai sót.

Định tính: Ghi âm, gỡ băng, ghi chép và phân tích theo từng nhóm chủ đề.

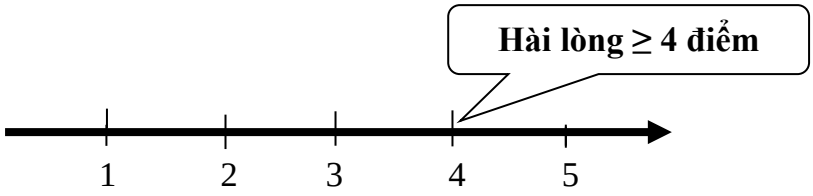
2.6.2. Phân tích số liệu

❖ **Phương pháp phân tích các số liệu định lượng:**

- Số liệu định lượng sau khi thu thập được làm sạch, nhập vào máy tính bằng phần mềm Epi Data 3.1 và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 19.0 cho các thông tin mô tả và phân tích thống kê.

+ Phần mô tả: thể hiện tần số của các biến trong nghiên cứu.

+ Phần phân tích: Xem xét các mối liên quan giữa sự hài lòng của người bệnh với một số yếu tố khác bằng kiểm định khi bình phương (χ^2), độ mạnh của mối liên quan được xác định với tỷ số chênh OR và khoảng tin cậy (CI) 95%. Phân tích mô hình hồi quy Logistic đa biến sẽ được sử dụng để kiểm soát các yếu tố nhiễu.



(Thang đo mức độ hài lòng tăng dần)

Theo phân tích, suy luận logic với thang điểm Likert, thì mức hài lòng của người bệnh bắt đầu từ mức 4 (4 điểm) (1: Rất không hài lòng, 2: Không hài lòng, 3: Bình thường, 4: Hài lòng, 5: Rất hài lòng), vì thế thang điểm Likert được mã hóa

thành 2 nhóm: nhóm chưa hài lòng (1-3 điểm) và nhóm hài lòng (4-5 điểm) đối với từng tiểu mục, từ đó tính tỷ lệ hài lòng của người bệnh theo từng tiểu mục.

Điểm hài lòng trung bình của từng yếu tố về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng được xác định từ điểm các tiểu mục của nó. Điểm hài lòng trung bình được mã hóa thành 2 nhóm: Nhóm hài lòng với điểm ≥ 4 và nhóm không hài lòng với điểm < 4.

Mỗi yếu tố được hình thành từ nhiều tiểu mục, mỗi yếu tố chia thành 2 nhóm "hài lòng" và "không hài lòng". Điểm giới hạn giữa 2 nhóm của các yếu tố được tính bằng công thức: 4 điểm x số tiểu mục. Như vậy:

- Yếu tố hài lòng về chăm sóc tinh thần cho người bệnh, có điểm giới hạn là 4 điểm x 5 tiểu mục = 20 điểm.
- Yếu tố hài lòng về thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng, có điểm giới hạn là 4 điểm x 9 tiểu mục = 36 điểm.
- Yếu tố hài lòng về mối quan hệ giữa NB và ĐD, có điểm giới hạn là 4 điểm x 6 tiểu mục = 24 điểm.
- Yếu tố hài lòng về cung cấp tư vấn và GDSK của điều dưỡng, có điểm giới hạn là 4 điểm x 8 tiểu mục = 32 điểm.

Kết quả nghiên cứu về mức độ hài lòng chung của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy dựa trên cơ sở 4 yếu tố vừa nêu, được xem là yếu tố then chốt quyết định việc người bệnh có đến với bệnh viện trong tương lai hay không và việc bệnh viện cần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc điều dưỡng như thế nào. Biến này được sử dụng để tìm hiểu các mối liên quan về sự hài lòng của người bệnh với các yếu tố về nhân khẩu, nghề nghiệp, các thông tin cá nhân của người bệnh.

Điểm tối đa đánh giá sự hài lòng chung của người bệnh về chất lượng CSSK được tính: 4 điểm x 28 tiểu mục = 112 điểm.

❖ **Phương pháp phân tích số liệu định tính:**

Các thông tin định tính được gỡ băng theo từng cuộc PVS và trích dẫn ý kiến tiêu biểu trong trình bày kết quả nghiên cứu.

2.7. Biến số nghiên cứu

a) Biến số định lượng(*):

Các nhóm biến số chính:

(1)- Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu gồm có 13 biến số, bao gồm các thông tin về xã hội, nhân khẩu học và các thông tin liên quan đến nhập viện lần này.

(2)- Sự hài lòng của người bệnh về các chăm sóc tinh thần của ĐD có 5 biến số, là nhận xét của NB về sự hài lòng của mình về công tác chăm sóc, hỗ trợ tinh thần của điều dưỡng trong quá trình điều trị tại khoa.

(3)- Sự hài lòng của người bệnh về thực hiện hoạt động chăm sóc của ĐD có 7 biến số, là nhận xét của NB về sự hài lòng của mình về việc thực hiện các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng.

(4)- Sự hài lòng của người bệnh về mối quan hệ với ĐD có 5 biến số, là nhận xét của NB về sự hài lòng của mình về mối quan hệ của điều dưỡng đối với cá nhân họ trong suốt quá trình chăm sóc.

(5)- Sự hài lòng của người bệnh về tư vấn và giáo dục sức khỏe của ĐD có 4 biến số, là nhận xét của NB về sự hài lòng của mình về việc cung cấp các thông tin về chế độ ăn, sử dụng thuốc, làm xét nghiệm, chế độ luyện tập vận động… của ĐD cho NB trong thời gian điều trị tại khoa và sau khi ra viện.

(6)- Thông tin về nhân lực điều dưỡng chăm sóc NB tại Khoa có 12 biến số bao gồm các thông tin chung về xã hội, nhân khẩu học của điều dưỡng, tỷ lệ BS/ĐD, số giường bệnh, sự quan tâm và giám sát của Lãnh đạo.

(*) Tham khảo chi tiết trong Phụ lục 7

b) Các chủ đề nghiên cứu định tính

Tên chủ đề	Kết quả mong đợi
Chăm sóc tinh thần cho người bệnh	Ý kiến của các bên liên quan về hoạt động chăm sóc tinh thần cho người bệnh, thuận lợi và khó khăn của hoạt động này.
Việc thực hiện kỹ thuật	Ý kiến của các bên liên quan về việc thực hiện kỹ

chuyên môn của điều dưỡng	thuật chuyên môn của điều dưỡng, thuận lợi và khó khăn của hoạt động này.
Mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng	Ý kiến của các bên liên quan về mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng.
Vấn đề tư vấn và giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh.	Ý kiến của các bên liên quan về hoạt động tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thuận lợi và khó khăn của hoạt động này.
Sự hài lòng chung của người bệnh	Ý kiến của các bên liên quan về sự hài lòng chung của người bệnh.

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu

- Nghiên cứu đã được sự cho phép của Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và sự đồng tình giúp đỡ của lãnh đạo Khoa Huyết học cùng toàn thể cán bộ nhân viên tại Khoa Huyết học.
- Hoạt động thu thập số liệu được tiến hành theo Quyết định số 151/2018/YTCC-HD3 ngày 02/4/2018 của Hội đồng Đạo đức - Trường Đại học Y tế Công cộng.
- Tất cả các thông tin của đối tượng nghiên cứu được đảm bảo giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
- Bệnh nhân ký vào phiếu chấp nhận tham gia trước khi tiến hành phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn bệnh nhân có quyền từ chối không tiếp tục trả lời bất cứ lúc nào.
- Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng tại khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như các khoa khác nhằm xây dựng giải pháp cải thiện các hạn chế liên quan đến công tác chăm sóc của điều dưỡng.

2.9. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số

2.9.1. Hạn chế của nghiên cứu

- Nghiên cứu có những hạn chế của một nghiên cứu cắt ngang nên chỉ đánh giá các yếu tố liên quan tại một thời điểm nghiên cứu.

- Đề tài chỉ đánh giá sự hài lòng của NB và các yếu tố liên quan về công tác chăm sóc của điều dưỡng tại Khoa Huyết học thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể không đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh hay toàn quốc.
- Nghiên cứu chưa tiến hành đánh giá việc thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc của điều dưỡng bằng phương pháp quan sát.
- Sai số do một số cán bộ y tế biết thời gian đánh giá nên có sự thay đổi trong công tác chăm sóc NB do đó dẫn đến sai số.

2.9.2. Biện pháp khắc phục

- Thiết kế câu hỏi đơn giản, dễ trả lời.
- Tiến hành thử nghiệm trên 10 đối tượng và chỉnh sửa lại bộ công cụ trước khi tiến hành phỏng vấn thu thập số liệu chính thức.
- Bố trí địa điểm phỏng vấn riêng biệt, thoải mái trao đổi, tránh việc bị tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng tâm lý. Nghiên cứu viên có mặt thường xuyên để hỗ trợ và giám sát hoạt động phỏng vấn.

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Một số thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu

Nội dung	Tần số (n=299)	Tỷ lệ (%)
Giới tính		
Nam	143	47,8
Nữ	156	52,2
Tuổi *(min=18; max=93; Trung bình=44,5±15,4)*		
18 – 30 tuổi	66	22,1
31 – 60 tuổi	194	64,9
61 tuổi trở lên	39	13,0
Nơi thường trú		
Thành phố Hồ Chí Minh	65	21,7
Các tỉnh thành khác	234	78,3
Dân tộc		
Kinh	273	91,3
Khác	26	8,7
Trình độ học vấn		
Không biết chữ	20	6,7
Tiểu học, Trung học cơ sở	132	44,1
Phổ thông trung học, Trung cấp	102	34,1
Cao đẳng trở lên	45	15,1
Tình trạng hôn nhân hiện tại		
Độc thân	56	18,7
Có gia đình	234	78,3
Ly hôn/ Ly thân/ Góa	9	3,0

Nội dung	Tần số (n=299)	Tỷ lệ (%)
Nghề nghiệp chính		
Học sinh, sinh viên	16	5,4
Nông dân	149	49,8
Cán bộ/ Công nhân/ Viên chức	80	26,8
Cán bộ hưu trí	12	4,0
Lao động tự do, nghề khác	42	14,0
Thu nhập bình quân		
Hộ nghèo	88	29,4
Hộ không nghèo	211	70,6

Bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ nam/ nữ được mời tham gia nghiên cứu khá tương đương (47,8% nam và 52,2% nữ).

Tuổi của ĐTNC từ 18 đến 93 tuổi, tuổi trung bình là 44.

ĐTNC đến từ các tỉnh thành xung quanh TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ lớn (78,3%) trong khi nhóm đối tượng sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh chỉ chiếm 21,7%.

Hai nhóm ĐTNC có trình độ trung học cơ sở và trung học phổ thông chiếm tỷ lệ lần lượt 44,1% và 34,1; nhóm không biết chữ chỉ có 6,7%.

Tỷ lệ ĐTNC đã lập gia đình chiếm 78,3%, nhóm độc thân là 18,7% và ly dị/ ly thân/ góa là 3%.

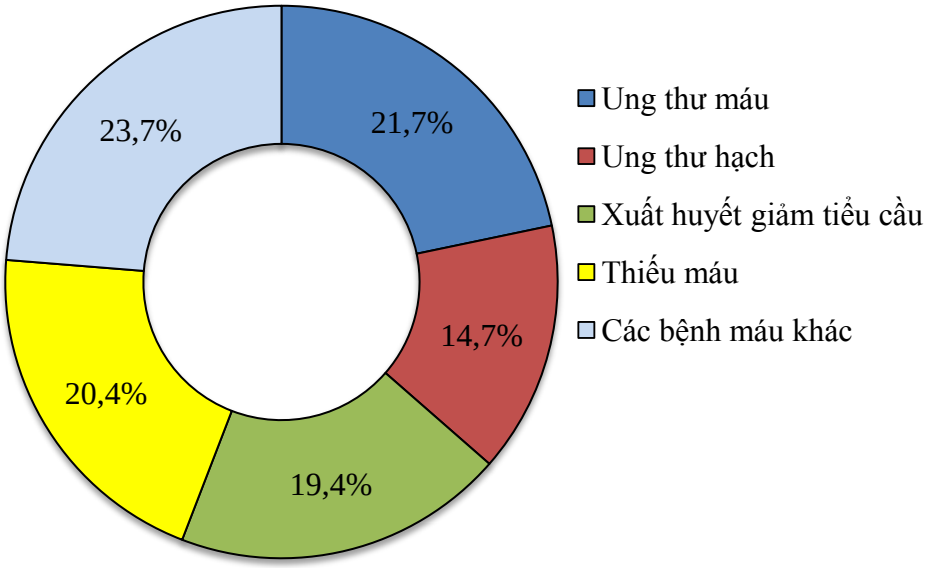
Gần một nửa số ĐTNC (49,8%) là nông dân; 26,8% là viên chức/ công nhân; 5,4% là học sinh, sinh viên. Số ĐTNC có thu nhập trung bình hàng tháng thuộc diện hộ nghèo chiếm 29,4%.

Bảng 3.2. Thông tin về lần nhập viện này

Thông tin	Tần số (n=299)	Tỷ lệ (%)
Bệnh chính được chẩn đoán ở lần nhập viện này		
Ung thư máu	65	21,7
Các bệnh do thiếu máu	61	20,4
Xuất huyết giảm tiểu cầu	58	19,4
Ung thư hạch	44	14,7
Bệnh lý khác	71	23,7
Bảo hiểm y tế (BHYT)		
Có BHYT	282	94,3
Không có BHYT	17	5,7
Số ngày điều trị *(min=2, max=120; Trung bình: 10,3 ± 9)*		
1 – 7 ngày	119	39,8
8 – 14 ngày	149	49,8
Trên 14 ngày	31	10,4
Tình trạng của ĐTNC lúc vào viện		
Cấp cứu	172	57,5
Khám bệnh/ Tái khám và nhập viện	127	42,5
Số lần nhập viện trong 12 tháng gần đây		
1 lần	136	45,5
Từ 2 – 5 lần	139	46,5
Trên 5 lần	24	8,0

Bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ đối tượng được mời tham gia nghiên cứu phân bố khá đồng đều giữa các nhóm bệnh lý khác nhau. Đa số ĐTNC đều có tham gia bảo hiểm y tế (94,3%). Tỷ lệ ĐTNC vào viện trong tình trạng cấp cứu là 57,5%, cao hơn nhóm đối tượng vào viện theo lịch hẹn (42,5%). Số ĐTNC vào viện lần đầu chiếm 45,5%, nhóm đã vào viện điều trị từ 2 đến 5 lần chiếm 46,5%. Nhóm phải vào viện điều trị thường xuyên (trên 5 lần/ năm) chiếm 8%.

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ phân bố theo bệnh lý



Biểu đồ 3.1 mô tả chi tiết hơn theo từng nhóm bệnh lý của ĐTNC. Theo đó, nhóm ĐTNC mắc ung thư máu và thiếu máu là nhiều nhất (đều 21,1%). Tiếp đến là nhóm mắc xuất huyết giảm tiểu cầu (19,1%) và ung thư hạch (14,7%). Nhóm mắc các bệnh về máu khác chiếm 24,1%.

3.2. Sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng chăm sóc điều dưỡng

3.2.1. Hài lòng của người bệnh về sự chăm sóc tinh thần

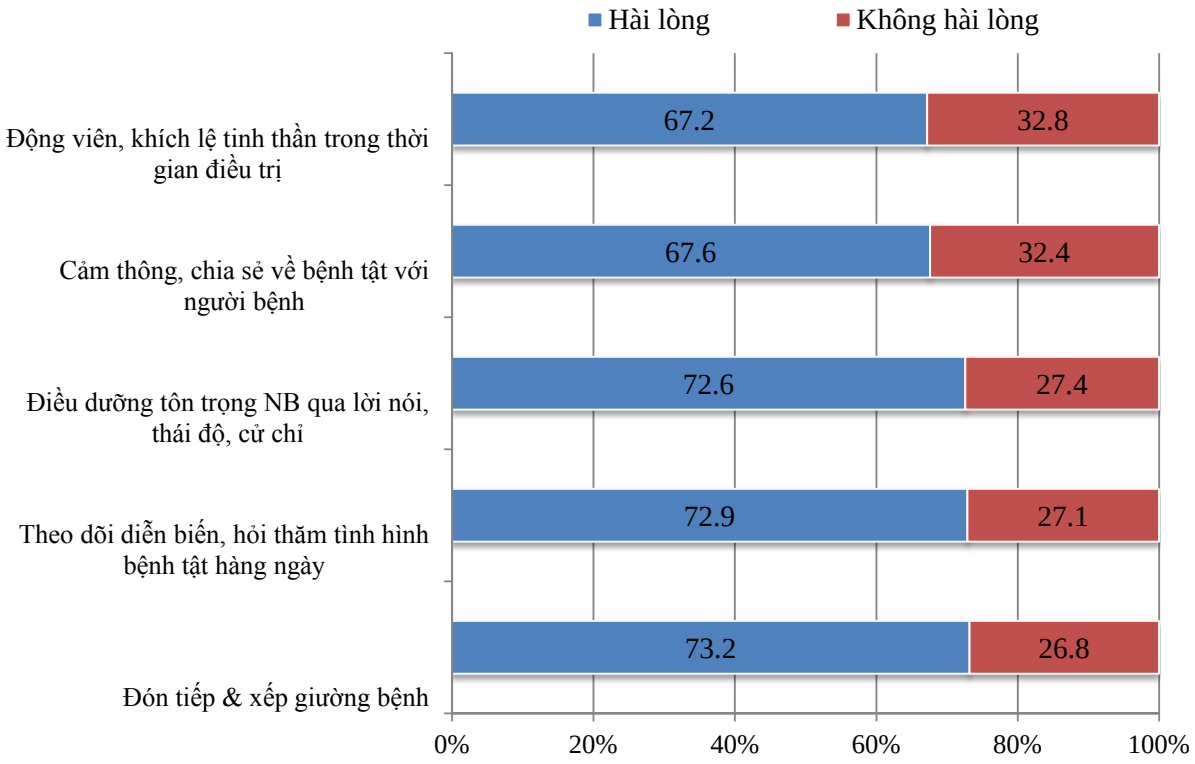
Bảng 3.3. Hài lòng của người bệnh về sự chăm sóc tinh thần (n=299)

Nội dung	Điểm trung bình
Hài lòng với việc theo dõi diễn biến, hỏi thăm về tình hình bệnh tật của NB hàng ngày trong thời gian nằm viện	3,91 ± 0,6
Hài lòng với sự tôn trọng của điều dưỡng (qua lời nói, thái độ, cử chỉ) trong khi chăm sóc	3,89 ± 0,7
Hài lòng với sự đón tiếp và sắp xếp giường bệnh của ĐD	3,88 ± 0,6
Hài lòng về mức độ cảm thông, chia sẻ về bệnh tật của điều dưỡng với người bệnh	3,82 ± 0,7
Hài lòng với sự động viên, an ủi, khích lệ tinh thần của điều dưỡng trong thời gian nằm điều trị tại khoa	3,81 ± 0,7

Điểm trung bình của 5 tiểu mục về chăm sóc tinh thần đều thấp hơn điểm hài lòng tối thiểu (≥4 điểm). Hoạt động của ĐD được đánh giá cao là việc theo dõi diễn biến, hỏi thăm về tình hình bệnh tật của NB hàng ngày (3,91 điểm), thái độ tôn trọng người bệnh (3,89 điểm). Các hoạt động của ĐD chưa được đánh giá tốt là cảm thông, chia sẻ với NB (3,82 điểm) và động viên, an ủi, khích lệ tinh thần người bệnh (3,81 điểm).

Biểu đồ 3.2 mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc tinh thần. Hai hoạt động có điểm trung bình thấp là cảm thông, chia sẻ với NB và động viên, an ủi, khích lệ tinh thần cũng có tỷ lệ hài lòng lần lượt chỉ là 67,2% và 67,6% - các tỷ lệ này thấp hơn so với ba hoạt động còn lại có tỷ lệ từ 72,6% đến 73,2%.

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ hài lòng người bệnh về chăm sóc tinh thần của điều dưỡng



Nói về hoạt động chăm sóc tinh thần của điều dưỡng, từ cấp độ quản lý khoa đến từng điều dưỡng viên đều hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của hoạt động này. Tuy nhiên tỷ lệ hài lòng của người bệnh đánh giá về nhóm hoạt động này còn thấp, chỉ dao động trong khoảng 67,2% đến 73,2% cho thấy hoạt động này còn có nhiều vấn đề cần cải thiện. Về phía điều dưỡng cho thấy họ rất thương yêu và quan tâm tới người bệnh, tuy nhiên bởi khối lượng công việc quá nhiều khiến họ dù muốn nhưng chưa có đủ thời gian để chăm sóc tinh thần cho toàn bộ người bệnh trong khoa. Hiện chỉ có thể dành sự chăm sóc tinh thần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn: *"ĐD có quan tâm hỏi han tình hình NB đặc biệt, hỏi về hoàn cảnh, biết được tâm tư tình cảm của NB, từ đó hiểu được NB cần gì. Tuy nhiên việc này mới chỉ thực hiện được trên một vài NB đặc biệt chứ chưa phải tất cả"* (PVS ĐD 1).

Một bác sĩ khẳng định tình trạng thiếu nhân lực của khoa Huyết học như sau: *"Hiện ĐD không có đủ thời gian để chăm sóc hỗ trợ tinh thần cho NB dù NB rất cần. Công tác chuyên môn đã chiếm phần lớn thời gian của ĐD"* (PVS cán bộ quản lý khoa Huyết học).

Một cán bộ quản lý tại khoa Huyết học cho biết thêm: *"do phần hành chính chiếm rất nhiều thời gian nên thời gian dành cho chăm sóc tinh thần hiện rất ít. Cơ hội gặp và nói chuyện với NB không nhiều. Chỉ khi thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng thì lúc đó mới giao tiếp với NB chứ bình thường không có thời gian để giao tiếp"* (PVS ĐD 1).

Ngoài ra, ĐD cũng có tâm lý e ngại khi phải chia sẻ về thông tin bệnh tật với NB do các vấn đề liên quan đến tâm lý NB cũng như vấn đề pháp lý phát sinh. Một điều dưỡng chia sẻ: *"ĐD cũng cố gắng hỗ trợ về tâm lý và tinh thần cho NB nhưng đôi khi không thể nói chuyện nhiều. Những người bệnh ở đây đa phần là mắc ung thư nên mình không thể cứ thế nói thẳng nói thật cho NB được. Vì thế chúng tôi chỉ hỗ trợ tinh thần cho những trường hợp nào đã biết rõ về tình trạng bệnh tật của mình, ĐD hiểu về diễn biến tâm lý của NB thì mới hỗ trợ được. Còn nếu ĐD tư vấn không hết ý thì có khi sẽ lại gây hiểu lầm hoặc sự cố đáng tiếc"* (PVS ĐD viên).

Về phía người bệnh, họ có phản hồi khá tốt về hoạt động chăm sóc tinh thần của ĐD. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng kỳ vọng của NB và người nhà đối với hoạt động này cũng chưa cao. Đa số NB và người nhà chỉ cần được đáp ứng các nhu cầu tối thiểu là đã thấy hài lòng như: được đón tiếp và sắp xếp giường sớm, được hướng dẫn các quy định và đối xử một cách tôn trọng. NB cảm nhận được sự bận rộn của ĐD nên thường không đòi hỏi nhận được động viên, khích lệ tinh thần hoặc cảm thông. Một bệnh nhân nhận xét: *"các cô ĐD vui vẻ, không làm gì để mình cảm thấy buồn, khi bệnh nhân đến các cô làm kịp thời, khám ngay, nhận bệnh ngay"* PVS NB 1.

Chỉ cần một vài lời động viên, hỏi thăm NB cũng đủ khiến họ cảm thấy được quan tâm và gần gũi. Một NB đã cho biết: *"Đôi khi được các cô (ĐD) hỏi han, thấy gần gũi giống như người nhà"* PVS NB 01.

3.2.2. Hài lòng về thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng

Bảng 3.4. Hài lòng về thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng (n=299)

Nội dung	Điểm trung bình
Hài lòng về việc thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng	3,98 ± 0,6
Hài lòng với việc điều dưỡng đến và xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường (quá lạnh, quá đau, nôn, ...) khi được thông báo	3,95 ± 0,6
Hài lòng với sự hướng dẫn các thủ tục hành chính (viện phí, bảo hiểm y tế, …) khi vào khoa điều trị	3,93 ± 0,7
Hài lòng với sự giúp đỡ của điều dưỡng khi thực hiện các hoạt động (hỗ trợ ăn uống, đi lại, vệ sinh thân thể, đại tiểu tiện, …)	3,91 ± 0,6
Hài lòng với sự hướng dẫn và trang bị đầy đủ đồ vải (ga giường, quần áo) khi vào khoa điều trị	3,87 ± 0,6
Hài lòng về sự sắp xếp của điều dưỡng khi NB ra viện	3,87 ± 0,6
Hài lòng về thực hiện công khai thuốc hàng ngày của ĐD	3,85 ± 0,6
Hài lòng với điều dưỡng đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng (chụp X-quang, siêu âm, …) trong thời gian nằm viện	3,85 ± 0,6
Hài lòng về thời gian chờ đợi Điều dưỡng (chăm sóc, thực hiện thuốc, thay dịch truyền, …)	3,77 ± 0,7

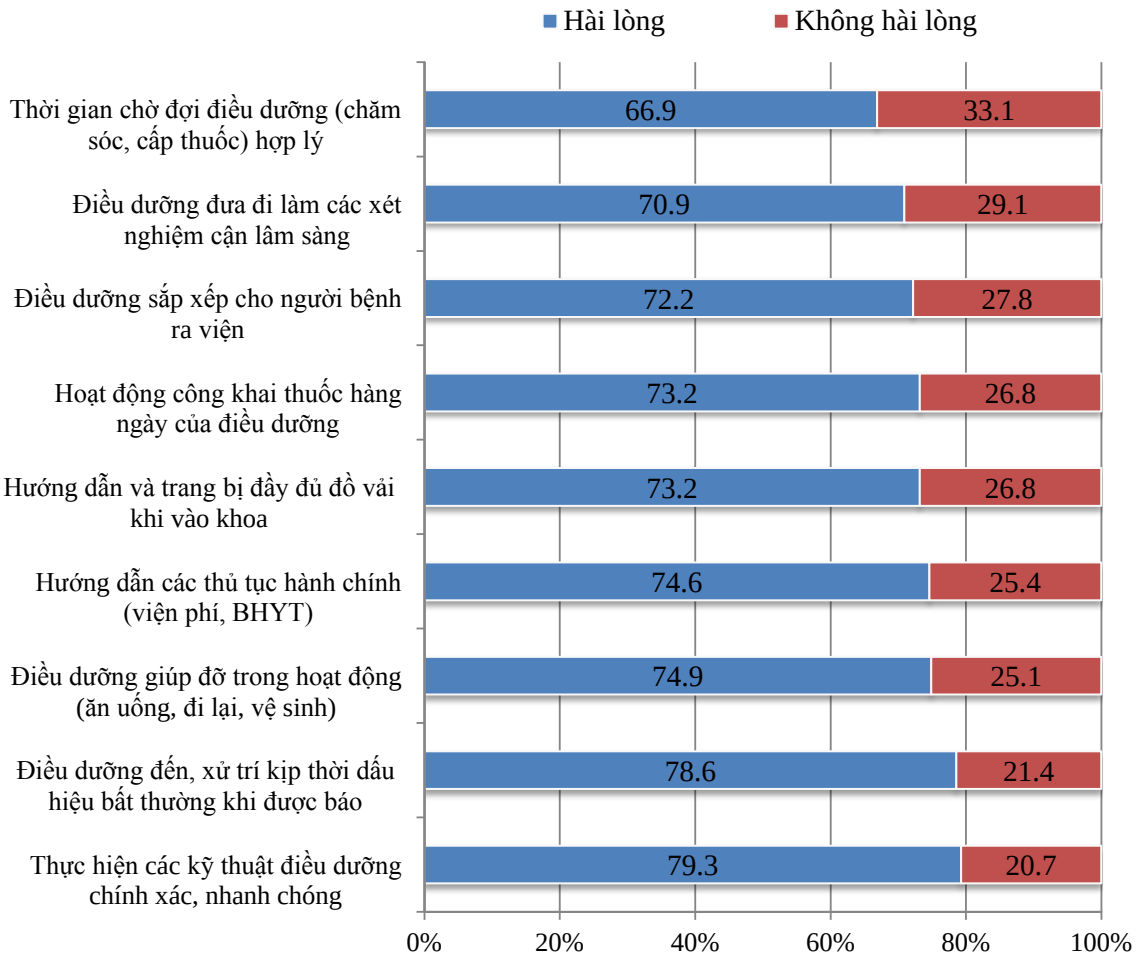
Điểm trung bình của 9 tiểu mục người bệnh hài lòng về thực hiện hoạt động chuyên môn của điều dưỡng trong thời gian điều trị tại khoa đều thấp hơn điểm hài lòng tối thiểu (≥4 điểm). Các hoạt động của ĐD được đánh giá cao nhất là việc thực hiện các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng (3,98 điểm), xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường khi được báo (3,95 điểm). Các hoạt động của ĐD chưa được ĐTNC đánh giá cao là việc đưa NB đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng (3,85 điểm) và thời gian chờ đợi ĐD chăm sóc, thực hiện kỹ thuật quá lâu (3,77 điểm).

Các kết quả này hoàn toàn dễ hiểu khi mà gần như toàn bộ NB tại khoa Huyết học đều mắc các bệnh rất nặng, nguy cơ xảy ra biến chứng hoặc tử vong trong quá trình điều trị là rất cao. Do vậy ĐD luôn nỗ lực để có thể theo sát các diễn biến trên lâm sàng nhằm phối hợp bác sĩ điều trị. Có thể nói đây chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất của ĐD. Tuy nhiên, vẫn còn một vài thiếu sót của ĐD trong công tác hàng ngày như ghi chép hồ sơ bệnh án chậm, đôi khi thiếu thông tin theo đúng chỉ định của bác sĩ. Một điều dưỡng đã có trên 20 năm công tác tại khoa chia sẻ: *"mặc dù các bạn ĐD luôn tập trung theo dõi sát trên lâm sàng những NB nặng, mới vào viện nhưng trên hồ sơ bệnh án còn sơ sài do nhiều việc quá"* PVS ĐD 1.

Nói về hoạt động đón tiếp và hướng dẫn các thủ tục hành chính cho NB khi vào viện và ra viện, một ĐD cho biết: *"các bạn ĐD luôn có tinh thần đón tiếp niềm nở, dặn dò chu đáo. Nhưng bên cạnh đó, có thể do tâm lý ĐD lúc làm việc mệt mỏi, áp lực nhiều nên sự tiếp đón có phần sơ sài. Nếu cùng lúc nhận vào 1 – 2 NB thì ĐD có thể khai thác kỹ càng tiền sử bệnh để có lời khuyên, tư vấn; nếu một lúc nhận từ 5 đến 10 NB mới thì sự tiếp đón không được chu đáo lắm"* PVS ĐD 3.

Biểu đồ 3.3 mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh về thực hiện hoạt động chăm sóc của ĐD. Hai hoạt động có điểm trung bình thấp nhất là đưa NB đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng và thời gian chờ đợi ĐD chăm sóc, thực hiện kỹ thuật quá lâu cũng có tỷ lệ hài lòng thấp nhất (lần lượt là 70,9% và 66,9%). Tỷ lệ ĐTNC hài lòng về hoạt động thực hiện các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng nhanh chóng, chính xác là cao nhất (79,3%).

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ hài lòng về thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng



Tìm hiểu sự hài lòng của người bệnh về việc thực hiện các hoạt động chăm sóc điều dưỡng, chúng tôi nhận thấy hiện bệnh viện Chợ Rẫy đã ban hành đầy đủ các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng. NB cũng đánh giá rất cao tay nghề của cán bộ ĐD nhưng có thể do bận nhiều việc nên một số kỹ thuật chưa được thực hiện chu đáo. Một NB đánh giá: *"Nhìn chung các cô ĐD thực hiện thao tác rất nhanh nhẹn chính xác. Tuy nhiên nếu buổi sáng bắt đầu truyền dịch mà được thông kim trước để khỏi tắc đường truyền thì sẽ đỡ hơn cho bệnh nhân nhiều lắm. Chứ nếu đang truyền dịch mà tắc thì thật mệt mỏi"* (PVS NB2).

Trong các yếu tố trên thì hai hoạt động được đánh giá kém hơn cả là: hoạt động cấp phát thuốc hàng ngày khiến NB và hoạt động đưa NB đi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng (chụp chiếu, xét nghiệm) còn chậm trễ, mất nhiều công sức chờ

đợi. Bảng 3.4 thể hiện rõ quãng thời gian người bệnh phải chờ đợi để được nhận thuốc hàng ngày.

Bảng 3.5. Thời gian người bệnh phải chờ đợi

Thời gian người bệnh phải chờ đợi	Tần số (n=299)	Tỷ lệ (%)
Dưới 30 phút	215	71,9
Từ 30 phút – 2 giờ	75	25,1
Trên 2 giờ	9	3,0
Tổng số	**299**	**100**

Có 71,9% NB hài lòng về thời gian chờ đợi ĐD đến thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng (tiêm, truyền, cấp thuốc, tư vấn). Có 25,1% cho biết họ phải đợi từ 30 phút đến 1 giờ, cá biệt có 3% đánh giá họ đã chờ trên 2 giờ. Như vậy, tổng tỷ lệ NB phải chờ đợi trên 30 mỗi lần phát thuốc/ tiêm truyền là 28,1%. Con số này cho thấy tiến độ thực hiện công việc chuyên môn của ĐD còn chậm. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do số lượng ĐD thiếu nhiều so với số giường bệnh thực tế. ĐD trưởng khoa Huyết học đánh giá: *"Khoa được biên chế 60 giường bệnh nhưng luôn có từ 120 đến 130 NB nội trú. Luôn có từ 60 đến 70 NB phải nằm điều trị trên băng ca thay vì giường. Vì số biên chế ĐD chỉ được bệnh viện phân bổ cho 60 NB nên hiện ĐD phải làm việc với 200% khả năng của họ. NB phàn nàn về việc phải chờ đợi lâu là hoàn toàn xác đáng"* PVS ĐD Trưởng khoa Huyết học.

Một ĐD mới vào làm việc tại Khoa cho biết hoạt động cấp phát thuốc, tiêm truyền hàng ngày thường không thể làm nhanh gọn như các khoa khác do thường xuyên bị ngắt quãng bởi công tác nhận bệnh mới diễn ra liên tục, hoạt động tiêm truyền cũng cần thời gian lâu hơn bởi các loại thuốc đều rất đắt tiền và đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp hơn hẳn các khoa khác. Cô chia sẻ: *"Một lọ thuốc dùng hàng ngày có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, chính vì vậy cần sử dụng rất cẩn thận và tư vấn rất kỹ càng cho NB. Từ đó dẫn đến mất nhiều thời gian hơn để thực hiện"* PVS ĐD 5.

Sự trợ giúp của ĐD hiện nay về công tác ăn uống, đi lại vệ sinh cho NB còn hạn chế và chủ yếu chỉ hướng dẫn người nhà thực hiện, đây là tình hình chung.

Hiện ĐD của khoa: *"chưa thể chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh về ăn uống, đi lại, vệ sinh, như tại đơn vị hồi sức tích cực - ICU được"* (PVS ĐD 1).

Một ĐD khác chia sẻ: "*Do sự quá tải về khối lượng công việc và NB nên công tác chăm sóc NB về ăn uống, đi lại, vệ sinh chủ yếu là người nhà thực hiện, điều dưỡng chỉ hướng dẫn*" (PVS ĐD 2).

3.2.3. Hài lòng về mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng

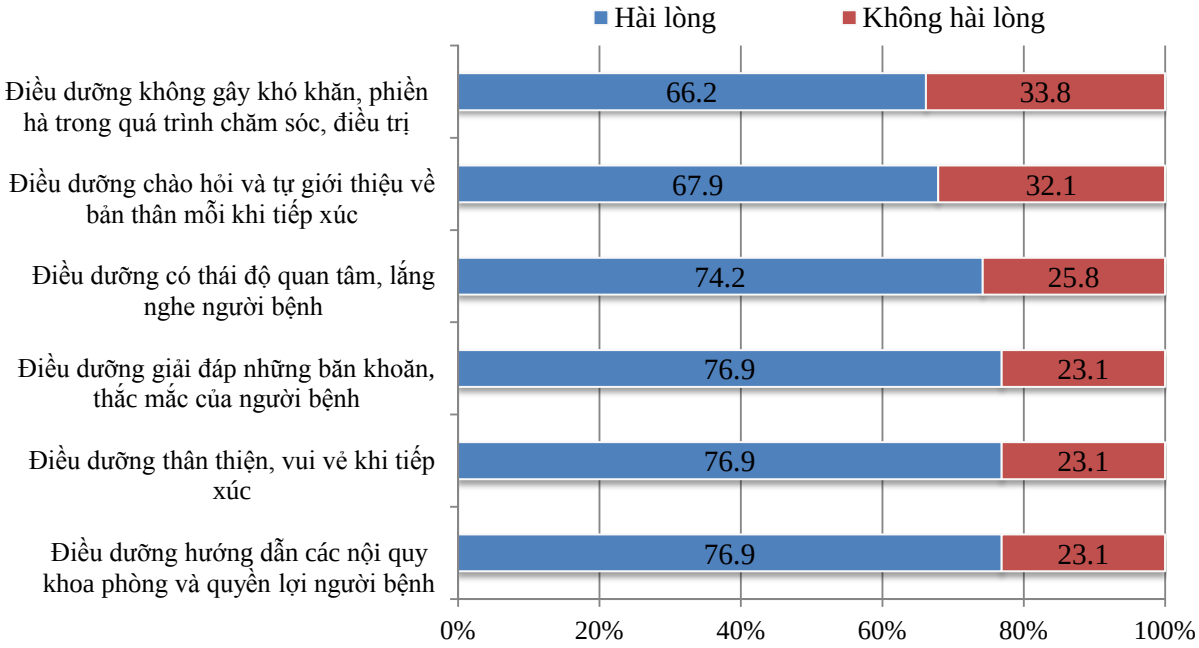
Bảng 3.6. Hài lòng về mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng (n=299)

Nội dung	Điểm trung bình
Hài lòng với sự hướng dẫn về các nội quy khoa phòng, bệnh viện và quyền lợi của người bệnh	3,93 ± 0,6
Hài lòng với sự thân thiện, vui vẻ của ĐD	3,93 ± 0,6
Hài lòng với sự giải đáp những băn khoăn thắc mắc của điều dưỡng	3,91 ± 0,6
Hài lòng về thái độ quan tâm, lắng nghe của ĐD	3,89 ± 0,6
Hài lòng về việc ĐD không gây khó khăn, phiền hà trong quá trình chăm sóc và điều trị tại khoa	3,80 ± 0,7
Hài lòng về việc ĐD chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc	3,79 ± 0,7

Điểm trung bình của 6 tiểu mục người bệnh đánh giá sự hài lòng về quan hệ, giao tiếp giữa điều dưỡng và NB trong thời gian điều trị tại khoa đều thấp hơn điểm hài lòng tối thiểu (≥4 điểm). Các hoạt động của ĐD được đánh giá cao là việc hướng dẫn các nội quy khoa phòng, bệnh viện và quyền lợi của người bệnh (3,93 điểm); ĐD thân thiện, vui vẻ khi giao tiếp (3,93 điểm). Các hoạt động của ĐD chưa được ĐTNC đánh giá tốt là việc chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc (3,79 điểm) và ĐD đôi khi gây khó khăn, phiền hà trong quá trình chăm sóc và điều trị (3,80 điểm).

Biểu đồ 3.4 mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh về quan hệ giữa ĐD và người bệnh. Hai hoạt động có điểm trung bình thấp nhất là việc chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc và đôi khi gây khó khăn, phiền hà trong quá trình chăm sóc và điều trị cũng có tỷ lệ hài lòng thấp nhất (lần lượt là 67,9% và 66,2%). Ở phía ngược lại, ĐTNC hài lòng nhất về hai hoạt động: hướng dẫn các nội quy khoa phòng, bệnh viện và ĐD tỏ ra thân thiện, vui vẻ khi giao tiếp (đều có tỷ lệ hài lòng là 76,9%).

Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ hài lòng về mối quan hệ người bệnh và điều dưỡng



Rõ ràng, vấn đề ĐD chào hỏi, tự giới thiệu bản thân mỗi khi tiếp xúc với NB là hết sức cần thiết. Giúp tạo ra không khí thân thiện, gần gũi giữa thầy thuốc và NB, từ đó làm cho NB hợp tác tốt hơn trong việc thực hiện các y lệnh. Tuy nhiên, một số ĐD thực sự đã chưa làm tốt quy định này. Một cán bộ ĐD thẳng thắn nhìn nhận: *"ĐD tại khoa thực hiện tốt quy trình kỹ thuật ĐD. Nhưng nếu quy về bài bản thì còn trường hợp bỏ bước. Có những bước như chào hỏi NB thì lại không làm đúng như được học"* PVS ĐD Trưởng khoa Huyết học.

Thấy được vấn đề này, Khoa Huyết học đã nỗ lực nhằm cải thiện khả năng giao tiếp của ĐD thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử. Một ĐD cho biết*: "Bệnh viện thường tổ chức tập huấn về quy tắc ứng xử giữa nhân*

viên bệnh viện với nhau và giữa nhân viên với NB. Từ đó, vấn đề giao tiếp đã dần có sự cải thiện, ít xảy ra tranh chấp không đáng có do hai bên hiểu sai vấn đề" PVS ĐD 3.

Bên cạnh đó, NB cũng cho rằng vẫn còn tình trạng ĐD gây khó khăn, phiền hà cho NB trong quá trình nằm viện thông qua tỷ lệ hài lòng ở tiểu mục này khá thấp (66,2%). Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề nằm ở năng lực chuyên môn của ĐD và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ và ĐD. Từ đó gây ra những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, khiến NB không hài lòng. Bác sĩ trưởng khoa chia sẻ: *"Một số ĐD trẻ thiếu kinh nghiệm nên mặc dù phát hiện các bất thường trên lâm sàng nhưng lại không báo cho bác sĩ kịp thời nên xảy ra sự cố đáng tiếc"* PVS BS Trưởng khoa Huyết học.

3.2.4. Hài lòng về việc tư vấn và giáo dục sức khỏe của điều dưỡng

Bảng 3.7. Hài lòng về việc tư vấn và giáo dục sức khỏe (n=299)

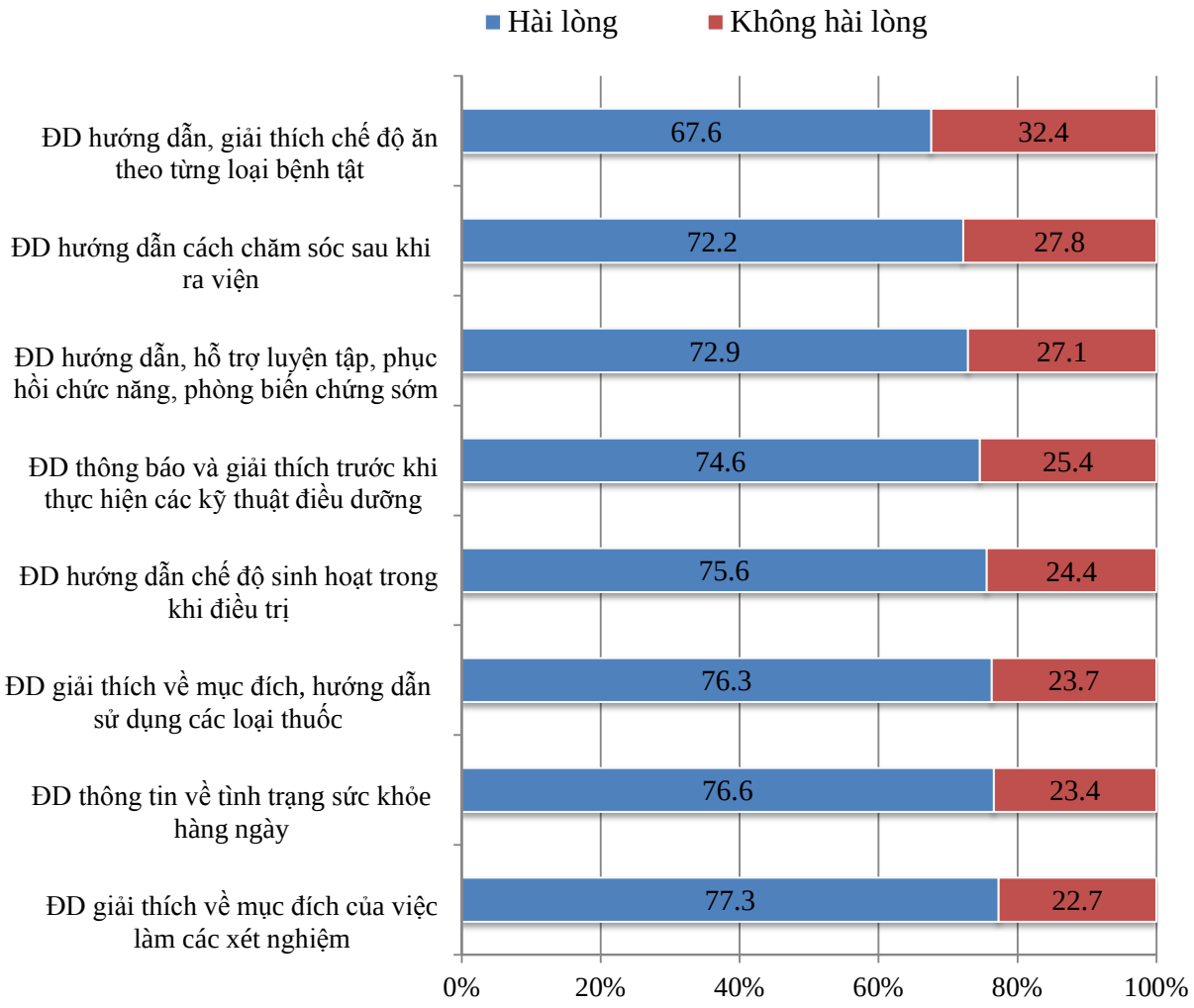
Nội dung	Điểm trung bình
Hài lòng với giải thích về mục đích của việc làm các xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm…) của ĐD	3,95 ± 0,6
Hài lòng với sự giải thích của ĐD đối với mục đích, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc	3,91 ± 0,6
Hài lòng với thông tin về tình trạng sức khỏe hàng ngày do ĐD cung cấp	3,91 ± 0,6
Hài lòng với sự thông báo và giải thích của ĐD trước khi thực hiện chăm sóc (tiêm, truyền, đặt sonde, lấy máu xét nghiệm…)	3,90 ± 0,6
Hài lòng với hướng dẫn chế độ sinh hoạt, lao động trong khi điều trị của ĐD	3,87 ± 0,6
Hài lòng với sự hướng dẫn cách chăm sóc sau khi ra viện (cách sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, phòng tái phát, biến chứng, thời gian tái khám)	3,84 ± 0,7
Hài lòng với hướng dẫn và hỗ trợ của ĐD trong việc luyện tập, phục hồi chức năng, phòng biến chứng sớm trong thời gian nằm viện	3,81 ± 0,6
Hài lòng với sự giải thích, hướng dẫn của ĐD đối với chế độ ăn theo từng loại bệnh tật	3,80 ± 0,7

Điểm trung bình của 8 tiểu mục người bệnh đánh giá sự hài lòng về hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong khi điều trị và sau khi xuất viện của ĐD đều thấp hơn điểm hài lòng tối thiểu (≥4 điểm). Các hoạt động của ĐD được đánh giá cao là: việc giải thích cho NB về mục đích của các xét nghiệm (xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm…) (3,95 điểm); giải thích về mục đích và hướng dẫn sử dụng các loại thuốc (3,91 điểm); thông tin về tình trạng sức khỏe hàng ngày cho NB (3,91 điểm). Các hoạt động của ĐD chưa được ĐTNC đánh giá tốt là việc hướng dẫn và

hỗ trợ NB luyện tập, phục hồi chức năng (3,81 điểm) và hướng dẫn chế độ ăn cho NB theo từng loại bệnh tật (3,80 điểm).

Biểu đồ 3.5 mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong khi điều trị và sau khi xuất viện. Hoạt động có điểm trung bình thấp nhất là hướng dẫn chế độ ăn cho NB theo từng loại bệnh tật cũng có tỷ lệ hài lòng thấp nhất (67,6%). Ở chiều ngược lại, người bệnh hài lòng nhất về các hoạt động như: giải thích về mục đích làm các xét nghiệm (77,3% hài lòng); thông tin cho NB về tình trạng sức khỏe hàng ngày (hài lòng 76,6%); giải thích về tác dụng và hướng dẫn sử dụng thuốc (hài lòng 76,3%).

Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ hài lòng về tư vấn và giáo dục sức khỏe



Tìm hiểu về công tác tư vấn, GDSK của ĐD, chúng tôi nhận thấy việc thực hiện công tác này còn tồn tại nhiều vấn đề. Hiện công tác tư vấn, GDSK hầu hết do các bác sĩ thực hiện khi thăm khám người bệnh hàng ngày, công tác này chưa được ĐD tại khoa quan tâm và chủ động thực hiện thể hiện vai trò độc lập của người điều dưỡng. Nhìn nhận về vấn đề này lãnh đạo khoa đã chia sẻ: "*điều dưỡng cần được huấn luyện liên tục về những bệnh lý, về chăm sóc dù những y lệnh là của bác sĩ. ĐD cần được huấn luyện những loại thuốc nào cần dùng trên NB nào, tác dụng phụ ra sao. Đôi khi ĐD thực hiện y lệnh thuốc nhưng không biết về các tác dụng phụ có thể xảy ra. Từ đó không tư vấn kịp thời cho NB, lúc xảy ra phản ứng bất lợi cho NB thì đã muộn"*.

Vấn đề tư vấn dinh dưỡng hợp lý cho NB cũng hết sức quan trọng, có vai trò quyết định đến hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, dường như hoạt động này vẫn chưa được ĐD quan tâm đúng mức. Tại Khoa Huyết học, người bệnh chủ yếu tự tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm với những người mắc bệnh giống mình đang điều trị nội trú. Nhiều NB cho biết: *"Cứ đến bữa thì tôi nhận phần ăn từ nhà bếp, có sao ăn vậy chứ cũng không có ý kiến gì vì nghĩ rằng các bác sĩ đã tính toán hợp lý rồi."* PVS NB 3.

Một NB khác nhìn nhận rằng việc tư vấn giáo dục sức khỏe của ĐD tại khoa chưa thực chất. Chủ yếu là NB hỏi gì thì ĐD trả lời nấy chứ ĐD chưa chủ động hướng dẫn cho từng trường hợp cụ thể. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân bao gồm: hoạt động tư vấn GDSK tại khoa Huyết học hiện chỉ mới tập trung chủ yếu ở nhóm NB cần hóa trị; chính ĐD cũng thiếu kiến thức sâu để có thể tư vấn rõ ràng, cặn kẽ cho NB; bản thân NB vì sợ bị trù dập, bỏ rơi nên cũng không dám có ý kiến với cán bộ y tế và tình trạng quá tải nghiêm trọng khiến ĐD chỉ đủ thời gian để thực hiện các kỹ thuật ĐD và hành chính chứ chưa ưu tiên cho các hoạt động khác. Điều dưỡng Trưởng khoa cho biết: *"Về giáo dục sức khỏe cho NB, hiện khoa có tổ chức lồng ghép trong buổi sinh hoạt Hội đồng bệnh nhân hàng tuần, chủ yếu về nhóm hóa trị. Với những bệnh khác, do ĐD cũng còn thiếu thông tin nên việc hướng dẫn cũng còn mù mờ, chủ yếu vẫn là hướng dẫn người bệnh uống thuốc theo toa."* PVS

ĐD Trưởng khoa Huyết học. Tuy nhiên, chính bản thân các buổi sinh hoạt này cũng không diễn ra đều đặn do vướng lịch công tác chuyên môn hoặc NB không được tham gia các buổi sinh hoạt này bởi vào viện không đúng ngày diễn ra buổi truyền thông.

Trên cơ sở đó, ĐD trưởng đề xuất*: "ĐD cần được tập huấn về cách hướng dẫn cho từng nhóm người bệnh, không chỉ riêng ĐD trưởng mà tất cả ĐD đều cần được tập huấn"* PVS ĐD Trưởng khoa Huyết học. Bên cạnh đó, việc: *"tăng tần suất tổ chức các buổi sinh hoạt, truyền thông để cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn cho NB là rất cần thiết."* PVS ĐD 4.

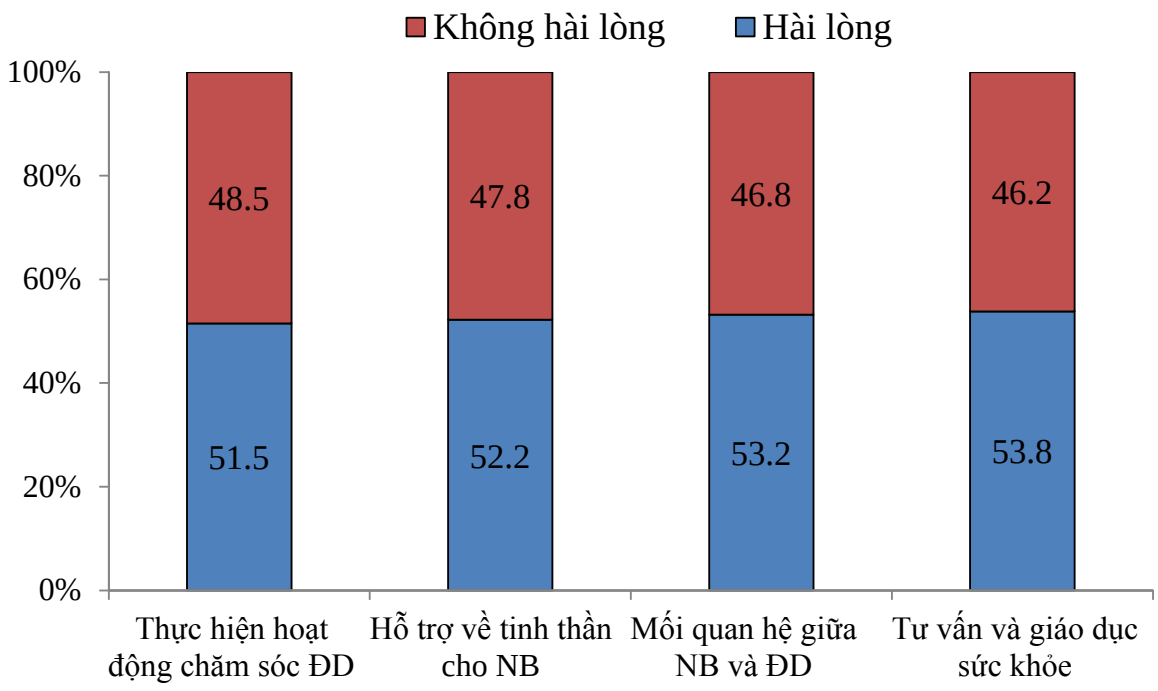
3.2.5. Tỷ lệ hài lòng xét theo từng yếu tố

Bảng 3.8. Bảng tổng hợp sự hài lòng theo từng yếu tố (n=299)

Yếu tố	Điểm hài lòng Tiêu chuẩn	Điểm hài lòng trung bình thực tế
Hỗ trợ về tinh thần cho NB	20	19,3 ± 3,0
Thực hiện hoạt động chăm sóc ĐD	40	34,9 ± 4,7
Mối quan hệ giữa NB và ĐD	24	23,2 ± 3,2
Tư vấn và giáo dục sức khỏe	32	30,9 ± 4,6

Bảng 3.7 cho thấy khi xét ở cả 4 nhóm hoạt động của điều dưỡng, chưa có nhóm hoạt động nào được người bệnh đánh giá thực sự tốt với mức điểm đạt mức 4 đến 5 điểm cho mỗi câu hỏi, mặc dù điểm hài lòng ở từng hoạt động đã tiệm cận với tiêu chuẩn đánh giá. Riêng nhóm hoạt động thực hiện chăm sóc của điều dưỡng có điểm đánh giá hài lòng trung bình còn cách khá xa so với mức lý thuyết (34,9 so với 40) mà nguyên nhân chủ yếu là do NB phải chờ đợi lâu mới đến lượt được phát thuốc/ tiêm/ truyền, ….

Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh theo từng yếu tố



Biểu đồ 3.6 mô tả rõ hơn tỷ lệ người bệnh hài lòng với từng nhóm hoạt động điều dưỡng. Do có điểm trung bình thấp nên nhóm hoạt động: "Thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng" có tỷ lệ hài lòng thấp nhất trong 4 nhóm (51,5%). Các nhóm hoạt động khác có tỷ lệ hài lòng cao hơn nhưng không quá chênh lệch (tỷ lệ hài lòng dao động trong khoảng hẹp 51,5% đến 53,8%).

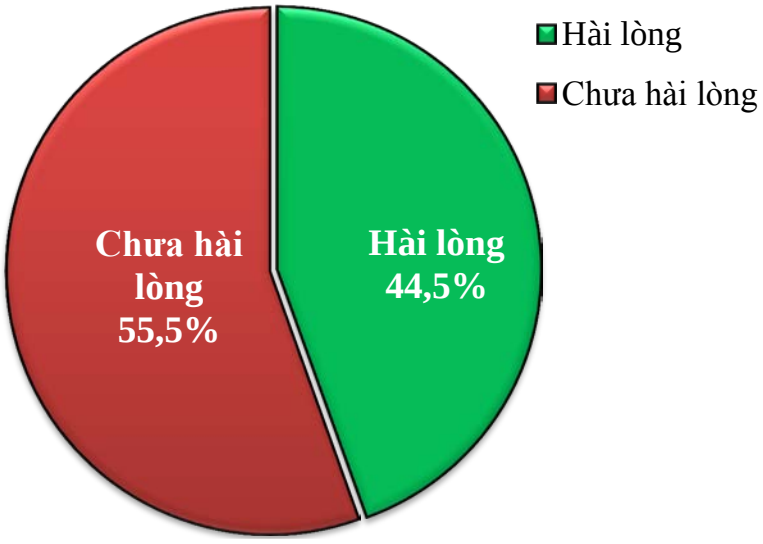
3.2.6. Sự hài lòng chung của người bệnh

Bảng 3.9. Sự hài lòng chung của người bệnh (n=299)

Nội dung	Điểm hài lòng chung tiêu chuẩn	Điểm hài lòng chung trung bình
Sự hài lòng chung về công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Huyết học	112	108,5 ± 14,6

Kết quả này được tính toán dựa trên cơ sở sự hài lòng của NB về 4 yếu tố: hỗ trợ tinh thần, thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng, mối quan hệ của người bệnh và điều dưỡng, tư vấn và giáo dục sức khỏe trong quá trình điều trị tại khoa. Điểm hài lòng chung trung bình của công tác chăm sóc điều dưỡng là 108,5 còn thấp hơn so với tiêu chuẩn là 112 điểm.

Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh



Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh về các hoạt động của điều dưỡng hiện đạt 44,5% và tỷ lệ chưa hài lòng là 55,5%.

3.3. Một số yếu tố liên quan tới sự hài lòng chung của người bệnh

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học với sự hài lòng chung

Yếu tố liên quan	Hài lòng chung		OR (95%CI)	p
	Hài lòng n (%)	Không hài lòng n (%)		
Giới tính				
Nam	65 (45,5)	78 (54,5)	1,07 (0,68 – 1,70)	0,74
Nữ	68 (43,6)	88 (56,4)		
Nhóm tuổi				
≤ 60	111 (42,7)	149 (57,3)	0,57 (0,29 – 1,13)	0,10
> 60	22 (56,4)	17 (43,6)		
Dân tộc				
Kinh	119 (43,6)	154 (56,4)	0,66 (0,29 – 1,48)	0,31
Khác	19 (53,8)	12 (46,2)		
Trình độ học vấn				
THCS trở xuống	64 (42,1)	88 (57,9)	0,82 (0,52 – 1,29)	0,40
THPT trở lên	69 (46,9)	78 (53,1)		
Nghề nghiệp				
Nông dân	64 (43,0)	85 (57,0)	0,88 (0,56 – 1,39)	0,59
Nghề nghiệp khác	69 (46,0)	81 (54,0)		
Tình trạng hôn nhân				
Ly hôn, ly thân, góa	3 (33,3)	6 (66,7)	0,61 (0,15 – 2,50)	0,49
Khác	130 (44,8)	160 (55,2)		
Kinh tế hộ gia đình				
Hộ nghèo	47 (53,4)	41 (46,6)	1,66 (1,01 - 2,74)	**0,04**
Hộ không nghèo	86 (40,8)	125 (59,2%)		

Qua khảo sát đã tìm thấy mối liên quan giữa điều kiện kinh tế hộ gia đình và sự hài lòng chung. ĐTNC thuộc diện hộ nghèo có xu hướng hài lòng cao hơn 1,66 lần so với nhóm không thuộc diện hộ nghèo. Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng chung và các yếu tố nhân khẩu học khác (p>0,05).

Bảng 3.11. Mối liên quan giữa các đặc điểm y tế với sự hài lòng chung (n=299)

Yếu tố liên quan	Hài lòng chung		OR (95%CI)	p
	Hài lòng n (%)	Không hài lòng n (%)		
Bảo hiểm y tế (BHYT)				
Có BHYT	128 (45,4)	154 (54,6)	1,99 (0,69 – 5,81)	0,19
Không có BHYT	5 (29,4)	12 (70,6)		
Thời gian nằm viện				
≤ 7 ngày	46 (38,7)	73 (61,3)	0,67 (0,42 – 1,08)	0,09
> 7 ngày	87 (48,3)	93 (51,7)		
Tình trạng bệnh tật				
Mắc bệnh máu ác tính	83 (49,7)	84 (50,3)	1,62 (1,02 – 2,58)	**0,04**
Không mắc bệnh ác tính	50 (37,9)	82 (62,1)		
Tình trạng khi vào viện				
Cấp cứu	77 (44,8)	95 (55,2)	1,03 (0,65 – 1,63)	0,90
Không cấp cứu	56 (44,1)	71 (55,9)		
Số lần vào Khoa Huyết học để điều trị nội trú trong một năm qua				
Trên 2 lần	39 (58,2)	28 (41,8)	2,05 (1,18 – 3,56)	**0,01**
Từ 1 - 2 lần	94 (40,5)	138 (59,5)		

Yếu tố số lần vào khoa để điều trị nội trú trong một năm qua có liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng chung. Nhóm người bệnh có số lần vào khoa điều trị trên 2 lần hài lòng cao gấp 2,05 lần so với nhóm người bệnh chỉ mới được điều trị tại khoa từ 1 đến 2 lần (p=0,01).

Yếu tố tình trạng bệnh tật có liên quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng chung. Nhóm người bệnh mắc các bệnh lý ác tính về huyết học *(ung thư máu, ung thư hạch, xuất huyết giảm tiểu cầu)* hài lòng cao gấp 1,62 lần so với nhóm người bệnh mắc các bệnh lý huyết học khác (p=0,04).

Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng chung và các đặc điểm khác như: người bệnh có mua bảo hiểm y tế hay không, tình trạng lúc vào viện là cấp cứu hay tái khám, thời gian nằm viện.

Bảng 3.12. Phân tích hồi quy Logistic đa biến các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung (n = 299)

Yếu tố	Hệ số hồi quy (B)	Sai số chuẩn (SE)	Mức ý nghĩa (p)	OR hiệu chỉnh	95% CI	
Điều kiện kinh tế hộ gia đình						
Hộ không nghèo (*)	-	-	-	1	-	-
Hộ nghèo	0,539	0,261	**0,039**	1,71	1,02	2,85
Tình trạng bệnh tật						
Không mắc bệnh ác tính (*)	-	-	-	1	-	-
Mắc bệnh ác tính	0,456	0,241	0,059	1,57	0,98	2,53
Số lần nhập viện trong 12 tháng gần đây						
Từ 1 đến 2 lần (*)	-	-	-	1	-	-
Trên 2 lần	0,702	0,286	**0,014**	2,01	1,15	3,53

Ghi chú: Cỡ mẫu phân tích: n=299 ; (*): nhóm so sánh; (-): nhóm không áp dụng.

Kiểm định Hosmer và Lemeshow cho sự phù hợp của mô hình:

$\chi^2 = 0,467;\ df = 5;\ p = 0,993$

Các yếu tố có liên quan (p<0,05) có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng chung của người bệnh trong phân tích đơn biến được chọn để đưa vào mô hình phân tích hồi quy logistic đa biến. Các biến này bao gồm: điều kiện kinh tế hộ gia đình, tình trạng bệnh tật và số lần nhập viện trong 1 năm qua.

Bảng 3.11 cho thấy có 2/3 biến số được đưa vào mô hình hồi quy có liên quan có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc là sự hài lòng chung. Cụ thể: những người bệnh thuộc diện hộ nghèo có xu hướng hài lòng hơn gấp 1,71 lần so với những NB không thuộc diện hộ nghèo (p=0,039). Nhóm những người bệnh có số lần nhập viện điều trị trên 2 lần trong năm có xu hướng hài lòng hơn gấp 2,01 lần so với những NB mới vào viện từ 1 đến 2 lần (p=0,014). Mô hình chỉ ra không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng bệnh tật của NB và sự hài lòng chung.

Chương 4. BÀN LUẬN

4.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Trong 299 người bệnh tại khoa Huyết học tham gia nghiên cứu, tỷ lệ nam nhiều hơn nữ khoảng 5%. Sự chênh lệch này là không đáng kể và từ đó, việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh ở cả hai giới sẽ cân bằng và hài hòa, giảm được sai số do nhìn nhận thiên lệch ở mỗi giới. Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý trên 188 người bệnh nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng có tỷ lệ nam/nữ khá tương đồng (54%/ 46%) [19]. Tuy nhiên, nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh (2012) tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy tỷ lệ nam nhiều hơn nữ (64% và 36%) [22]. Theo nghiên cứu của Mehrnoosh Akhtari-Zavare tại 10 Bệnh viện ở Tehran, Iran; tỷ lệ NB nam nhiều hơn tỷ lệ NB nữ (52,3% và 60,9%) [26].

Tuổi của ĐTNC biến động từ 18 đến 93 tuổi với tuổi trung bình là 44 và nhóm từ 30 đến 60 tuổi là nhiều nhất chiếm 64,9%. Kết quả này cho thấy độ tuổi của ĐTNC khá trẻ nếu so sánh với các nghiên cứu khác. Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý cho thấy độ tuổi trung bình là 56 tuổi; nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu tại Bệnh viện Banpong, Thái Lan cho thấy nhóm tuổi từ 50 trở lên mới chiếm đa số (49,1%) [46] [19]. Thực ra vấn đề này là hoàn toàn hợp lý vì ĐTNC của nghiên cứu này chủ yếu là NB ung thư máu, ung thư hạch và các bệnh lý máu bẩm sinh, khác với các nghiên cứu kể trên vốn được thực hiện tại các bệnh viện đa khoa và điều trị các bệnh thông thường. Vì người bệnh trên 60 tuổi thường không được chỉ định hóa trị mà chỉ điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng nên ít được chỉ định điều trị nội trú. Chính vì tuổi trung bình cao (xấp xỉ 44 tuổi) nên đa số ĐTNC đều đã lập gia đình (chiếm 78,3%).

Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối ở phía Nam, nhận toàn bộ NB thuộc các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau chuyển tuyến về. Vì vậy đa số NB tại đây là dân ngoại tỉnh, nhóm này chiếm tỷ lệ tới 78,3% so với nhóm cư trú tại TP. Hồ Chí Minh (21,7%). ĐTNC chủ yếu là người Kinh (chiếm 91,3%), tổng tỷ lệ các dân tộc khác chỉ là 8,7% gồm đa phần là người Hoa.

Trình độ học vấn của ĐTNC đa số ở mức trung học, còn lại là nhóm có trình độ từ cao đẳng trở lên (5,1%). Gần một nửa số ĐTNC (49,8%) là nông dân; 26,8% là viên chức/ công nhân và 5,4% là học sinh, sinh viên. Số ĐTNC có thu nhập trung bình hàng tháng thuộc diện hộ nghèo chiếm 27,8%. Những con số này cho thấy đa số ĐTNC có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại mắc bệnh nan y nên có thể được xem là nhóm yếu thế trong xã hội.

Phần đông NB nhập viện trong tình trạng cấp cứu (57,5%) và 42,5% còn lại là người bệnh tái khám hoặc đang ở trong các đợt hóa trị, đến dùng thuốc theo lịch hẹn tại phòng khám ngoại trú và ra về trong ngày. Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ giữa các nhóm mắc bệnh lý huyết học khác nhau.

Đa số người bệnh nằm điều trị tại Khoa Huyết học đều có BHYT (chiếm 94,3%); tỷ lệ này là cao hơn so với một số nghiên cứu khác thực hiện ở các bệnh viện đa khoa. Do đặc thù của các bệnh lý huyết học có chi phí điều trị đắt đỏ, một đợt điều trị trong 10 ngày có thể tốn khoảng 1 tỷ đồng. Chính vì vậy đa số người bệnh đều chủ động mua BHYT trước khi nhập viện bởi các thuốc điều trị tại khoa được BHYT thanh toán.

Số ngày nằm điều trị của NB tại khoa từ 8-14 ngày chiếm 49,8%. Số lần nhập viện trong năm qua là một lần chiếm 45,5% và từ 2 đến 5 lần chiếm 46,5%. Tỷ lệ tái khám cao là do các bệnh lý huyết học có quá trình điều trị lâu dài, phức tạp, phải quay lại bệnh viện thường xuyên để theo dõi diễn biến bệnh. Việc quay lại khoa thường xuyên khiến người bệnh có nhiều thời gian làm quen với điều kiện chăm sóc tại khoa, các thủ tục hành chính, từ đó có cảm nhận chính xác hơn về hoạt động của điều dưỡng cũng như các cán bộ y tế khác. Nhưng rõ ràng, quá trình điều trị dài, tốn kém nhưng hiệu quả thấp, đôi khi chỉ là duy trì thể trạng đã làm người bệnh/ người nhà trở nên mệt mỏi, khó tính hoặc yêu cầu cao hơn so với NB chỉ mắc các bệnh lý thông thường tại các bệnh viện đa khoa khác.

Đa số người bệnh là nông dân (49,8%), công nhân (26,8%) và đang trong độ tuổi lao động nên đã làm ảnh hưởng mạnh đến thu nhập của họ. Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý, tỷ lệ người bệnh là cán bộ hưu trí chiếm 44%, nghiên cứu của

Nguyễn Bá Anh có tỷ lệ nông dân chỉ là 26,2% và công nhân là 13,8% [1] [19]. Vì vậy, tỷ lệ người bệnh thuộc diện hộ nghèo lên đến 27,8%. Được đánh giá là hộ nghèo theo chuẩn của Chính phủ (giai đoạn 2016 – 2010) với thu nhập từ 700 nghìn đồng ở khu vực nông thôn đến 900 nghìn đồng tại khu vực thành thị thì gia đình đó đã rất khó khăn [9]. Thế nên nhiều NB trong nghiên cứu này có thể được xem là kiệt quệ về tài chính. Yếu tố này tác động đến tâm lý người bệnh, qua đó ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh khi đánh giá công tác điều dưỡng.

4.2. Sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng

4.2.1. Sự hài lòng của người bệnh về yếu tố chăm sóc tinh thần

Theo kết quả nghiên cứu, chỉ có 52,2% số người bệnh đánh giá hài lòng về công tác chăm sóc hỗ trợ tinh thần của điều dưỡng. Tỷ lệ này thấp hơn tất cả các nghiên cứu cùng chủ đề mà chúng tôi tham khảo: nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh tại bệnh viện Việt Đức là 83%, nghiên cứu của Bùi Bích Ngà tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là 63,9%, nghiên cứu của Nguyễn Thùy Châu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (2014) là 83,2% [1] [8] [20]. Như vậy, rõ ràng sự hài lòng của người bệnh tại khoa Huyết học là thấp hơn rất nhiều so với báo cáo tại các bệnh viện khác. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề là điều dưỡng không có đủ thời gian để thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh. Với tình trạng nhân lực hiện có, việc chỉ vừa hoàn thành các hoạt động chuyên môn và hành chính đã chiếm trọn thời gian của điều dưỡng. Chính vì vậy, dù kết quả định tính cho thấy điều dưỡng rất thông cảm và thương yêu NB bởi ai cũng hiểu rằng đã vào khoa Huyết học điều trị thì đều mắc bệnh nan y. Nhưng cũng phải nói người bệnh chưa cảm nhận được rõ ràng sự chăm sóc về tinh thần của điều dưỡng là chính xác. Hiện tại khoa Huyết học, việc chăm sóc và hỗ trợ tinh thần chỉ mới được thực hiện trên những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc một số trường hợp đặc biệt khác.

Một rào cản khác khiến điều dưỡng chưa tích cực chăm sóc, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh là bởi tính đặc thù của các bệnh huyết học. Điều dưỡng không dễ dàng để có thể thông báo, từ đó chia sẻ với người bệnh về bệnh lý mà họ đang mắc,

ngược lại trong một số trường hợp, điều dưỡng còn phải che giấu thông tin thật để tránh gây sốc cho người bệnh. Các quy định pháp lý về vấn đề cung cấp thông tin về bệnh tật đã rất rõ ràng và vì vậy điều dưỡng thường bỏ qua vấn đề này. Chính vì vậy, người bệnh đánh giá điều dưỡng chưa biết: "động viên, an ủi, khích lệ tinh thần cho người bệnh" chiếm tỷ lệ cao nhất (67,2%) hoặc "cảm thông, chia sẻ về bệnh tật với người bệnh" chiếm tỷ lệ (67,8).

Ngoài các nguyên nhân khách quan kể trên, có thể thấy trong công tác chăm sóc tinh thần, người điều dưỡng vẫn chưa hình thành được tư tưởng chủ động và xây dựng được thói quen động viên, an ủi, thăm hỏi người bệnh hàng ngày. Công tác này mới chỉ thể hiện được qua việc hỏi về tình hình diễn biến bệnh hàng ngày, vốn hơi nghiêng về chuyên môn điều dưỡng hơn. Hiện chỉ có hoạt động sắp xếp giường bệnh là được người bệnh đánh giá hài lòng nhất bởi nó khá đơn giản và đây là công tác bắt buộc phải làm khi nhận bệnh. Qua đây cũng nhận thấy rằng ĐD tại khoa chưa thực sự biết cách chăm sóc về tinh thần cho NB một cách khoa học và khéo léo. Điều này đòi hỏi bệnh viện phải đào tạo, cải thiện kỹ năng chăm sóc tinh thần của ĐD cũng như xem đây là mục tiêu phấn đấu của khoa, bệnh viện. Có như vậy mới dần thay đổi được nhận thức của ĐD xưa nay vốn chỉ quan niệm chỉ cần thực hiện chính xác y lệnh và viết đầy đủ bệnh án là được.

Nhu cầu chăm sóc tinh thần của những người bệnh ở khoa Huyết học cao hơn nhiều so với những người bệnh trong các chuyên khoa khác. Do đó nếu làm tốt công tác động viên, an ủi, hỏi thăm và theo dõi tình trạng sức khỏe… sẽ giúp người bệnh yên tâm, tuân thủ điều trị và chắc chắn sẽ hài lòng hơn bởi bầu không khí nghĩa tình trong bệnh viện.

4.2.2. Sự hài lòng của người bệnh về thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với việc thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng chiếm 51,5%, tỷ lệ này thấp nhất trong cả bốn nhóm hoạt động của điều dưỡng được đánh giá trong nghiên cứu này. Tương tự như hoạt động chăm sóc và hỗ trợ tinh thần, tỷ lệ hài lòng về hoạt động chăm sóc điều dưỡng trong nghiên cứu này khá thấp so với các nghiên cứu tương tự. Theo nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh

có 78,2% hài lòng; theo nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu tại Bệnh viện Banpong, Thái Lan có 55,4% người bệnh hài lòng; theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý có 64,4% người bệnh hài lòng [1] [19] [46].

Trong các hoạt động chăm sóc điều dưỡng, việc thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chính xác, nhanh chóng và đến xử trí các bất thường của người bệnh được người bệnh hài lòng nhiều hơn so với các hoạt động khác, đặc biệt hoạt động cấp thuốc, tiêm truyền hàng ngày bị người bệnh phản hồi là chậm, khiến họ phải chờ đợi lâu. Có thể thấy đây là đặc thù không chỉ tại Khoa Huyết học mà là tình trạng chung của các bệnh viện. Với một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối như tại Chợ Rẫy, tay nghề của điều dưỡng không phải là vấn đề mà người bệnh có thể phàn nàn. Tương tự, do tại khoa chủ yếu là người bệnh nặng nên việc theo dõi sát các biểu hiện, chỉ số đặc trưng của bệnh là rất sát sao để có xử trí kịp thời. Chính việc thiếu nhân lực khiến điều dưỡng không thể hoàn thành công tác phát thuốc, hướng dẫn sử dụng, tiêm, truyền và các kỹ thuật khác kịp thời. Người bệnh phải chờ đợi là hiển nhiên, đặc biệt là người bệnh tại các dãy phòng cuối. So sánh với các nghiên cứu khác cho thấy: theo Nguyễn Ngọc Lý, có 89,4% người bệnh cho rằng các điều dưỡng viên thực hiện đạt các quy trình kỹ thuật; trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh có 89,9% và thấp hơn của Phạm Anh Tuấn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (98,3%) [1] [19] [24]. Khoa Huyết học luôn trong tình trạng quá tải và có nhiều sinh viên thực tập nên các điều dưỡng đôi khi giao cho các sinh viên thực hiện các kỹ thuật mà không có giám sát nên cũng gây sự khó chịu nơi người bệnh, đặc biệt là khi người bệnh ở khoa luôn am hiểu rất sâu sắc về bệnh tật của mình và các kỹ thuật điều trị do đã điều trị lâu dài.

Việc sử dụng thuốc và công khai danh mục thuốc cho NB được người bệnh khá hài lòng (73,2%). Trước khi phát thuốc hoặc tiêm, truyền, điều dưỡng luôn giải thích và hướng dẫn theo dõi dùng thuốc cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh mới vào viện. Tuy nhiên rất ít trường hợp điều dưỡng hỗ trợ cho người bệnh uống thuốc tại chỗ được mà chỉ phát cho người bệnh hay người nhà, từ đó không thể theo dõi xem người bệnh có uống thuốc đúng hướng dẫn hay không.

Sự trợ giúp của điều dưỡng đối với người bệnh khi thực hiện các hoạt động như: hỗ trợ ăn uống, đi lại, vệ sinh thân thể, đại tiểu tiện… tại khoa có tỷ lệ hài lòng chiếm 74,9%. Công tác này chủ yếu là do người nhà thực hiện với sự hướng dẫn của điều dưỡng. Đây là tình trạng chung không chỉ tại khoa Huyết học mà còn tồn tại ở các khoa khác trừ các trường hợp vừa được hóa trị, xạ trị cần nằm phòng vô trùng do suy giảm miễn dịch và người nhà không được tiếp xúc. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện công đều không thể thực hiện được công tác này, do tình trạng quá tải trong công việc và quá tải bệnh nhân. Điều này giống với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Bích Lưu tại bệnh viện Banpong, Thái Lan cũng cho rằng một số hoạt động của điều dưỡng cần được cải thiện, chẳng hạn như việc hỗ trợ người bệnh thực hiện một số hoạt động (tắm, gội đầu, vệ sinh…) trong bệnh viện [46]. Trong nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà, công tác chăm sóc, hỗ trợ người bệnh nặng vệ sinh cá nhân hàng ngày chủ yếu do người nhà chăm sóc chiếm 86,3% [20]. Đây là tình trạng chung không chỉ tại khoa Huyết học – Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn ở các bệnh viện khác, việc hỗ trợ về vệ sinh cá nhân hàng ngày chủ yếu là do người nhà người bệnh thực hiện.

4.2.3. Sự hài lòng của người bệnh về yếu tố mối quan hệ với điều dưỡng

Tỷ lệ người bệnh hài lòng về mối quan hệ với điều dưỡng là 53,2%, thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý là 70,7% [19]. Lý do chính khiến tỷ lệ hài lòng của người bệnh về mối quan hệ với điều dưỡng còn thấp là sự quá tải về số lượng người bệnh trong khi nhân lực điều dưỡng còn rất thiếu. Ngoài ra do một số điều dưỡng đi học, nghỉ chế độ thai sản nên nhân lực điều dưỡng vốn đã thiếu nay lại càng thiếu hơn; những người đi làm phải phụ trách phần công việc cho người đang nghỉ nên thường chỉ đủ thời gian thực hiện y lệnh (cấp phát thuốc và tiêm, truyền), ghi chép hồ sơ bệnh án, viết phiếu chăm sóc hoặc đưa người bệnh đi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Người điều dưỡng sau khi tiếp nhận người bệnh phải hướng dẫn nội quy khoa/ phòng của bệnh viện, các quyền lợi của người bệnh để người bệnh thấy rằng họ được quan tâm, chăm sóc, từ đó họ sẽ hợp tác và tuân thủ điều trị hơn. Hiện tỷ lệ

này chỉ đạt 53,2% cho thấy điều dưỡng cần thực hiện nghiêm túc công việc theo bảng mô tả công việc, theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, điều dưỡng phải xây dựng thói quen chào hỏi, giới thiệu tên khi giao tiếp với người bệnh. Điều này khiến người bệnh cảm thấy được tôn trọng và khi cần nhờ can thiệp hoặc xử trí có thể tìm được chính xác điều dưỡng phụ trách chăm sóc cho mình. Hiện tại, đa số điều dưỡng chưa thực hiện được hoạt động này một cách bài bản như đã được đào tạo. Mặc dù bệnh viện Chợ Rẫy đã có tổ chức một số lớp học về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho toàn bộ nhân viên nhưng kết quả nghiên cứu chứng tỏ rằng các khóa học này chưa đạt hiệu quả như mong đợi, tỷ lệ người bệnh không hài lòng về vấn đề chào hỏi của điều dưỡng còn cao (33,8%).

Bên cạnh đó, việc thiếu kỹ năng giao tiếp và thiếu thời gian dẫn đến tình trạng vội vàng, truyền đạt thông tin thiếu chính xác, dễ gây hiểu nhầm cho người bệnh. Một số vụ việc tranh cãi to tiếng đã xảy ra giữa người nhà bệnh nhân và điều dưỡng mà nguyên nhân đến từ việc người nhà chưa hiểu những hướng dẫn của điều dưỡng nên dẫn đến thực hiện sai các thủ tục hành chính, gây thời gian chờ đợi kéo dài.

Do đó, trong thời gian tới bệnh viện Chợ Rẫy cần tăng cường công tác đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế nói chung và điều dưỡng nói riêng nhằm cải thiện năng lực này.

4.2.4. Sự hài lòng của người bệnh về hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong thời gian điều trị và sau khi ra viện

Trong các hoạt động chính của điều dưỡng, hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong thời gian điều trị và sau khi ra viện có tỷ lệ hài lòng cao nhất (53,8%). Dù tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với công bố tại các bệnh viện khác nhưng vẫn có thể xem đây là điểm sáng về hoạt động của điều dưỡng tại khoa Huyết học.

Theo công bố của Nguyễn Ngọc Lý, có 66,5% người bệnh hài lòng với sự tư vấn và giáo dục sức khỏe của điều dưỡng; so với nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh có 80% người bệnh hài lòng; theo Nguyễn Bích Lưu có khoảng 73,7% hài lòng [1]

[19] [46]. Một kết quả nghiên cứu khác của Bùi Bích Ngà tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho thấy có 49,6% người bệnh đánh giá công tác tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe đạt yêu cầu [20].

Qua phỏng vấn chúng tôi thấy đa số người bệnh chưa hài lòng vì chưa được tư vấn và giáo dục sức khỏe hoặc được tư vấn nhưng chưa đầy đủ và rõ ràng, đặc biệt là tư vấn về chế độ dinh dưỡng, tập luyện phục hồi chức năng trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện.

Công tác giáo dục sức khỏe phải là hết sức quan trọng và phải được thực hiện ngay từ trong cộng đồng. Đối với người bệnh nội trú rất cần có những kiến thức y tế cơ bản về bệnh tật của mình và cách phòng tránh bệnh, luyện tập phòng biến chứng. Điều dưỡng không thể luôn ở cùng người bệnh, do đó cần phải hướng dẫn người bệnh và người nhà cách tự chăm sóc khi tình trạng sức khỏe đã tạm ổn định. Điều này giúp cho họ có kiến thức để tự chăm sóc bản thân và phòng các biến chứng; đến khi ra viện người bệnh và người nhà có thể tự chăm sóc được cho mình.

Đối với người bệnh ra viện, hoạt động truyền thông giúp họ có đủ kiến thức và kỹ năng có thể tự chăm sóc cho bản thân khi về nhà. Tự phát hiện sớm các triệu chứng bất thường, cách xử trí những vấn đề có thể xảy ra. Tuy vậy hiện công tác tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại khoa Huyết học - bệnh viện Chợ Rẫy chưa được quan tâm đúng mức. Các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe chưa được tổ chức riêng biệt và thường xuyên mà còn lồng ghép vào trong các buổi họp Hội đồng người bệnh nên có quỹ thời gian truyền thông hạn chế. Ngoài ra, chủ đề truyền thông của nặng về hình thức, chủ yếu đề cập đến các vấn đề chung như: nội quy bệnh viện, khoa, phòng; yêu cầu tuân thủ điều trị, uống thuốc theo toa mà chưa được xây dựng riêng theo chủ đề, theo nhóm bệnh lý cụ thể. Nhiều khi người trả lời câu hỏi của người bệnh lại chưa có chuyên môn về vấn đề được hỏi nên trả lời quanh co, mù mờ, thậm chí là thiếu chính xác. Vì vậy, bệnh viện Chợ Rẫy cần cải thiện hoạt động truyền thông cho người bệnh bằng các giải pháp như tăng cường tần suất truyền thông, tổ chức đều đặn và chia ra nhiều chủ đề. Cán bộ điều dưỡng

cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức để dễ dàng chia sẻ với người bệnh/ người nhà khi được hỏi.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, chuyên khoa Dinh dưỡng chịu trách nhiệm về tính toán và cung cấp khẩu phần dinh dưỡng cho người bệnh theo từng bệnh lý khác nhau. Vì vậy, đa số điều dưỡng thiếu quan tâm đến công tác tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh mà cho đó là phần việc của khoa Dinh dưỡng. Điều này dẫn đến tỷ lệ người bệnh hài lòng về việc tư vấn dinh dưỡng hiện thấp nhất trong các chỉ số đánh giá (67,6%). Kết quả này cao hơn nghiên cứu của của Bùi Bích Ngà với 55,3% người bệnh được giải thích hướng dẫn chế độ ăn, thấp hơn trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh 92,5% và nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn với số người bệnh thường xuyên được chăm sóc dinh dưỡng chiếm 84% [1] [20] [24].

Tương tự như vậy, đa số điều dưỡng khoa Huyết học không thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng cho người bệnh vì cho rằng đây là phần việc của khoa Vật lý trị liệu. Trong thực tế, chuyên gia vật lý trị liệu chỉ có thể hỗ trợ người bệnh trong một khoảng thời gian ngắn và cung cấp những yêu cầu/ hướng dẫn cơ bản. Việc theo dõi hàng ngày thường xuyên liên tục, kịp thời sửa chữa lỗi cho người bệnh rất cần được điều dưỡng quan tâm. Bên cạnh đó, khá đông người bệnh phải vào viện nhiều lần nên quen với các liệu pháp điều trị. Với những người bệnh này, điều dưỡng chỉ hướng dẫn sơ sài hoặc không hướng dẫn vì cho rằng người bệnh đã biết. Trong khi đó, nhiều người bệnh chia sẻ rằng họ tự tìm hiểu và được người mắc bệnh giống mình hướng dẫn về cách sinh hoạt, ăn uống, vận động trong khi nằm viện hoặc ra viện. Điều này tiềm ẩm một số rủi ro do thông tin truyền miệng có thể tồn tại nhiều sai sót; một số liệu pháp chỉ phù hợp với một bệnh nhân cụ thể mà có thể không phù hợp với người khác dù mắc bệnh giống nhau.

Có 76,6% số người bệnh được cung cấp thông tin về tình trạng bệnh của mình hàng ngày. Tỷ lệ này tương đồng so với nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý (73,4%) nhưng lại thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh là 89,1% [1] [19].

4.2.5. Sự hài lòng chung của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng

Điểm trung bình hài lòng chung trong nghiên cứu là 108,5 điểm, thấp hơn điểm hài lòng chung tiêu chuẩn là 112. Tỷ lệ NB hài lòng chung về công tác chăm sóc của điều dưỡng chiếm 44,5%, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ hài lòng chung trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh là 93,5% nhưng lại không quá cách biệt so với các nghiên cứu khác: Nguyễn Bích Lưu (51,3%); Nguyễn Thu (59,4%); Nguyễn Ngọc Lý (65%) [1] [19] [22] [46].

Sự khác biệt với kết quả của các tác giả khác phần nào thể hiện những điều kiện thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là một bệnh viện quá tải trầm trọng, luôn có trên 50% số người bệnh phải nằm điều trị dài ngày trên những chiếc băng ca chật chội đặt dọc theo hành lang. Mặc dù tay nghề chuyên môn của cán bộ y tế tại đây có thể được xếp vào nhóm hàng đầu Việt Nam nhưng chỉ điều này thôi rõ ràng là chưa đủ để người bệnh cảm nhận được "sự hài lòng". Vì vậy, hoạt động chăm sóc của điều dưỡng dù đã rất nỗ lực cũng chỉ mới đạt ở mức bình thường, tạm chấp nhận chứ chắc rằng chưa thể gọi là hài lòng.

Nhiều điều dưỡng công tác lâu năm đã chia sẻ rằng nếu bớt đi được những thủ tục hành chính, bớt đi được những công việc không tên nhưng lại tốn nhiều thời gian như đi trình bệnh án, trình hồ sơ cho lãnh đạo ký duyệt, đi đóng dấu hồ sơ, đi gửi mẫu xét nghiệm cho khoa cận lâm sàng vì hoàn toàn có thể giao những việc đó cho hộ lý thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

4.3. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng

4.3.1. Các yếu tố nhân khẩu, xã hội học của người bệnh

Kết quả nghiên cứu cho thấy có một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh với công tác chăm sóc điều dưỡng. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung của người bệnh gồm điều kiện kinh tế hộ gia đình, tình trạng bệnh tật và mức độ thường xuyên phải quay lại khoa để điều trị ($p<0,05$).

Trong đó, những NB thuộc diện hộ nghèo có xu hướng hài lòng cao hơn gấp 1,66 lần so với nhóm NB không thuộc diện hộ nghèo ($p=0,04$). Nhóm NB đang mắc

các bệnh lý ác tính (ung thư máu) hài lòng cao hơn 1,62 lần so với những NB không mắc các bệnh lý ác tính (p=0,04). Nhóm NB có số lần vào khoa điều trị từ 2 lần trở lên hài lòng cao gấp 2,05 lần so với nhóm NB chỉ mới được điều trị tại khoa từ 1 đến 2 lần (p=0,01).

Xét về yếu tố điều kiện kinh tế, tác giả Nguyễn Ngọc Lý cũng chỉ ra rằng nhóm người bệnh thuộc diện hộ nghèo hài lòng nhiều hơn 2,2 lần so với nhóm người bệnh không thuộc diện hộ nghèo. Sự tương đồng giữa hai nghiên cứu cho thấy những người bệnh có điều kiện kinh tế tốt hơn sẽ có yêu cầu, kỳ vọng lớn hơn ở người điều dưỡng.

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu năm 2001 tại bệnh viện Banpong - Thái Lan cho thấy tuổi tác của ĐTNC có liên quan đến sự hài lòng chung (p=0,031) [46]. Nghiên cứu của Nguyễn Bá Anh chỉ ra yếu tố tình trạng hôn nhân ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh với công tác CSĐD; những người bệnh đã kết hôn có tỉ lệ hài lòng về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng là 95,4% cao hơn 2,94 lần so với nhóm còn độc thân (p = 0,007) [1].

Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lý, người bệnh ở nhóm có số lần nhập viện từ 02 lần trở lên có xu hướng hài lòng cao hơn so với những NB nhập viện 01 lần (OR= 2,56; p = 0,008), như vậy là khá tương đồng với nghiên cứu này. Tương tự, kết quả phân tích mối liên quan trong nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu năm 2001 tại bệnh viện Banpong - Thái Lan chỉ rõ sự khác biệt về thời gian nằm viện của người bệnh với sự hài lòng về công tác CSĐD, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p= 0,018 [46]

Mặc dù các nghiên cứu đều thực hiện trên đối tượng là NB về sự hài lòng của họ trên lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, nhưng do điều kiện thực hiện nghiên cứu khác nhau, cỡ mẫu, đối tượng người bệnh khác biệt và công cụ nghiên cứu không đồng nhất dẫn đến sự khác biệt về kết quả nghiên cứu. Vì vậy, cần có những phân tích sâu hơn về từng yếu tố để có thể rút ra kết luận chung.

4.3.2. Phân tích hồi quy Logistic về các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung

Kết quả phân tích mô hình hồi quy logistic cho thấy có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc người bệnh có hài lòng với công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Huyết học hay không là: điều kiện kinh tế hộ gia đình và tình trạng bệnh tật. Trong đó, những người bệnh thuộc diện hộ nghèo có xu hướng hài lòng hơn gấp 1,71 lần so với những NB không thuộc diện hộ nghèo (p=0,039). Nhóm những người bệnh đang mắc các bệnh lý ác tính về huyết học có xu hướng hài lòng hơn gấp 2,01 lần so với những NB mắc các bệnh huyết học thông thường (p=0,014).

Các yếu tố chỉ ra trong mô hình này khác biệt nhiều so với công bố của Nguyễn Ngọc Lý với 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc người bệnh có hài lòng với công tác chăm sóc điều dưỡng hay không là: giới tính, kinh tế hộ gia đình, dân tộc, trình độ học vấn, nơi cư trú.

Một trong những lý do giải thích cho sự khác biệt trên là những người có trình độ học vấn cao sẽ có yêu cầu về chất lượng chăm sóc khắt khe hơn. Còn với những NB có trình độ học vấn thấp, ít tìm hiểu về quyền lợi của mình, nên họ chấp nhận và hài lòng với những dịch vụ mình nhận được. Trong nghiên cứu này, có thể thấy có sự liên kết giữa nghề nghiệp và điều kiện kinh tế. Đối tượng chủ yếu là người lao động, nông dân nên thu nhập thấp, nhiều người sống dưới mức nghèo khổ. Người mắc bệnh về máu thường phải điều trị dài ngày, nhiều đợt trong năm nên thường đã quen với điều kiện sinh hoạt tại khoa cũng như hoạt động chăm sóc của điều dưỡng. Chính vì vậy dễ có thiện cảm với điều dưỡng của khoa và hài lòng với thực trạng hiện tại. Điều này không thường thấy ở nhóm người bệnh mới đến, thường cảm giác mệt mỏi, lạ lẫm và kỳ vọng cao hơn khi mới phải chuyển từ nhà vào viện.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đánh giá về sự hài lòng trên 299 người bệnh ra viện tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 02/2018 đến tháng 6/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

1. Sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng

Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng còn thấp (44,5%). Trong đó, tỷ lệ người bệnh hài lòng về chăm sóc tinh thần của điều dưỡng là 52,2%; thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng là 51,5%; mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng là 53,2%; về tư vấn và giáo dục sức khỏe là 53,8%.

Người bệnh còn phải chờ đợi nhiều khi cần hỗ trợ. Thời gian người bệnh phải chờ để được chăm sóc khoảng dưới 30 phút chiếm 71,9% và có 3,1% số NB phải chờ đợi trên 120 phút.

2. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nội trú

Qua phân tích hồi quy logistic đã xác định được một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh ($p< 0,05$) là: điều kiện kinh tế hộ gia đình (OR=1,71; 95%CI: 1,02-2,85) và tình trạng bệnh tật hiện tại (OR=2,01; 95%CI: 1,15-2,03). Không tìm thấy mối liên quan giữa các đặc điểm nhân khẩu – xã hội học khác của NB với sự hài lòng chung.

Nghiên cứu định tính cho thấy ĐD ý thức rõ nhiệm vụ nâng cao sự hài lòng cho NB nhưng vấn đề quá tải bệnh nhân, khối lượng công việc, đặc biệt là công tác hành chính khiến điều dưỡng không đủ thời gian chăm sóc cho NB một cách toàn diện.

KHUYẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu về thực trạng công tác chăm sóc của điều dưỡng, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:

1. Đối với người bệnh nội trú

Chủ động tham gia sinh hoạt tại các buổi truyền thông, thu nhận thông tin liên quan đến quá trình điều trị, kịp thời phản hồi, trao đổi với cán bộ điều dưỡng phụ trách bệnh phòng để được hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thủ tục.

2. Đối với cán bộ điều dưỡng khoa Huyết học

Thực hiện nghiêm quy định của bệnh viện về chào hỏi, giao tiếp với NB, chăm sóc NB với tinh thần thái độ tích cực.

Rèn luyện tay nghề để thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nhanh chóng, chính xác, góp phần làm giảm thời gian chờ đợi của NB.

Quan tâm, thường xuyên động viên, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, tập vận động cho người bệnh và người nhà để họ có thể tự chăm sóc. Đặc biệt là với những NB mắc bệnh lý ác tính, những NB có điều kiện kinh tế khó khăn.

3. Đối với bệnh viện Chợ Rẫy

Sớm bổ sung thêm cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, chuyển trả điều dưỡng về làm công tác chăm sóc NB.

Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, giao lưu để cập nhật kiến thức, kỹ năng giao tiếp hàng ngày cho nhân viên y tế.

Định kỳ hàng tuần tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh nội trú, đặc biệt là người bệnh mới bằng nhiều hình thức khác nhau theo các chủ đề riêng biệt, phong phú để thu hút người bệnh.

Chú trọng công tác đào tạo thêm về các bệnh lý chuyên khoa cho điều dưỡng nhằm tăng khả năng phối hợp với bác sĩ, xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường cho NB.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Bá Anh (2012), *Đánh giá và sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2012*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
2. Bệnh viện Chợ Rẫy (2018), *Công tác xã hội: Nỗ lực nâng cao sự hài lòng của người bệnh*, Tp. Hồ Chí Minh, truy cập ngày 01/02/2018, tại trang web http://choray.vn/Default.aspx?tabid=135&ID=8418.
3. Bệnh viện Chợ Rẫy (2018), *Giới thiệu bệnh viện*, Tp. Hồ Chí Minh, truy cập ngày 06/02/2018, tại trang web http://choray.vn/Default.aspx?tabid=135&ID=5359.
4. Bộ Y tế (1997), Quy chế Bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế), chủ biên.
5. Bộ Y tế (2004), *"Điều dưỡng học và các nguyên lý cơ bản về điều dưỡng", Tài liệu Quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Bộ Y tế (2004), *Tài liệu quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
7. Bộ Y tế (2011), Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 về việc "Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện", chủ biên.
8. Nguyễn Thùy Châu (2014), *Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng qua đánh giá của người bệnh nội trú và các yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2014*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
9. Chính Phủ (2015), Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, chủ biên.
10. Nguyễn Thị Thanh Điều (2007), "*Thực trạng và một số giải pháp về tăng cường công tác điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại Viện chấn thương - chỉnh hình quân đội, Bệnh viện TWQĐ 108 từ 4/2006 đến 6/2007*", *Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ III*, Hà Nội.
11. Nguyễn Thị Hiền (2010), "*Đánh giá bước đầu kết quả chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tại khoa ngoại sản - Bệnh viện Đa khoa Mê Linh năm 2009*", *Hội nghị khoa học điều dưỡng Hà Nội lần thứ II*, Hà Nội.
12. Hội Điều dưỡng (2018), *Điều dưỡng với công tác chăm sóc toàn diện tại Việt Nam*, Hà Nội, truy cập ngày 05/02/2018, tại trang web http://hoidieuduong.org.vn/tin-tuc/dieu-duong-voi-cong-tac-cham-soc-toan-dien-tai-viet-nam-a353.html.
13. Hội Điều dưỡng (2018), *Florence Nightingale - Người phụ nữ sáng lập ngành điều dưỡng thế giới*, Hà Nội, truy cập ngày 05/02/2018, tại trang web http://hoidieuduong.org.vn/tin-tuc/florence-nightingale-nguoi-phu-nu-sang-lap-nganh-dieu-duong-the-gioi-a646.html.
14. Hội Điều dưỡng (2018), *Lịch sử hình thành Hội điều dưỡng Việt Nam*, Hà Nội, truy cập ngày 06/02/2018, tại trang web http://hoidieuduong.org.vn/tin-tuc/lich-su-hinh-thanh-hoi-dieu-duong-viet-nam-a116.html.
15. Trần Quang Huy (2009), "*Chăm sóc toàn diện người bệnh theo mô hình đội tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động*", *Hội nghị khoa học điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức lần thứ II*, Hà Nội tr. 36-44.
16. Khoa Huyết học - BV Chợ Rẫy (2018), Quy chế tổ chức và hoạt động khoa Huyết Học - Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ biên, Tp. Hồ Chí Minh.
17. Lê Hùng Lâm (2001), *Bệnh viện và chăm sóc sức khỏe ban đầu*, Nhà xuất bản Y học.
18. Nguyễn Thị Linh (2007), "*Đánh giá kỹ năng giao tiếp trong điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, năm 2006*", *Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học Điều dưỡng*, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, tr. 176-180.

19. Nguyễn Ngọc Lý (2013), *Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, năm 2013*, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.
20. Bùi Thị Bích Ngà (2011), *Thực trạng công tác chăm sóc của Điều dưỡng qua nhận xét của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, năm 2011*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
21. Nguyễn Đức Thành (2006), *Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các Bệnh viên tỉnh Hòa Bình*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
22. Nguyễn Thu (2011), *Đánh giá sự hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
23. Trần Thu Thủy (2001), *Khái niệm về quản lý và quản lý bệnh viện*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
24. Phạm Anh Tuấn (2011), *Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 2011*, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
25. Younas Ahtisham và Sommer Jacoline (2015), "Integrating nursing theory and process into practice; Virginia's Henderson need theory ", *International Journal of Caring Sciences*, 8(2), tr. 443-450.
26. Mehrnoosh Akhtari-Zavare (2010), "Patient satisfaction: evaluating nursing care for patients hospitalized with cancer in Tehran teaching hospitals, Iran", *Global Journal of Health Science*, 2(1).
27. Jafar Alasad, Nazih Abu Tabar và Mohannad Eid AbuRuz (2015), "Patient satisfaction with nursing care: Measuring outcomes in an international setting", *The journal of nursing administration*, 45(11), tr. 563-568.
28. Mark Avis, Meg Bond và Antony Arthur (1995), "Satisfying solutions? A review of some unresolved issues in the measurement of patient satisfaction", *Journal of Advanced Nursing*, 22(2), tr. 316-322.
29. V. Bankauskaite và O. Saarelma (2003), "Why are people dissatisfied with medical care services in Lithuania? A qualitative study using responses to open-ended questions", *Int J Qual Health Care*, 15(1), tr. 23-29.
30. MC. Beach và J. Sugarman (2005), "Do patients treated with dignity report higher satisfaction, adherence, and receipt of preventive care?", *Ann Fam Med*, 3(4), tr. 331-338.
31. JK. Burke (2003), "Dissatisfaction with medical care among women with HIV: dimensions and associated factors", *AIDS Care*, 15(4), tr. 451-462.
32. E. Carretta và các cộng sự. (2017), "Looking Through the Patients' Eyes: Measuring Patient Satisfaction in a Public Hospital", *J Patient Exp*, 4(3), tr. 121-128.
33. Denis Doherty (2003), Measurement of patient satisfaction guidelines: health strategy implementation project 2003 chủ biên, The Health Boards Executive, Tullamore - Ireland.
34. Avedis Donabedian (2005), "Evaluating the quality of medical care", *The Milbank Quarterly*, 83(4), tr. 691-729.
35. U. Eriksson và M. Svedlund (2007), "Struggling for confirmation--patients' experiences of dissatisfaction with hospital care", *J Clin Nurs.* , 16(3), tr. 438-446.
36. Health Services Advisory Group (2018), *CAHPS Hospital Servey*, USA, truy cập ngày 03/10/2018, tại trang web https://www.hcahpsonline.org/.
37. SL. Heiner, BM. Jennings và LA. Loan (2005), "What really matters to healthcare consumers", *J Nurs Adm.*, 35(4), tr. 173-180.
38. P. Johansson và M. Oléni (2002), "Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study", *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 16(4), tr. 337-344.

39. Nathorst-Boos Jorgen (2001), "An evaluation of the QSP and the QPP: two methods for measuring patient satisfaction", *Int J Qual Health Care*, 13(3), tr. 257-264.
40. Wipada Kunaviktikul (2005), "Development of indicator to assess the quality of nursing care in Thai Lan", *Nursing and Health Sciences*, 7(4), tr. 273-280.
41. Cox Cheryl L. (1982), "An interaction model of client health behavior: theoretical prescription for nursing", *Advances in Nursing Science*, 5(1), tr. 41-56.
42. Heather Spence Laschinger (2005), "A psychometric analysis of the patient satisfaction with nursing care quality questionnaire. An actionable approach to measuring patient satisfaction ", *Journal of Nursing Care Quality*, 20(3), tr. 220-230.
43. Nguyen Thi Phi Linh (2002), "Factors determining inpatient satisfaction with care", *Social Science & Medicine Journal*, 54(4), tr. 493-504.
44. JE. Liu, E. Mok và T. Wong (2006), "Caring in nursing: investigating the meaning of caring from the perspective of cancer patients in Beijing, China", *J Clin Nurs*, 15(2), tr. 188-196.
45. Yilan Liu và Guilan Wang (2007), "Inpatient satisfaction with nursing care and factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China", *Journal of Nursing Care Quality*, 22(3), tr. 266-271.
46. Nguyen Bich Luu (2001), *Factors related to the quality of nursing care services as evaluated by patients discharged from Banpong hospital Ratchaburi province, Thailand*, Mahidol University, Thailand.
47. Steven L. Mcmurtry (2000), "The Client Satisfaction Inventory: Results of an Initial Validation Study", *SAGE Journals*, 10(5).
48. Dragana Milutinović (2012), "The patient satisfaction with nursing care quality: The psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire", *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 26(3), tr. 598-606.
49. M.T Mrayyan (2006), "Jordanian nurse's job satisfaction, patient's satisfaction and quality of nursing care", *International Nursing Review*, 53, tr. 224-230.
50. Charles Normand (2000), "Quality in nursing care: Context, complexity and the role of profession", *Journal of Research in Nursing*, 5(6), tr. 407-415.
51. M. Osterweis và J.R. Howell (1979), "Administering patient satisfaction questionnaires at diverse ambulatory care sites", *The Journal of Ambulatory Care Management*, 2(3), tr. 67-88.
52. I. Schofield (2005), "An exploration of the caring attributes and perceptions of work place change among gerontological nursing staff in England, Scotland and China (Hong Kong)", *Int J Nurs Stud.*, 42(2), tr. 197-209.
53. SS. Starr, MM. Shattell và SP. Thomas (2007), "Take my hand, help me out': mental health service recipients' experience of the therapeutic relationship", *Int J Ment Health Nurs*, 16(4), tr. 274-287.
54. Lois H Thomas và các cộng sự. (1996), "Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care", *Quality in Health Care*, 5, tr. 67-72.
55. I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (2018), *The concept of nursing process. The first stage of nursing process*, Ukraina, truy cập ngày 06/02/2018, tại trang web http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/magistr/lectures_stud/english/first%20year/nursing%20diagnosis/3.%20the%20concept%20of%20nursing%20process.%20the%20first%20stage.htm.
56. J. E. Ware, Jr. và R. D. Hays (1988), "Methods for measuring patient satisfaction with specific medical encounters", *Med Care*, 26(4), tr. 393-402.
57. T. Zborowsky (2014), "The legacy of Florence Nightingale's environmental theory: Nursing research focusing on the impact of healthcare environments", *Health Environments Research & Design journal*, 7(4), tr. 19-34.

Phụ lục 1. Giấy đồng ý tham gia nghiên cứu

Tên nghiên cứu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng khoa Huyết Học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3855 4137

Giới thiệu về nghiên cứu:

Đây là nghiên cứu do Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐHYTCC) phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện nhằm thu thập ý kiến của người bệnh nội trú về hoạt động của điều dưỡng trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Sự tham gia của ông/ bà vào nghiên cứu này sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện hoạt động của điều dưỡng cũng như các bộ phận liên quan tại Khoa Huyết học, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc cho người bệnh nói chung tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ông/ bà, có hơn 300 người bệnh khác tại Khoa Huyết học cũng được mời ngẫu nhiên để tham gia vào nghiên cứu này. Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài khoảng 20 phút.

Sự tham gia là tự nguyện:

Việc tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện, ông/ bà có thể từ chối hoặc dừng tham gia nghiên cứu bất kỳ khi nào.

Trong khi phỏng vấn, nếu ông/ bà thấy có những câu hỏi khó trả lời hoặc không muốn trả lời thì đề nghị ông/ bà không trả lời chứ không nên trả lời một cách thiếu chính xác. Việc trả lời đúng là vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi mong rằng ông/ bà sẽ hợp tác và giúp chúng tôi có được những thông tin chính xác nhất.

Để đảm bảo tính riêng tư, toàn bộ thông tin ông/ bà cung cấp sẽ được chúng tôi tổng hợp cùng với thông tin thu được từ các bệnh nhân khác và không gắn với tên người trả lời, nên sẽ không ai khác biết được ông/ bà đã trả lời cụ thể những gì. Sẽ không có bất kỳ thông tin nào do ông/ bà cung cấp được sử dụng ngoài mục đích nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ liên hệ khi cần thiết:

Nếu ông/ bà muốn biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi gì liên quan đến nghiên cứu, ông/ bà có thể hỏi nghiên cứu viên theo địa chỉ:

NCV. Huỳnh Anh Dũng.

Khoa Huyết Học – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Điện thoại: 090 840 4121.

Ông/ bà đồng ý tham gia trả lời nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh chứ?

☐ Đồng ý **☐Từ chối**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày / / 2018

Chữ kí của người được phỏng vấn

Phụ lục 2: Bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Phần 1: Thông tin cá nhân của người bệnh

Stt	Câu hỏi	Phương án trả lời	
1	Năm sinh	…….	
2	Nơi cư trú	1	Tp. Hồ Chí Minh
		2	Tỉnh thành khác
3	Giới tính	1	Nam
		2	Nữ
4	Dân tộc	1	Kinh
		2	Hoa
		3	Dân tộc khác: …….
5	Trình độ học vấn	1	Không biết chữ
		2	Tiểu học, THCS
		3	THPT, Trung cấp chuyên nghiệp
		4	Cao đẳng, đại học, sau đại học
6	Nghề nghiệp	1	Cán bộ hưu trí
		2	Nông dân
		3	Công nhân, viên chức
		4	Học sinh, sinh viên
		5	Khác:
7	Tình trạng hôn nhân	1	Độc thân
		2	Có gia đình
		3	Ly hôn, ly thân, góa
8	Kinh tế hộ gia đình	1	Hộ nghèo
		2	Hộ không nghèo
9	Được chẩn đoán mắc bệnh gì?	1	Ung thư máu
		2	Ung thư hạch
		3	Xuất huyết giảm tiểu cầu
		4	Các bệnh thiếu máu
		5	Bệnh khác: …….

10	Bảo hiểm y tế (BHYT)	1	Có BHYT
		2	Không có BHYT
11	Loại phòng bệnh	1	Phòng yêu cầu
		2	Phòng bình thường
12	Số ngày nằm viện	…… ngày	
13	Tình trạng người bệnh lúc vào viện	1	Cấp cứu
		2	Không cấp cứu/ Theo lịch hẹn
14	Số lần điều trị nội trú tại bệnh viện Chợ Rẫy trong 12 tháng gần đây.	…… lần	

Phần 2. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng tại khoa Huyết học

Để đo lường sự hài lòng đối với chất lượng phục vụ của điều dưỡng tại Khoa Huyết học - Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi sử dụng thang đo với các mức độ sau:

Nhận định	Điểm	Mức độ biểu cảm
Rất không hài lòng	1 điểm	
Không hài lòng	2 điểm	
Bình thường	3 điểm	
Hài lòng	4 điểm	
Rất hài lòng	5 điểm	

Xin Ông/bà chọn mức độ hài lòng đúng nhất với cảm nhận của ông/bà bằng cách đánh dấu ***(X)*** *hoặc* ***khoanh tròn*** *vào ô số tương ứng.*

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Cảm nhận của Ông/ Bà				
		Rất không HL 1	Không hài lòng 2	Bình thường 3	Hài lòng 4	Rất hài lòng 5
A. Chăm sóc về tinh thần						
A1	Mức độ hài lòng của ông/bà với sự đón tiếp và sắp xếp giường bệnh của điều dưỡng?	1	2	3	4	5
A2	Mức độ hài lòng của ông/bà với việc theo dõi diễn biến, hỏi thăm về tình hình bệnh tật của ông/bà hàng ngày trong thời gian nằm viện?	1	2	3	4	5
A3	Mức độ hài lòng của ông/bà với sự động viên, an ủi, khích lệ tinh thần của điều dưỡng trong thời gian nằm điều trị tại khoa?	1	2	3	4	5
A4	Mức độ hài lòng của ông/bà về mức độ cảm thông, chia sẻ về bệnh tật của điều dưỡng với người bệnh?	1	2	3	4	5
A5	Mức độ hài lòng của ông/bà với sự tôn trọng của điều dưỡng (qua lời nói, thái độ, cử chỉ) trong khi chăm sóc?	1	2	3	4	5
B. Thực hiện hoạt động chăm sóc điều dưỡng						
B1	Mức độ hài lòng của ông bà với hướng dẫn các thủ tục hành chính thủ tục hành chính (viện phí, bảo hiểm…) và trang bị đầy đủ đồ vải khi ông/bà vào khoa điều trị?	1	2	3	4	5
B2	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc điều dưỡng đến và xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường (quá lạnh, quá đau, nôn...) khi được ông/bà thông báo không?	1	2	3	4	5

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Cảm nhận của Ông/ Bà				
		Rất không HL 1	Không hài lòng 2	Bình thường 3	Hài lòng 4	Rất hài lòng 5
B3	Mức độ hài lòng của ông/bà khi điều dưỡng thực hiện các quy trình kỹ thuật: Tiêm thuốc, truyền thuốc, đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, làm xét nghiệm….	1	2	3	4	5
B4	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc điều dưỡng thực hiện công khai thuốc với người bệnh?	1	2	3	4	5
B5	Mức độ hài lòng của anh/chị về thời gian chờ đợi Điều dưỡng (chăm sóc, thực hiện thuốc…)	1	2	3	4	5
	Nếu phải chờ đợi trung bình thời gian chờ đợi của ông bà khoảng bao nhiêu lâu?	☐ 30 phút ☐ Dưới 2 giờ ☐ Trên 2 giờ				
B6	Mức độ hài lòng của ông bà với sự giúp đỡ của điều dưỡng khi thực hiện các hoạt động (vệ sinh thân thể, đại tiểu tiện, hỗ trợ ăn uống, đi lại…) trong bệnh viện?	1	2	3	4	5
B7	Mức độ hài lòng của ông/bà khi được điều dưỡng đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng (chụp X-quang, siêu âm…) trong khi nằm viện?	1	2	3	4	5
B8	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự hỗ trợ giảm đau của điều dưỡng (động viên, theo dõi đau, thực hiện thuốc giảm đau)?	1	2	3	4	5
B9	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự sắp xếp của điều dưỡng khi ông/ bà ra viện?	1	2	3	4	5

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Cảm nhận của Ông/ Bà				
		Rất không HL 1	Không hài lòng 2	Bình thường 3	Hài lòng 4	Rất hài lòng 5
C. Mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng						
C1	Ông/ bà cho biết mức độ hài lòng của mình về việc ĐD chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc với người bệnh?	1	2	3	4	5
C2	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc điều dưỡng gây phiền hà tới người bệnh khi thực hiện chăm sóc?	1	2	3	4	5
C3	Mức độ hài lòng của ông bà về sự hướng dẫn các nội quy khoa phòng, nội quy bệnh viện và quyền lợi của NB?	1	2	3	4	5
C4	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự thân thiện, vui vẻ của điều dưỡng?	1	2	3	4	5
C5	Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ quan tâm, lắng nghe của điều dưỡng khi ông/bà cần?	1	2	3	4	5
C6	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự giải đáp những băn khoăn thắc mắc của điều dưỡng khi ông/bà cần?	1	2	3	4	5
D. Tư vấn và giáo dục sức khỏe						
D1	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự giải thích, hướng dẫn của điều dưỡng đối với chế độ ăn theo bệnh tật ông/bà không?	1	2	3	4	5
D2	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự thông báo và giải thích của điều dưỡng trước khi thực hiện chăm sóc (tiêm, truyền, đặt sonde, lấy máu xét nghiệm…)	1	2	3	4	5

Câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Cảm nhận của Ông/ Bà				
		Rất không HL 1	Không hài lòng 2	Bình thường 3	Hài lòng 4	Rất hài lòng 5
D3	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự giải thích của điều dưỡng đối với mục đích, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc không?	1	2	3	4	5
D4	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc giải thích mục đích của việc làm các xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm máu, Xquang, siêu âm…) của điều dưỡng không?	1	2	3	4	5
D5	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc điều dưỡng cung cấp thông tin tình trạng sức khỏe cho ông/bà hàng ngày không?	1	2	3	4	5
D6	Ông/Bà hài lòng về hướng dẫn và hỗ trợ của điều dưỡng trong việc luyện tập, phục hồi chức năng sớm để phòng biến chứng trong thời gian nằm viện không?	1	2	3	4	5
D7	Mức độ hài lòng của ông/bà về sự hướng dẫn cách chăm sóc sau khi ra viện (cách sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, phòng tái phát, biến chứng, tái khám) của điều dưỡng không?	1	2	3	4	5
D8	Mức độ hài lòng của ông/bà về việc hướng dẫn chế độ sinh hoạt, lao động trong khi điều trị và sau khi ra viện của điều dưỡng không?	1	2	3	4	5

Phụ lục 3. Hướng dẫn phỏng vấn sâu Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học

Đối tượng phỏng vấn sâu: Điều dưỡng trưởng Khoa Huyết học

Phần 1. Giới thiệu

Nói: "Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tên tôi là ....., tôi công tác tại ..... và đây là đồng nghiệp của tôi tên là ..... đang công tác tại ..... Chúng tôi đến đây để tìm hiểu thực trạng chất lượng chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Khoa. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi muốn nghe những ý kiến của ông/bà về chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa như thế nào và cần làm gì để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Các thông tin chúng tôi thu được từ cuộc phỏng vấn này sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu.

Phần 2. Nội dung phỏng vấn

1. Xin ông/bà cho biết chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại khoa thế nào?

2. Ông/bà đánh giá các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng thế nào gồm các nội dung:

2.1. Các chăm sóc tinh thần của điều dưỡng thế nào?

2.2. Thực hiện hoạt động chăm sóc của điều dưỡng:

- Công tác đón tiếp NB (người bệnh) thế nào?
- Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho người bệnh thế nào?
- Công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho người bệnh thế nào?
- Chăm sóc hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người bệnh?
- Chăm sóc vận động?
- Theo dõi đánh giá diễn biến NB trong quá trình điều trị thế nào?
- Kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng?

2.3. Mối quan hệ giữa NB và ĐD?

2.4. Thông tin về tình trạng bệnh và sự giáo dục sức khỏe trong quá trình nằm viện và khi ra viện?

3. Sự hài lòng của NB với các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng thế nào?

4. Hiện tại nhân lực ĐD ở bệnh viện ông/bà như thế nào? Đáp ứng yêu cầu công việc trong bệnh viện như thế nào?

5. Theo ông/bà, ĐD đã thể hiện tính chủ động trong công việc chưa? Thực hiện như thế nào? Việc phối hợp của ĐD với bác sỹ thực hiện như thế nào? Có đáp ứng được yêu cầu điều trị không? Nếu không, tại sao?

6. Nhìn nhận một cách toàn diện, ông/bà đánh giá hoạt động chăm sóc của điều dưỡng đã đáp ứng đến đâu so với mong đợi của người bệnh? Những khó khăn vướng mắc chính là gì?

7. Sự quan tâm, tạo điều kiện của ông/bà đối với công tác điều dưỡng:

- Ông/bà tổ chức cho ĐD học tập nâng cao trình độ tại bệnh viện như thế nào? Mức độ và sự tiếp nhận của ĐDV?
- Ông/bà giám sát, kiểm tra công tác CSNB của ĐD như thế nào?

8. Theo ông/bà, cần làm gì để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng trong bệnh viện?

Xin cám ơn ông/bà.

Người phỏng vấn

Phụ lục 4: Hướng dẫn phỏng vấn sâu Trưởng/ Phó khoa Huyết học

Đối tượng phỏng vấn sâu: Trưởng / Phó khoa Huyết học

Phần 1. Giới thiệu

Nói: "Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tên tôi là ....., tôi công tác tại .....và đây là đồng nghiệp của tôi tên là .....đang công tác tại .....Chúng tôi đến đây để tìm hiểu thực trạng chất lượng chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi muốn nghe những ý kiến của ông/bà về chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa như thế nào và cần làm gì để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Các thông tin chúng tôi thu được từ cuộc phỏng vấn này sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu.

Phần 2. Nội dung phỏng vấn

1. Xin ông/bà đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại khoa hiện nay thế nào?

2. Ông/bà đánh giá các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng thế nào ở từng nội dung sau:

2.1. Các hoạt động chăm sóc hỗ trợ tinh thần của điều dưỡng thế nào?

2.2. Thực hiện hoạt động chăm sóc của ĐD

- Công tác đón tiếp NB (người bệnh) thế nào?
- Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho người bệnh thế nào?
- Công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho người bệnh thế nào?
- Chăm sóc hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người bệnh?
- Chăm sóc vận động?
- Theo dõi đánh giá diễn biến NB trong quá trình điều trị thế nào?
- Kỹ năng thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng?

2.3. Mối quan hệ giữa NB và ĐD?

2.4. Thông tin về tình trạng bệnh và sự giáo dục sức khỏe trong quá trình nằm viện và khi ra viện?

3. Sự hài lòng của NB với các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng thế nào?

4. Hiện tại nhân lực ĐD ở khoa ông/bà như thế nào? Đáp ứng yêu cầu công việc trong khoa như thế nào?

5. Theo ông/bà, ĐD đã chủ động trong công việc chưa? Thực hiện như thế nào? Việc phối hợp của ĐDV với bác sỹ thực hiện như thế nào? Có đáp ứng được yêu cầu điều trị không? Nếu không, tại sao?

6. Nhìn nhận một cách toàn diện, ông/bà đánh giá hoạt động chăm sóc của điều dưỡng đã đáp ứng đến đâu so với mong đợi của người bệnh? Những khó khăn vướng mắc chính là gì?

7. Sự quan tâm, tạo điều kiện của ông/bà đối với công tác điều dưỡng:

- Ông/bà tổ chức cho ĐD học tập nâng cao trình độ tại khoa như thế nào? Mức độ và sự tiếp nhận của ĐDV?
- Ông/bà giám sát, kiểm tra công tác CSNB của ĐD như thế nào?

8. Theo ông/bà, cần làm gì để nâng cao công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng trong bệnh viện?

Xin cám ơn ông/bà.

Người phỏng vấn

Phụ lục 5. Hướng dẫn phỏng vấn sâu điều dưỡng chăm sóc

Đối tượng phỏng vấn sâu: Điều dưỡng chăm sóc

Phần 1. Giới thiệu

Nói: "Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tên tôi là ....., tôi công tác tại ..... và đây là đồng nghiệp của tôi tên là ..... đang công tác tại ..... Chúng tôi đến đây để tìm hiểu thực trạng chất lượng chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện. Trong cuộc phỏng vấn này, chúng tôi muốn nghe những ý kiến của ông/bà về chất lượng chăm sóc người bệnh tại khoa như thế nào và cần làm gì để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Các thông tin chúng tôi thu được từ cuộc phỏng vấn này sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu.

Phần 2. Nội dung phỏng vấn

1. Xin ông/bà cho biết mình đang đảm nhiệm công tác chăm sóc nhóm người bệnh nào tại Khoa?

2. Các nội dung chăm sóc của điều dưỡng sau đây được ông/bà thực hiện ra sao? Gặp thuận lợi hoặc khó khăn gì đối với từng hoạt động?

2.1. Các chăm sóc hỗ trợ tinh thần của điều dưỡng cho NB?

2.2. Thực hiện hoạt động chăm sóc của người điều dưỡng

- Công tác đón tiếp NB (người bệnh)?
- Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho người bệnh?
- Công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho người bệnh?
- Chăm sóc hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người bệnh?
- Chăm sóc vận động và phục hồi chức năng?
- Theo dõi đánh giá diễn biến NB trong quá trình điều trị?
- Thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng?

2.3. Mối quan hệ giữa hàng ngày giữa ông/bà và người bệnh nhìn chung ra sao? Có điều gì đặc biệt so với các chuyên khoa khác?

2.4. Thông tin về tình trạng bệnh và sự giáo dục sức khỏe trong quá trình nằm viện và khi ra viện?

3. Cảm nhận của NB với các hoạt động chăm sóc của ông/ bà thế nào ?

4. Hiện tại nhân lực ĐD ở khoa có đáp ứng đủ yêu cầu công việc chưa? Nếu cần bổ sung thì cụ thể ở vị trí nào?

5. Theo ông (bà), lý do nào ảnh hưởng đến hoạt động CSNB tại khoa?

6. Sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Khoa đối với công tác Điều dưỡng:

- Lãnh đạo khoa đã quan tâm, khuyến khích ông (bà) nâng cao trình độ chuyên môn như thế nào?

- Lãnh đạo đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho ông, bà như thế nào?

7. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác CSNB của Điều dưỡng:

- Ông/bà có dự định học tập nâng cao trình độ không ?

Theo ông/bà, cần làm gì để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng trong bệnh viện?

Xin cám ơn ông/bà.

Người phỏng vấn

Phụ lục 6. Hướng dẫn phỏng vấn sâu người bệnh nội trú

I. Mục đích

- Tìm hiểu thực trạng công tác chăm sóc người bệnh tại khoa.

- Tìm hiểu những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân/yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh.

- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

II. Đối tượng: Người bệnh.

III. Phương tiện: Máy ghi âm, giấy, bút.

IV. Nội dung

1. Tìm hiểu thực trạng chất lượng chăm sóc NB.

1.1. Xin ông/bà đánh giá chung công tác chăm sóc NB của điều dưỡng tại khoa hiện nay như thế nào?

1.2. Ông bà có được điều dưỡng chăm sóc hỗ trợ tinh thần trong quá trình nằm viện không? Sự hỗ trợ đó là gì và có ý nghĩa thế nào đối với ông/ bà?

1.3. Cảm nhận của ông/ bà về các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng sau:

- Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho người bệnh ?
- Công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày cho người bệnh?
- Cấp thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh?
- Chăm sóc vận động và phục hồi chức năng?
- Theo dõi đánh giá diễn biến người bệnh trong quá trình điều trị?
- Việc thực hiện các thao tác, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng ?

1.4. Mối quan hệ giữa ông/ bà và điều dưỡng trong quá trình nằm viện ra sao?

1.5. Ông bà có được thông tin về tình trạng bệnh và sự giáo dục sức khỏe trong quá trình nằm viện và khi ra viện không? Cụ thể đó là những hoạt động thông tin gì và có ý nghĩa thế nào đối với ông/ bà?

1.6. Nhìn nhận một cách toàn diện, ông/bà đánh giá hoạt động chăm sóc của điều dưỡng đã đáp ứng đến đâu so với mong đợi của mình? Những khúc mắc chính là gì?

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc NB

- Theo ông/ bà thì những nguyên nhân hoặc yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng?

3. Những giải pháp nâng cao công tác chăm sóc NB

- Theo ông/ bà cần làm gì để cải thiện công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại bệnh viện?

- Những kiến nghị nếu có của ông/ bà với lãnh đạo khoa Huyết học, lãnh đạo Bệnh viện?

Xin cám ơn ông/bà.

Người phỏng vấn

Phụ lục 7: Biến số nghiên cứu

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu				
1	Tuổi	Tính tuổi dương lịch, lấy 2018 trừ đi năm sinh	Rời rạc	Phỏng vấn
2	Giới	Là giới tính của đối tượng nghiên cứu	Nhị phân	Phỏng vấn
3	Dân tộc	Dân tộc của đối tượng nghiên cứu	Định danh	Phỏng vấn
4	Tình trạng hôn nhân	Là tình trạng hôn nhân hiện tại của ĐTNC.	Định danh	Phỏng vấn
5	Trình độ học vấn	Cấp học cao nhất của đối tượng nghiên cứu đạt được	Thứ bậc	Phỏng vấn
6	Nghề nghiệp	Nghề đem lại thu nhập chính cho ĐTNC.	Định danh	Phỏng vấn
7	Kinh tế hộ gia đình	Là hộ nghèo/hộ không nghèo, theo quyết định 09/2011/QĐ-TT ngày 30/01/2011, Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.	Nhị phân	Phỏng vấn
8	Bệnh chính	Là bệnh được bác sỹ chẩn đoán nhập viện lần này.	Định danh	Phỏng vấn
9	BHYT	Là ĐTNC có/không sử dụng BHYT khi nhập viện	Nhị phân	Phỏng vấn
10	Loại phòng bệnh	Là loại phòng mà ĐTNC nằm điều trị.	Định danh	Phỏng vấn

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
11	Số ngày điều trị	Là tổng số ngày nằm điều trị của ĐTNC (từ lúc nhập viến đến lúc ra viện).	Rời rạc	Phỏng vấn
12	Tình trạng NB khi nhập viện	Là tình trạng bệnh của ĐTNC lúc nhập viện là cấp cứu hay không cấp cứu.	Nhị phân	Phỏng vấn
13	Số lần nằm viện	Là số lần nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong 12 tháng gần đây tính cả lần nhập viện này của ĐTNC.	Rời rạc	Phỏng vấn
2. Sự hài lòng của người bệnh về các chăm sóc tinh thần của ĐD				
14	Hài lòng với sự tiếp đón của điều dưỡng	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với tiếp đón nhiệt tình và xếp giường bệnh ngay khi BN vào khoa điều trị	Thứ bậc	Phỏng vấn
15	Hài lòng với sự theo dõi diến biến, hỏi thăm về tình trạng bệnh tật	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với sự theo dõi diễn biến, thăm hỏi của ĐD hàng ngày trong quá trình điều trị.	Thứ bậc	Phỏng vấn
16	Hài lòng với sự động viên, an ủi, khích lệ tinh thần của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với sự động viên, an ủi, khích lệ tinh thần của điều dưỡng trong thời gian điều trị tại khoa.	Thứ bậc	Phỏng vấn
17	Hài lòng với sự giúp đỡ, hỗ trợ khi cần	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với việc đáp ứng giúp đỡ, hỗ trợ khi NB cần của ĐD.	Thứ bậc	Phỏng vấn
18	Hài lòng với sự tôn trọng	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với thái độ tôn trọng của ĐD	Thứ bậc	Phỏng vấn

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
		(qua thái độ, cử chỉ) trong thời gian điều trị.		
3. Sự hài lòng của NB về thực hiện hoạt động chăm sóc của ĐD				
19	Hài lòng với hướng dẫn các thủ tục hành chính	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với việc hướng dẫn các thủ tục hành chính (viện phí, bảo hiểm…) của điều dưỡng	Thứ bậc	Phỏng vấn
20	Hài lòng với sự xử trí kịp thời các dấu hiệu bất thường của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng với việc đáp ứng, xử trí kịp thời của ĐD khi được NB thông báo.	Thứ bậc	Phỏng vấn
21	Hài lòng với việc thực hiện các quy trình kỹ thuật	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi ĐD thực hiện các quy trình kỹ thuật (tiêm, truyền, đo mạch, nhiệt, huyết áp…)	Thứ bậc	Phỏng vấn
22	Hài lòng với thời gian chờ đợi ĐD chăm sóc	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình về thời gian chờ đợi ĐD chăm sóc.	Thứ bậc	Phỏng vấn
23	Hài lòng với sự giúp đỡ của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi ĐD giúp đỡ thực hiện các hoạt động (vệ sinh, ăn uống…)	Thứ bậc	Phỏng vấn
24	Hài lòng khi được ĐD đưa đi làm các xét nghiệm	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi được ĐD đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng (Xquang, siêu âm…)	Thứ bậc	Phỏng vấn

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
25	Hài lòng về sự sắp xếp khi ra viện	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi với sự sắp xếp của ĐD khi ra viện	Thứ bậc	Phỏng vấn
4. Sự hài lòng của NB về mối quan hệ giữa NB và ĐD				
26	Hài lòng với việc ĐD chào hỏi và tự giới thiệu mỗi khi tiếp xúc	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi ĐD chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc với NB	Thứ bậc	Phỏng vấn
27	Hài lòng với sự hướng dẫn nội quy của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi ĐD hướng dẫn nội quy khoa phòng, bệnh viện và quyền lợi cho NB	Thứ bậc	Phỏng vấn
28	Hài lòng với sự thân thiện của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với sự thân thiện của ĐD (nụ cười, vui vẻ)	Thứ bậc	Phỏng vấn
29	Hài lòng với thái độ quan tâm, lắng nghe của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình khi ĐD chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân mỗi khi tiếp xúc với NB	Thứ bậc	Phỏng vấn
30	Hài lòng với sự giải đáp những thắc mắc của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với việc ĐD giải đáp những thắc mắc, băn khoăn khi NB cần	Thứ bậc	Phỏng vấn
5. Sự hài lòng của NB về tư vấn và GDSK của ĐD				
31	Hài lòng với thông tin về chế	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với thông tin về chế độ ăn,	Thứ bậc	Phỏng vấn

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
	độ điều trị trong thời gian điều trị tại khoa của ĐD	sử dụng thuốc, làm xét nghiệm, chế độ luyện tập vận động của ĐD cho NB trong thời gian điều trị tại khoa.		
32	Hài lòng với thông tin về tình trạng bệnh hàng ngày	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với việc ĐD cung cấp những thông tin về tình trạng bệnh hàng ngày.	Thứ bậc	Phỏng vấn
33	Hài lòng với sự thông báo của ĐD trước khi thực hiện chăm sóc	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với sự thông báo, giải thích của ĐD trước khi thực hiện hoạt động CSĐD.	Thức bậc	Phỏng vấn
34	Hài lòng của NB với hướng dẫn chăm sóc sau khi ra viện của ĐD	Là nhận xét của NB về mức độ hài lòng của mình đối với việc hướng dẫn chăm sóc sau khi ra viện (chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, lao động, sử dụng thuốc, tập luyện, phòng tái phát, biến chứng, tái khám) của ĐD	Thứ bậc	Phỏng vấn
6. Thông tin về nhân lực điều dưỡng chăm sóc NB tại Khoa				
35	Tuổi	Tính tuổi dương lịch, lấy 2018 trừ đi năm sinh	Rời rạc	Số liệu thức cấp
36	Giới	Là giới tính của ĐD đang làm việc tại Khoa	Định danh	Số liệu thứ cấp
37	Dân tộc	Dân tộc của điều dưỡng đang làm việc tại khoa	Định danh	Số liệu thứ cấp
38	Tình trạng hôn	Là tình trạng hôn nhân hiện tại của ĐD	Định	Số liệu

STT	Tên biến	Định nghĩa	Phân loại biến	Phương pháp TTTT
	nhân	đang làm việc tại Khoa	danh	thứ cấp
39	Số con hiện có	Tổng số con hiện có của các ĐD đã kết hôn đang làm việc tại Khoa	Thứ cấp	Số liệu thứ cấp
40	Nhân lực	Là số nhân lực tại Khoa Huyết học được đáp ứng đủ theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 về việc.	Rời rạc	Số liệu thứ cấp
41	Tổng số điều dưỡng viên.	Số lượng các điều dưỡng làm việc tại Khoa Huyết học năm 2018.	Rời rạc	Số liệu thứ cấp
42	Tổng số điều dưỡng có trình độ cao đẳng, đại học	Tổng số điều dưỡng có trình độ cao đẳng, đại học làm việc tại Khoa Huyết học năm 2018.	Thứ bậc	Số liệu thứ cấp
43	Thời gian công tác	Là số năm công tác của ĐD tình từ thời điểm kí hợp đồng làm việc tại bệnh viện	Rời rạc	Số liệu thứ cấp
44	Số giường bệnh	Là số lượng các giường bệnh của tại Khoa Huyết học năm 2018.	Liên tục	Số liệu thứ cấp
45	Sự quan tâm, động viện khuyến khích	Là sự quan tâm, động viên khuyến khích của lãnh đạo khoa và bệnh viện đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng.	Phân loại	Phỏng vấn sâu
46	Sự kiểm tra giám sát	Là sự kiểm tra giám sát của lãnh đạo khoa và các điều dưỡng trưỡng đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng	Phân loại	Phỏng vấn sâu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

CÁC GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG/LUẬN VĂN/LUẬN ÁN/CHUYÊN ĐỀ LUẬN ÁN

Họ tên học viên: HUỲNH ANH DŨNG

Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Huyết học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

TT	**Nội dung góp ý** **(***Liệt kê các nội dung góp ý theo thứ tự các phần của đề cương/luận văn/luận án/chuyên đề)*	**Phần giải trình của học viên** *(Nêu rõ đã chỉnh sửa như thế nào, ở phần nào, trang bao nhiêu. Nếu không chỉnh sửa,giải thích lý do vì sao không chỉnh sửa)*
1	Định hướng chuyên ngành của luận văn/luận án	
	……	
2	Tên đề tài luận văn/luận án/chuyên đề	
	….	
3	Tóm tắt	
	….	
4	Đặt vấn đề	
	…	
5	Mục tiêu nghiên cứu	
	…	
6	Khung lý thuyết/cây vấn đề	
	…	
7	Đối tượng và phương pháp	

	nghiên cứu	
	…	
8	Kết quả nghiên cứu	
	…	
9	Bàn luận	
	…	
10	Kết luận	
	…	
11	Khuyến nghị	
	…	
12	Tài liệu tham khảo	
	…	
13	Công cụ nghiên cứu	
	…	
14	Các góp ý khác	
	…	

Lưu ý:

- Có dòng kẻ giữa từng góp ý và phần giải trình thẳng hàng với góp ý.
- Học viên/NCS giải trình theo thứ tự từng phần (***nếu có***) của đề cương/luận văn/luận án/chuyên đề, không nêu tên hoặc chức danh của người góp ý.
- Đối với bản giải trình Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở cần có thêm xác nhận của các phản biện và chủ tịch hội đồng
- Đối với bản giải trình Hội đồng luận án cấp trường, cần có thêm xác nhận của chủ tịch hội đồng.

Ngày tháng năm

Học viên

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của GV hướng dẫn 1	Xác nhận của GV hướng dẫn 2 (nếu có)	Xác nhận của GV hỗ trợ (nếu có)
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*	*(ký và ghi rõ họ tên)*

Ý kiến của thành viên HĐ/chủ tịch HĐ *(Nếu được phân công)*:

……..……

……..……

Ngày tháng năm

Đại diện hội đồng

(ký và ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA
CÁC KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG SAU BẢO VỆ LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

Họ và tên học viên: HUỲNH ANH DŨNG

Tên luận văn/luận án: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại khoa Huyết học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018.

Sau khi nghiên cứu và tiếp thu các kết luận của Hội đồng chấm luận văn/luận án, học viên xin được giải trình việc chỉnh sửa theo các kết luận đó như sau:

TT	**Các kết luận của Hội đồng**	**Nội dung đã chỉnh sửa** *(Mô tả chi tiết, ghi rõ số trang)*	**Nội dung không chỉnh sửa** *(Lý do không chỉnh sửa)*
1.	Nên có tóm tắt trong 1 trang.	Học viên (HV) đã rút gọn tóm tắt trong 1 trang. (Trang viii)	
2.	Phần đầu đặt vấn đề cần viết gọn lại. Nên nói ngay trong đặt vấn đề xem có điểm gì độc đáo ở luận văn này.	HV viết gọn phần đầu của đặt vấn đề và đã bổ sung về điểm mới của luận văn này (Trang 1)	
3.	Tên đề tài và mục tiêu: cân nhắc khi dùng từ "đánh giá" và mục tiêu chỉ nên để mô tả vì yêu cầu không bắt buộc phải là "đánh giá".	HV xin giữ nguyên tên đề tài nhưng thay đổi mục tiêu 1 từ "đánh giá" thành "mô tả" sự hài lòng. (Trang 3)	
4.	Tổng quan tài liệu đã bổ sung thang đo tốt, cần chỉnh sửa theo 3 điểm: thang đo đó có biến số nào, ưu nhược điểm gì. Trong tổng quan nên tránh liệt kê mà cần phân tích theo từng nhóm sự hài lòng để có thể so sánh tốt hơn. Không sử dụng văn nói (từ "biến") trong luận văn. Sửa lỗi chính tả.	HV đã bổ sung nhận định về các thang đo sự hài lòng về công tác chăm sóc điều dưỡng thường dùng. (Trang 14). HV đã chỉnh sửa tổng quan về các kết quả nghiên cứu theo từng nhóm sự hài lòng. HV đã chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi dùng từ trong toàn luận văn.	
5.	Bộ công cụ HV phát triển từ ai, đã chuẩn hoá chưa. Tại sao không sử dụng bộ công cụ đánh giá của Bộ Y tế?	Bộ công cụ được tham khảo từ nghiên cứu tại BV Việt Đức. Các câu hỏi được xây dựng dựa theo Quy định về chức năng nhiệm vụ của cán bộ điều dưỡng. Bộ công cụ được phỏng vấn thử và chỉnh sửa từ	

		ngữ trước khi thu thập dữ liệu.	
6.	HV hơi lạm dụng định tính nhưng chưa phân tích được hết sự đóng góp của định tính vào mục tiêu nghiên cứu.	HV đã rút gọn những kết quả định tính trình bày dài dòng, tập trung kết quả định tính theo các mục tiêu.	
7.	Tại sao lại đưa ra khuyến nghị tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh, tăng cường nhân viên hành chính. Xuất phát từ kết quả nào?	HV đưa ra khuyến nghị cần tăng cường tư vấn dinh dưỡng dựa trên kết quả hài lòng về hoạt động này là thấp nhất trong nhóm tư vấn và giáo dục sức khoẻ. Dựa trên kết quả định tính cho thấy nhân lực điều dưỡng đang dành nhiều thời gian cho công tác giải quyết thủ tục hành chính, vì vậy HV có kiến nghị tăng nhân viên hành chính hỗ trợ cho điều dưỡng.	

(Lưu ý: Học viên cần giải trình lần lượt từng kết luận và nên sắp xếp theo thứ tự các mục của luận văn/luận án)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Học viên

(ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Anh Dũng

Xác nhận của
GV hướng dẫn 1
(ký và ghi rõ họ tên)

TS.BS TRẦN THANH TÙNG

Xác nhận của
GV hỗ trợ
(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. LÊ BÍCH NGỌC

Xác nhận của
Chủ tịch Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN

Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018

Mã số đề tài: 02 *(Ghi ở góc trên bên phải quyển LV)*

1. Tóm tắt đề tài nghiên cứu

1.1. Nhận xét

Đã có câu hỏi nghiên cứu, một số nội dung cơ bản. Tóm tắt cần chỉnh sửa.

1.2. Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có):

Cần nêu rõ phương pháp chọn mẫu 299 và 13 đối tượng phỏng vấn định tính. Nêu rõ các biến số chính và chủ đề nghiên cứu. Nêu rõ phân tích định tính, các biến số chính,

Báo cáo kết quả về mối liên quan (con số thống kê) trong phần kết quả của tóm tắt học viên đã chỉnh sửa trong tóm tắt.

Học viên đã bổ sung câu hỏi nghiên cứu và chỉnh sửa theo góp ý. Khuyến nghị về cần cải thiện kỹ năng giao tiếp và trau dồi chuyên môn là rất chung chung, cần sửa lại để phù hợp với kết quả nghiên cứu. Chú ý khuyến nghị từ kết quả định tính.

2. Tên đề tài nghiên cứu

2.1 Nhận xét

Tên đề tài phù hợp. Đề tài về sự hài lòng đã được thực hiện nhiều tại CSYT tuy nhiên với đơn vị Khoa huyết học vẫn là cần thiết.

2.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có):

3. Đặt vấn đề

Đặt vấn đề phù hợp. Tuy nhiên phần đầu cần viết gọn lại, nêu rõ các lý do chính cần đánh giá sự hài lòng về điều dưỡng trong bệnh viện/khoa huyết học.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1 Nhận xét: Mục tiêu phù hợp với luận văn thạc sĩ. Mục tiêu 1: Thực trạng và mục tiêu 2: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng

3.2 Những điểm cần tiếp tục chỉnh sửa (nếu có):

4. Tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu chưa nêu được các điểm chính. Cần chỉnh sửa: Bỏ phần 1.1.1. Khái niệm về bệnh viện trang 4 không cần thiết.

Đã nêu được khai niệm về sự hài lòng và sự hài lòng trong nghiên cứu trang 5. Phần 1.1.5 cần nêu rõ sự hài lòng điều dưỡng gồm những nội dung cụ thể gì., trang 6.

Phần 1.2.2 trang 6 7 8 các học thuyết cơ bản về điều dưỡng cần viết gọn lại, nếu có thì cần nêu rõ các học thuyết đó nói gì (nguyên lý…) về sự hài lòng của người bệnh với công tác điều dưỡng.

Phần trang 9 10 11 12 13 về qui trình điều dưỡng cần viết gọn lại 1 trang.

Phần 1.4.2 trang 13 là phần quan trọng trong tổng quan lại làm quá sơ sài: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh qua các thang đo cần chỉ ra một số thang đo cơ bản, nội dung thang đo, cách đánh giá và ưu nhược điểm, học viên cần tổng hợp và phân tích phần này để có thể có lý giải cho việc sử dụng thang đo về sự hài lòng trong nghiên cứu. Cần viết lại phần này.

Học viên đã bổ sung các thang đo khác nhau, ví dụ thang đo Bộ công cụ MISS, PSS, NSNS, HCAHPS: học viên mô tả tuy nhiên cần nêu rõ ưu , nhược điểm, phạm vi áp dụng và giải thích các bộ công cụ với điều dưỡng được xây dựng như thế nào (mô hình cox): liên quan đến: Chăm sóc thinh thần, thực hiện chuyên môn kĩ thuật, mối quan hệ giữa người bệnh và điều dưỡng, tư vấn giáo dục sk.

Phần 1.4.3 liên quan đến mục tiêu 2 của nghiên cứu chưa biết tổng hợp, chỉ liệt kê các nghiên cứu. Nội dung chính của nghiên cứu trong trang 15 cần nêu rõ các trích dẫn từ y văn để làm cơ sở cho việc đánh giá nội dung chăm sóc tinh thần, kĩ năng chuyên môn, thông tin về tình trạng bệnh và giáo dục sức khỏe,... Vậy các nội dung này được lấy từ đâu và tại sao? Cần giải thích rõ và bổ sung trích dẫn.

Luận văn rõ ràng, phù hợp với khóa đào tạo QLBV; Học viên cần cho biết sự hài lòng về điều dưỡng có gì khác so với sự hài lòng của đối tượng khác?

Học viên đã cố gắng chỉnh sửa, kết quả và khuyến nghị cần rõ thêm nhằm làm cho điều dưỡng chăm sóc tốt hơn

Tổng quan tài liệu học viên đã bổ sung thang đo tốt, cần chỉnh sửa theo 3 điểm: thang đo đó có những biến số nào? Ưu nhược điểm là gì?

Trong phần tổng quan nên chỉnh sửa để tránh tình trạng chỉ liệt kê mà cần phân tích theo từng nhóm sự hài lòng để có thể so sánh tốt hơn

Tên đề tài và mục tiêu: Phần định lượng chủ yếu là mô tả nên tên đề tài rất cân nhắc khi dùng từ "đánh giá" và mục tiêu chỉ nên để mô tả vì yêu cầu không bắt buộc phải là "đánh giá"

Trích dẫn không nên chỉ ra quá cụ thể con người vì không đảm bảo bí mật thông tin

4.2 Ý kiến Phản biện 2*(Có bản nhận xét kèm theo)*:

Chủ đề rất nhiều học viên đã làm,

Nên có tóm tắt trong 1 trang

Đã nêu được bối cảnh và vai trò của điều dưỡng,

Tổng quan tài liệu: Đã chỉnh sửa được tổng quan về sự hài lòng của người bệnh về công tác điều dưỡng, xem xét để không bị trùng lắp từ phần khái niệm và phần nội dung sau.

HV hơi lạm dụng định tính nhưng chưa phân tích được hết sự đóng góp của định tính và mục tiêu nghiên cứu,

Bộ công cụ HV phát triển từ ai? Đã chuẩn hóa chưa? Tại sao không sử dụng bộ công cụ đánh giá của BYT mà sử dụng của nước ngoài

4.3 Ý kiến Ủy viên :

Chọn đề tài này ít độc đáo và khó tạo được giá trị mới, nên nói ngay trong đặt vấn đề xem có điểm gì độc đáo của luận văn này

Tổng quan cần nêu sơ lược về khoa huyết học, sau mỗi phần nêu thì nên có những nhận định chung để xem lần sau mình cần xây dựng công cụ mới hay ntn?

Một số lỗi chính tả cần lưu ý, không nên sử dụng văn nói trong luận văn (từ "biến" – Trang 33)

Phần kết quả nên có sự so sánh nhiều hơn với nghiên cứu khác và nêu lên sự đặc thù của khoa huyết học

Phần kết luận Học viên có nhiều ưu điểm trong trình bày rõ hơn bản viết rất nhiều

Khuyến nghị đưa theo trình tự lần lượt từ kết luận, tránh những kết luận chung chung, nên đưa ra mối liên quan được phiên giải theo ý nghĩa y tế hơn là chỉ thuần túy xử lý và kết luận về mặt thống kê.

4.4 Ý kiến Thư ký:

Bàn luận nhiều chỗ còn dài dòng vì dự trang 58-60 về đối tượng nghiên cứu cần cắt ngắn lại.

Bổ sung Bàn luận về các giải pháp can thiệp dựa trên các kết quả can thiệp từ trước, từ đó có cơ sở cho khuyến nghị.

Bổ sung hạn chế (không phân tích được mục tiêu 2 phần định tính...) bổ sung hạn chế về chưa phân tích sâu được số liệu định tính, chưa nêu được đặc thù của SHL và các yếu tố ảnh hưởng với khoa huyết học.

6 Kết luận

Kết luận mới chỉ tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Kết luận cần viết gọn lại, đưa ra giải pháp cụ thể (dựa trên các bằng chứng can thiệp đã phải phân tích trong phần bàn luận).

Kết luận mục tiêu định lượng cần đưa ra các con số (p, tỉ lệ..) chứ không được kết luận chung chung.

7 Khuyến nghị

Viết lại sau khi đã chỉnh sửa các phần theo góp ý.

10. Nhận xét khác

11. Kết luận: (Thầy cô ghi rõ ý kiến ĐỒNG Ý THÔNG QUA CÓ CHỈNH SỬA hay KHÔNG ĐỒNG Ý THÔNG QUA)

Đồng ý thông qua

Người nhận xét

PGS.TS. Hồ Thị Hiền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ VÀ CHUYÊN KHOA II

(Dành cho Dành cho Ủy viên Phản biện Hội đồng luận văn ThS và CKII)

Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về sự chăm sóc của điều dưỡng tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018

Họ và tên học viên: .....

Mã số đề tài:02 (Ghi ở góc trên bên phải quyển LV)

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2018

1. Đề tài có đúng định hướng và mã số chuyên ngành (*ThS YTCC định hướng nghiên cứu/ ThS YTCC định hướng ứng dụng/ ThS QLBV/ CKII TCQLYT*)

Nghiên cứu trên đối tượng người bệnh về sự hài lòng của đối với điều dưỡng là nhân viên bệnh viện. Đề tài hoàn toàn đúng định hướng quản lý bệnh viện và ở mức độ thạc sĩ.

2. Tên đề tài nghiên cứu:

1.1. Nhận xét: Tên đầy đủ động từ, nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu

1.2. Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

.....

.....

.....

3. Tóm tắt nghiên cứu:

1.3. Nhận xét: Đã tóm tắt được bối cảnh cần nghiên cứu, tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và khuyến nghị.

1.4. Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): Tuy nhiên, nếu tóm tắt nghiên cứu nếu được cô đọng lại trong 1 trang sẽ phù hợp format.

4. Phần đặt vấn đề:

1.5. Nhận xét: Đã nếu được bối cảnh cần được nghiên cứu từ nhu cầu cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, đến sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế, đến vài trò của điều dưỡng, các quy định đối với điều dưỡng, đến khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy, câu hỏi nghiên cứu và đến sự cần thiết tiến hành đề tài.

1.6. Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

.....
.....
.....
.....
.....

5. Mục tiêu nghiên cứu:

2.1 Nhận xét: Hai mục tiêu rõ ràng, phù hợp với mức độ của một luận văn thạc sĩ.

2.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....
.....
.....
.....

3. Tổng quan tài liệu:

3.1 Nhận xét (*Cấu trúc và nội dung của tổng quan tài liệu có phù hợp tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu không, tài liệu tham khảo cập nhật và trích dẫn đúng, các góp ý khác (nếu có)* :

Tác giả đã tổng quan được các nội dung trong đề tài: khái niệm bệnh viện, chăm sóc điều dưỡng, sự hài lòng của người bệnh, sự hài lòng của người bệnh về công tác điều dưỡng, các học thuyết và nguyên lý cơ bản về chăm sóc điều dưỡng, quy trình, chức năng điều dưỡng, sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc điều dưỡng (trùng với 1.1.5), một số bộ công cụ đánh giá, các yếu tố liên quan, một số nghiên cứu từ y văn thế giới và Việt Nam, Khoa huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, khung lý thuyết

3.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): Nên gộp các khái niệm và mục viết về viết vấn đề đó

4. **Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:**

4.1 Nhận xét *(Đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu? Cỡ mẫu, chọn mẫu phù hợp và khả thi không? Biến số/nội dung nghiên cứu phù hợp với mục tiêu, đúng định hướng và phù hợp với mã ngành không? Phương pháp thu thập số liệu rõ ràng, khả thi và phù hợp với nội dung nghiên cứu? Phương pháp phân tích số liệu, và đạo đức nghiên cứu được viết phù hợp? Các nhận xét khác (nếu có)*:

Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân nội trú tại Khoa huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, có tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ. Thời gian và địa điểm nghiên cứu rõ ràng. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang, định tính kết hợp với định lượng.

Câu hỏi: Học viên làm rõ nghiên cứu định tính để làm gì? Và đáp ứng mục tiêu nào?

Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi đã từng được dùng tại Bệnh viện Việt Đức bởi Nguyễn Bá Anh.

Câu hỏi: Học viên làm rõ bộ câu hỏi này? Dịch từ một bộ câu hỏi đã sử dụng đâu đó trên thế giới? do một tác giả Việt Nam tự phát triển? đã được chuẩn hóa chưa? Việc miền nam hóa văn phong thế nào?

4.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

5. **Kết quả nghiên cứu:**

5.1 Nhận xét (*Kết quả nghiên cứu có đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu không? có phù hợp với định hướng và mũi nhọn không? Kết quả nghiên cứu trình bày có rõ ràng và theo mục tiêu nghiên cứu không? có sử dụng các phương pháp phân tích phù hợp và đảm bảo độ tin cậy không?*):

Kết quả nghiên cứu trình bày đẹp, theo mục tiêu nghiên cứu.

5.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

6. Bàn luận:

Nhận xét (*cấu trúc và nội dung của bàn luận có phù hợp với mục tiêu và kết quả nghiên cứu không? trích dẫn tài liệu tham khảo có đúng không?*):.....
Đã bàn luận được kết quả nghiên cứu với y văn và theo mục tiêu.

6.1 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

.....

7. Kết luận:

7.1 Nhận xét (*có khái quát được các kết quả chính và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu không*) : Đã khái quát được các kết quả chính và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu .

7.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): .....

8. Khuyến nghị:

8.1 Nhận xét (*phù hợp, khả thi và dựa trên kết quả nghiên cứu không?*).....

8.2 Những điểm cần chỉnh sửa (nếu có): Bám sát khuyến nghị trên kết quả nghiên cứu.....

.....

9. KẾT LUẬN: ĐỀ NGHỊ PHẢN BIỆN GHI RÕ: Đồng ý thông qua với điều kiện chỉnh sửa hay Không đồng ý thông qua.

Đồng ý thông qua

NGƯỜI NHẬN XÉT

(ký, ghi rõ họ và tên)

PGS. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt